

הפרעות אישיות

יעדי הלימוד

- 10.1 לתאר את המאפיינים הכלליים של הפרעות אישיות.
- 10.2 לסכם את האתגרים שבעריכת מחקר על הפרעות אישיות.
- 10.3 למנות את שלוש הפרעות האישיות באשכול A ולתאר את המאפיינים הקליניים העיקריים של כל אחת מהן.
- 10.4 לתאר את ארבע הפרעות האישיות באשכול B ולהסביר את המאפיינים המשותפים להן.
- 10.5 למנות את שלוש הפרעות האישיות באשכול C ולתאר את המאפיינים הקליניים העיקריים של כל אחת מהן.
- 10.6 להסביר את התפקידים שגורמים חברתיים-תרבותיים עשויים למלא בתפוצה של הפרעות אישיות.
- 10.7 להסביר את האתגרים בטיפול בהפרעות אישיות ולסכם את הגישות שבהן משתמשים.
- 10.8 לתאר את המאפיינים הקליניים של פסיכופתיה ולהסביר את הדמיון ואת השוני בינה ובין הפרעת אישיות אנטי-חברתית.

כיצד הייתם מתארים את עצמכם? האם אתם יותר מוחצנים או יותר מופנמים? האם אפשר לסמוך עליכם או שאתם בלתי צפויים? האם בעת לחץ אתם רגועים או שמא אתם נלחצים בנקל? תכונותיו האופייניות של אדם, סגנונות ההתמודדות שלו ודרכי האינטראקציה שלו עם סביבתו החברתית מופיעים במהלך הילדות, ובמצב נורמלי מתגבשים לדפוסים קבועים לקראת סוף גיל ההתבגרות או בשנות הבגרות המוקדמות. דפוסים אלה מרכיבים את האישיות של האדם – מערכת תכונות והתנהגויות ייחודיות המאפיינות את הפרט. כיום יש הסכמה רחבה למדי בין חוקרי האישיות שישנם חמישה ממדים של תכונות אישיות בסיסיות היכולים לשמש לאפיון אישיות נורמלית. חמש התכונות המרכזיות במודל חמשת הגורמים של האישיות הן נוירוטיות (אי-יציבות רגשית), מוחצנות / מופנמות, פתיחות להתנסויות (אי-קונבנציונליות), נועם הליכות / אנטגוניזם ותחושת חובה (למשל (Goldberg, 1990; John & Naumann, 2008; McCrae & Costa, 2008).

מאפיינים קליניים של הפרעות אישיות

יעד לימוד 10.1 לתאר את המאפיינים הכלליים של הפרעות אישיות.

כאנשים בוגרים, לרובנו כבר יש אישיות המותאמת לדרישות החברה. במילים אחרות, אנו נענים בקלות לרוב הציפיות של החברה. אנו הולכים לבית הספר או לעבודה, אנו מכבדים את ההתחייבויות הכספיות שלנו, אנו מפתחים מערכות יחסים ומשתדלים לשמר אותן. כמו כן, אנו מודעים למי שאנחנו. לעומת זאת אנשים מסוימים, אף שאינם מציגים תסמינים ברורים של רוב הפרעות הנידונות בספר זה, הם בעלי תכונות נוקשות כל כך ולא הסתגלותיות עד כדי כך שהם אינם מסוגלים לתפקד ביעילות או לענות על הדרישות של החברה. במקרים כאלה, נוכל לומר כי האדם סובל מהפרעת אישיות. ככלל, התכונות המאפיינות את רוב הפרעות האישיות הן קשיים בין-אישיים כרוניים, בעיות של האדם עם זהותו או עם תחושת העצמי שלו ואי-יכולת לתפקד כראוי בחברה (Livesley & Jang, 2000).

הפרעת אישיות (personality disorder)

המקרה שלפניכם ממחיש רבים מהמאפיינים השונים של אדם עם הפרעת אישיות.

הפרעת אישיות נרקיסיסטית

אלאן, בן 25, הוא סטודנט לתואר שני. הוא אינו מהסס לספר לפרופסורים שלו על המוטיבציה שלו ועל ההתרגשות שעבודתו האקדמית מסבה לו, אך רק לעיתים רחוקות הוא טורח לקרוא את החומר הנדרש ומגיש עבודות שאינן הרבה יותר מטיוטות לא גמורות. כאשר הוא מקבל ציונים בינוניים בקורסים שלו, אלאן ממחר להתלונן בפני סטודנטים אחרים שהיחס של המרצים כלפיו אינו הוגן וכי סימנו אותו להטחת ביקורת מיותרת. אין לו ספק שהוא מוכשר הרבה יותר מכפי שציוניו מראים והוא מאשים את מרציו בכך שאינם מכירים בזה. אלאן גם מתמרמר כאשר אומרים לו כיצד הוא יכול לשפר את עבודותיו. בפגישות המשוב עם המרצים הוא אומנם כותב

בפירוט את הנאמר לו ומספר להם עד כמה הוא רוצה להשתפר, אך במציאות כל ניסיון לעזור לו נתפס בעיניו משפיל ומיותר. עמיתיו הסטודנטים מנסים לעזור לו להבין את הסיבות לבעיות, אך אלאן מסרב להכיר באחריות שלו למצבו. במקום זה הוא טוען שמוריו משתמשים באמות מידה נמוכות יותר בהערכת סטודנטים אחרים בקורסים ושזו הסיבה שהם מקבלים ציונים גבוהים יותר ממנו. בסופו של דבר, אלאן מתחיל להפיץ שמועות מרושעות על אחדים מחברי הסגל כדי ש"ישלמו" על שלא התייחסו אליו טוב יותר.

כדי לקבוע אבחנה של הפרעת אישיות, דפוס ההתנהגות הקבוע של האדם צריך להיות נרחב ונוקשה וכן יציב ומתמשך. כמו כן, עליו לגרום מצוקה משמעותית מבחינה קלינית או שיבושים בתפקוד המתבטאים לפחות בשניים מתוך כמה תחומים: קוגניציה, רגשיות, תפקוד בין-אישי ושליטה בדחפים. מנקודת מבט קלינית, אנשים עם הפרעות אישיות גורמים לעיתים קרובות לקשיים בחיי זולתם לפחות כמו בחייהם שלהם. בני אדם נוטים לראות את התנהגותם של אנשים עם הפרעות אישיות כמבלבלת, מרגיזה, בלתי צפויה וגם בלתי מקובלת ברמות שונות. יהיו אשר יהיו דפוסי התכונות שהלוקים בהפרעות אישיות מפתחים (לדוגמה עקשנות, עוינות חבויה, חשדנות או פחד מדחייה), דפוסים אלה צובעים את תגובותיהם לכל מצב חדש ומובילים אותם לחזרה על אותן התנהגויות לא הסתגלותיות שכן הם אינם לומדים משגיאות ומקשיים שבהם התנסו בעבר. לדוגמה, אדם תלתי עשוי להביא לשחיקה של מערכת יחסים עם מישהו כמו בן זוג, בשל דרישות חריגות ובלתי פוסקות כגון הדרישה לא להשאירו לבד אף פעם. אחרי שכן הזוג עוזב, האדם התלתי עשוי להיכנס כמעט מייד למערכת יחסים אחרת, תלתי לא פחות, בלי לבחור את בן הזוג החדש בקפידה.

הפרעות אישיות אינן נובעות בדרך כלל מתגובות לעקה בעבר הקרוב המחלישות את האדם, כמו בהפרעת עקה פוסט-טראומטית או במקרים רבים של דיכאון קשה. הן נובעות בעיקר מהתפתחות הדרגתית של דפוסי אישיות והתנהגות נוקשים ומעוותים היוצרים דרכים מקובעות ולא הסתגלותיות לתפוס את העולם, לחשוב עליו ולהתייחס אליו. עם זאת, אירועים מעוררי עקה בגיל צעיר עשויים להכשיר את הקרקע להתפתחות דפוסי אישיות מעוותים ונוקשים אלה.

קטגוריית הפרעות האישיות היא רחבה והיא כוללת בעיות התנהגות שונות מאוד בצורתן ובחומרתן. במקרים הקלים יותר אנו רואים אנשים שבדרך כלל מתפקדים כהלכה, אך קרוביהם, חברים ומכריהם מתארים אותם כמטרידים, כמשונים או כמי שקשה לעמוד על טיבם. ייתכן כי הם יתקשו לפתח יחסים קרובים עם זולתם או להסתדר עם אלה שיש להם מערכת יחסים קרובה איתם. אחת הצורות החמורות של הפרעת אישיות (הנקראת הפרעת אישיות אנטי-חברתית) באה לידי ביטוי בהתנהגות קיצונית ולעיתים קרובות לא מוסרית כלפי החברה. רבים מהלוקים בהפרעה זו כלואים בבתי סוהר אם כי מקצתם מסוגלים להוליד שולל את זולתם ולא להיתפס.

ב־DSM-5, הפרעות האישיות מקובצות בשלושה אשכולות על בסיס מה שבעבר נחשב לקווי דמיון חשובים של ההפרעות באשכול נתון. **בטבלה 10.1** מוצג סיכום האשכולות:

אשכול A: כולל את הפרעות האישיות פרנואידית, סכיזואידית וסכיזוטיפלית. אנשים עם הפרעות אלה נראים לעיתים קרובות מוזרים או משונים, והתנהגותם הבלתי שגרתית נעה בין חוסר אמון וחשדנות לבין ניתוק חברתי.

אשכול B: כולל את הפרעות האישיות היסטריונית, נרקיסיסטית, אנטי־ חברתית וגבולית. אנשים עם הפרעות אלה נוטים כולם להיות דרמטיים, רגשיים ולא יציבים.

אשכול C: כולל את הפרעות האישיות נמנעת, תלותית וטורדנית־כפייתית. בניגוד לשני האשכולות האחרים, אצל אנשים עם הפרעות אלה רואים לעיתים קרובות חרדה וחששות.

הפרעות אישיות הופיעו לראשונה ב־DSM בשנת 1980 (ב־DSM-III). השימוש באשכולות אומנם נמשך מאז ועד היום, אך המחקר מעלה שאלות רבות בדבר תקפותם. כפי שנראה בהמשך הפרק (ראו מסגרת "סוגיות בלתי פתורות"), ישנן מגבלות בולטות לסיווג לקטגוריות ולאשכולות. אכן, צוות העבודה של DSM-5 בחן בקפידה כמה הצעות שכללו את הוצאתן של ארבע הפרעות אישיות מן המדריך ואת הפסקת השימוש באשכולות לארגון ההפרעות. אחת הסוגיות העיקריות הייתה פשוט ריבוי המאפיינים החופפים גם בין ההפרעות השונות וגם בין האשכולות השונים (Widiger & Mullins-Sweatt, 2005). עם זאת, מאחר שב־DSM-5 עדיין משתמשים באשכולות אלה כמבנה מארגן, גם אנחנו ממשיכים לציין אותם כאן.

טבלה 10.1 סיכום הפרעות האישיות

הפרעת אישיות	מאפיינים	תפוצה נקודתית באוכלוסייה הכללית	אומדן יחס מגדרי
אשכול A			
פרנואידית	חשדנות וחוסר אמון באחרים, נטייה של האדם לראות את עצמו כחף מכל אשמה, קשוב למה שנתפס בעיניו כהתקפה מצד אחרים.	1.5%	גברים = נשים
סכיזואידית	יחסים חברתיים לקויים, חוסר יכולת וחוסר רצון ליצור קשרים עם אחרים.	1.2%	נשים > גברים
סכיזוטיפלית	דפוסי חשיבה מוזרים, מוזרויות בתפיסה ובדיבור המפריעות לתקשורת ולאינטראקציות חברתיות.	1.1%	נשים > גברים

אשכול B		
היסטוריונית	דרמטיזציה עצמית, דאגת יתר למראה החיצוני, נטייה לרגזנות ולהתפרצויות זעם במקרה של תסכול מחיפוש תשומת לב.	1.2% גברים > נשים
נרקיסיסטית	ראוונות, עיסוק במשיכת תשומת לב, קידום עצמי וחוסר אמפתיה.	<1% נשים > גברים
אנטי- חברתית	חוסר התפתחות מוסרית או אתית, חוסר יכולת לאמץ מודלים מוסכמים של התנהגות, חוסר יושר, מניפולציה חסרת בושה של אחרים, היסטוריה של בעיות התנהגות בילדות.	1% נשים 3% גברים
גבולית	אימפולסיביות, כעס שלא במקומו, תנודות קיצוניות במצב הרוח, תחושה מתמדת של שעמום, ניסיונות של חבלה עצמית קשה או התאבדות.	1.4% גברים = נשים
אשכול C		
נמנעת	רגישות יתר לדחייה או לנחיתות חברתית, ביישנות, חוסר ביטחון באינטראקציות חברתיות וביצירת קשרים.	2.5% גברים > נשים
תלותית	קושי בפרידה במערכות יחסים, קושי להיות לבד, שעבוד הצרכים האישיים של האדם כדי להשאיר אחרים במערכת יחסים איתו, חוסר החלטיות.	1% גברים > נשים
טורדנית- כפייתית	עיסוק מוגזם בסדר, בכללים ובפרטים שוליים, שאיפה לשלמות, חוסר הבעות רגש וחוסר, קושי להירגע וליהנות.	2.1% נשים > גברים

מקור: Torgersen (2012).

המספרים הם ממוצעי התפוצה הנקודתית של 11 מחקרים אפידמיולוגיים שונים. שיעורי התפוצה במהלך חיים גבוהים בערך פי שלושה. הפרעות אישיות שכיחות יותר באוכלוסיות קליניות מאשר במדגמי קהילה.

מחקר אפידמיולוגי (epidemiological study)

בשנים האחרונות היו כמה **מחקרים אפידמיולוגיים** שהעריכו את תפוצתן של הפרעות אישיות. חלקם של המחקרים נערכו בארצות הברית ואחרים נערכו באירופה. במחקרים השתמשו לעיתים קרובות בראיונות הערכה שונים. למרות הבדלים אלה, אומדני התפוצה של כלל הפרעות האישיות נוטים להיות דומים להפליא. לפי ממצאי המחקרים, 10% עד 12% מבני האדם עונים על הקריטריונים של הפרעת אישיות אחת לפחות כאשר תקופת הזמן שעליה נשאלו היא התנהגותו

של האדם ב־2 עד 5 השנים הקודמות (Lenzenweger, 2008; Torgersen, 2012). במילים אחרות, אחד מכל עשרה אנשים בקירוב סובל מהפרעת אישיות הניתנת לאבחון. בעיון באשכולות של ה־DSM-5, נראה שההפרעות באשכול C הן השכיחות ביותר, עם תפוצה של כ־7%. אחריהן באות ההפרעות של אשכול A, ותפוצתן היא כ־4%. לבסוף, תפוצת הפרעות האישיות של אשכול B מעט נמוכה יותר, בטווח של 3.5% עד 4% (Torgersen, 2012). בשל התחלואה הנלווית הרבה בין האשכולות, יש אנשים העונים על הקריטריונים של הפרעות אישיות ביותר מאשכול אחד ולכן סכום האחוזים האחרונים שפורטו גבוה מ־10% או 12%.

זרקור על מחקר מחקר אפידמיולוגי



מחקרים אפידמיולוגיים נועדו לקבוע את שיעור תפוצתה מאוד (בדרך כלל אלפי משתתפים) של אנשים החיים (מספר המקרים) של הפרעה מסוימת במדגם גדול בקהילה.

מאז כניסתן של הפרעות האישיות ל־DSM לראשונה ב־1980 ועד DSM-IV-TR הן קודדו על ציר נפרד, ציר II. הסיבה לכך הייתה שהן נחשבו לשונות דיין מתסמונות פסיכיאטריות רגילות (שקודדו על ציר I) ולכן הצדיקו סיווג נפרד. אולם ב־DSM-5 נזנחה המערכת הרב־צירית. כעת הפרעות אישיות נכללות עם שאר ההפרעות שאנו דנים בהן בספר זה. הפרעות אישיות קשורות לעיתים קרובות להפרעות חרדה (או שהן נלוות להן) (פרקים 5 ו־6), להפרעות מצב רוח (פרק 7), לבעיות שימוש בחומרים (פרק 11) ולהפרעות מיניות וקשיים מיניים (פרק 12) (ראו למשל אחד מסיכומי הראיות, ההערכה היא שכשני־שלישים מהאנשים שאובחנה אצלם הפרעת אישיות לוקים גם בהפרעה אחרת (Dolan-Sewell et al., 2001).

שאלות חזרה



- מהי ההגדרה של הפרעת אישיות?
- מהם הקריטריונים הכלליים של DSM-5 לאבחנת הפרעות אישיות?
- מהו אומדן תפוצת הפרעות האישיות באוכלוסייה הכללית?

אתגרים במחקר על הפרעות אישיות

יעד לימוד 10.2 לסכם את האתגרים שבעריכת מחקר על הפרעות אישיות.

לפני שנפנה לדיון בסיבות ובמאפיינים הקליניים של הפרעות אישיות, מן הראוי לציין שישנם כמה היבטים חשובים בעריכת מחקרים בתחום זה שמעכבים את

ההתקדמות, ביחס למה שידוע על הפרעות רבות אחרות. נתאר בקצרה שתי קטגוריות מרכזיות של קשיים.

קשיים באבחון הפרעות אישיות

ראוי להיות זהירים באבחון הפרעות אישיות שכן האבחנות השגויות בקטגוריה זו כנראה רבות מבכל קטגוריה אחרת. יש לכך כמה סיבות. אחת הבעיות היא שהקריטריונים האבחנתיים של הפרעות האישיות אינם מוגדרים באופן חד כמו אלה של רוב קטגוריות האבחנה האחרות ולכן הם אינם מדויקים ואינם קלים ליישום הלכה למעשה. לדוגמה, קשה מאוד לאבחן במהימנות אם אדם עונה על קריטריון נתון להפרעת אישיות תלוית כגון "מרחיק לכת במאמציו לקבל טיפול ותמיכה מאחרים" או "מתקשה לקבל החלטות יום-יומיות בלי מידה מוגזמת של ייעוץ ועידוד מאחרים". מאחר שהקריטריונים להפרעות אישיות מוגדרים באמצעות תכונות משוערות או דפוסים עקביים של התנהגות ולא באמצעות סטנדרטים אובייקטיביים יותר של התנהגות (כגון התקף פאניקה או מצב רוח דיכאוני ארוך ומתמשך), המטפל נדרש להפעיל שיקול דעת רב יותר באבחון הפרעה זו מאשר בהרבה הפרעות אחרות.

עם פיתוחם של ראיונות מובנים למחצה ושאלוני דיווח עצמי לאבחון הפרעות אישיות, כמה מההיבטים של מהימנות האבחון השתפרו במידה ניכרת. אולם, מאחר שההתאמה בין האבחנות שנקבעו על בסיס ראיונות מובנים שונים או שאלוני דיווח עצמי פעמים רבות נמוכה, נותרו עדיין בעיות בדבר המהימנות והתוקף של אבחנות אלה (Clark & Harrison, 2001; Livesley, 2003; Trull & Durrett, 2005). פירוש הדבר הוא לדוגמה, כי שלושה חוקרים שונים המשתמשים בשלושה כלי הערכה שונים עשויים לזהות קבוצות אנשים עם מאפיינים שונים מאוד כבעלות אבחנה מסוימת כגון הפרעת אישיות גבולית או נרקיסיסטית. מכאן עולה כמובן שחוקרים אחרים יוכלו לשחזר רק מעט מן הממצאים שהתקבלו אף שלקבוצות שהחוקרים השונים חקרו יש תווית אבחנתית זהה (למשל Clark & Harrison, 2001).

לנוכח הבעיות של חוסר מהימנות האבחנות (למשל Clark 2007; Livesley, 2003; Trull & Durrett, 2005), הוקדשה במהלך 20 השנים האחרונות עבודה רבה לפיתוח דרך מהימנה ומדויקת יותר להערכת הפרעות אישיות. תיאורטיקנים אחדים ניסו להתמודד עם הבעיות הטבועות בגישה להפרעות אישיות המבוססת על קטגוריות (שבה ההפרעות נחשבות לנפרדות ונבדלות זו מזו) בעזרת גישה ממדית. גישה זו מניחה שאישיות (והפרעת אישיות) נמצאת על רצף. לפיכך, ניסו לפתח מערכות הערכה ממדיות לתכונות ולתסמינים המעורבים בהפרעות אישיות (למשל Clark, 2007; Krueger & Eaton, 2010; Trull & Durrett, 2005; Widiger et al., 2009). עם זאת, סיווג ממדי אחיד של הפרעות אישיות לא התגבש במהירות, וישנם חוקרים המנסים לפתח גישה המשלבת את הגישות הרבות הקיימות (למשל Krueger, Eaton, Clark et al., 2011a; Markon et al., 2005; Widiger et al., 2009, 2012).

מודל חמשת הגורמים הוא אולי המודל בעל ההשפעה הרבה ביותר. הוא מבוסס על מודל חמשת הגורמים של אישיות נורמלית שהוזכר מוקדם יותר, המסייע לחוקרים להבין את המשותף לכל הפרעות האישיות ואת ההבדלים ביניהן באמצעות הערכת ציוניהם של אנשים אלה בחמשת תכונות האישיות הבסיסיות (למשל Clark, 2007; Widiger & Trull, 2007; Widiger et al, 2009, 2012). כדי להבין לאשורו את המגוון העצום של הדרכים שבהן אנשים נבדלים זה מזה, כל אחת מחמש תכונות האישיות הבסיסיות האלה מחולקת גם לתת-מרכיבים. לדוגמה, התכונה הבסיסית נזירותיות כוללת שישה תת-מרכיבים: חרדה, כעס-עוינות, דיכאון, מודעות עצמית, אימפולסיביות ופגיעות. אנשים שונים שלכולם רמת נזירותיות גבוהה, יכולים להיות שונים מאוד זה מזה בתת-המרכיבים הבולטים יותר. לדוגמה, יש שאצלם יבלטו יותר חרדה ומחשבות דיכאוניות, אחרים עשויים להפגין יותר מודעות עצמית ופגיעות ואנשים אחרים יכולים להראות יותר כעס-עוינות ואימפולסיביות. תכונת המוחצנות כוללת שישה תת-מרכיבים: חוסר, חברותיות, אסרטיביות, פעילות, חיפוש ריגושים ורגשות חיוביים (כל תת-המרכיבים של כל אחד מחמשת ממדי התכונות הבסיסיות והאופן שבו הם משתנים אצל אנשים עם הפרעות אישיות שונות מוסברים בטבלה 10.2). באמצעות הערכת ציוניו של אדם כנמוכים, גבוהים או בינוניים בכל אחד מ-30 תת-המרכיבים, קל לראות כיצד מערכת זו יכולה להסביר טווח עצום של דפוסי אישיות שונים – הרבה יותר מ-10 הפרעות האישיות המסווגות כיום ב-DSM.

במסגרת גישה ממדית, אפשר לערוך מחדש ממדים של תכונות אישיות נורמליות לתחומים מקבילים המייצגים קיצוניות פתולוגית יותר של ממדים אלה: רגשיות שלילית (נזירותיות), ניתוק (מופנמות קיצונית), אנטגוניזם (נועם הליכות נמוך ביותר) וחוסר עכבות (תחושת חובה נמוכה ביותר). נראה כי הממד החמישי, פסיכוטיות, אינו הקצה הפתולוגי של הממד האחרון של אישיות נורמלית (פתיחות), אלא, כפי שנדון מאוחר יותר בסעיף על הפרעת אישיות סכיזופרנית, הוא משקף תכונות דומות לתסמינים של הפרעות פסיכוטיות (למשל סכיזופרניה) (Watson et al., 2008).

לאור ההסתעפויות האלה ובמשנה זהירות, נבחן עתה את המאפיינים הקליניים של הפרעות אישיות. חשוב לזכור כי מה שאנו מתארים הוא רק אב-טיפוס של כל הפרעת אישיות. במציאות, כפי שאפשר לצפות מנקודת המבט של מודל חמשת הגורמים של הפרעות אישיות, נדיר למצוא אדם המתאים לתיאורים "אידיאליים" אלה. וכפי שהמסגרת "חשיבה ביקורתית על DSM-5" ממחישה, מצב זה נותר על כנו ב-DSM-5.

טבלה 10.2 הפרעות אישיות ב-DSM-5 ומודל חמשת הגורמים

טורגית- כפייגית	תלותית	נמנית	נרקיסטית	היסטורית	גבולית	אנטי- חברתית	סכיון טיפלית	סכיואידית	פרגואידית	שאלון אישיות NEO מעודכן - תחומים ותת-מרכיבים
נוירוטיות										
	גבולת	גבולת			גבולת		גבולת	גבולת		חרדה
			גבולת		גבולת	גבולת			גבולת	כעס-עוינות
		גבולת		גבולת	גבולת					דיכאון
	גבולת	גבולת	גבולת	גבולת			גבולת			מודעות עצמית
					גבולת					אימפלסיונות
	גבולת	גבולת			גבולת					פגיעות
מחצנות										
	גבולת			גבולת			נמור	נמור		חוס
		נמור		גבולת			נמור	נמור		חברתיות
גבולת	נמור	נמור								אסרטיביות
										פעילות
		נמור		גבולת		גבולת				חיפוש ריגשים
				גבולת			נמור	נמור		רגשות חיוביים
פתיות להחנאות										
				גבולת	גבולת			גבולת		פנטזיה
										אסתטיות

הערה: מבוסס על הקריטריונים האבחנתיים של המהדורה הרביעית של *Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders* (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994). הקריטריונים האבחנתיים של הפרעות אישיות נותרו ללא שינוי ב-DSM-5.

מקור: על פי P. T. Widiger et al. (2002). A description of the DSM-IV personality disorders with the five-factor model of personality. In P. T. Costa & T. A. Widiger (Eds.), *Personality disorders and the five-factor model of personality* (2nd ed., p. 90). Washington DC: APA Books.

שאלון אישיות NEO מעודכן - תחומים ותת-מרכיבים	פרגמטיות	סכזואידיות	סיכזן טיפלית	אנטי- חברתית	גבולית	היסטוריונית	נרקסיסטיט	נמנעת	תלותית	טורדניות כפיתית
רגשית		נמור				גבורה				
פעולת			גבורה							
רעיונות			גבורה							
ערכים										נמור
נועם הלכות										
אמון	נמור		נמור		נמור	גבורה			גבורה	
ישירות	נמור			נמור						
אלטרואיזם				נמור			נמור		גבורה	
היענות	נמור			נמור	נמור				גבורה	נמור
צניעות							נמור		גבורה	
התנהלות עדינה				נמור			נמור			
תחושת חובה										
יכולת					נמור					
סדר										גבורה
ציתנות				נמור						גבורה
הישגיות							גבורה			גבורה
משמעת עצמית				נמור						גבורה
תשומת לב				נמור						

קשיים בחקר הסיבות להפרעות אישיות

באופן יחסי, מעט ידוע לנו על הגורמים הסיבתיים המעורבים בהתפתחות רוב הפרעות האישיות. אחת הסיבות היא שהפרעות כאלה התחילו לקבל תשומת לב מחוקרים באופן עקבי רק אחרי פרסום ה-DSM ב-1980. בעיה אחרת נובעת מן הרמה הגבוהה של התחלואה הנלווית שיש בהן. לדוגמה, בסקירה של ארבעה מחקרים, מצאו וידיגר ועמיתיו כי 85% מן המטופלים שהתאימו לאבחנה של הפרעת אישיות אחת התאימו לאבחנה של הפרעת אישיות נוספת אחת לפחות, ורבים התאימו לכמה אבחנות נוספות (Widiger & Rogers, 1989; Widiger et al., 1991). במחקר של 900 מטופלים פסיכיאטריים במרפאות חוץ נמצא ש-45% התאימו לאבחנת אישיות אחת לפחות וביניהם ל-60% היו יותר מהפרעה אחת ול-25% היו שתיים או יותר (Zimmerman et al., 2005). אפילו במדגם של אנשים שאינם מטופלים, צימרמן וקורייל (Zimmerman & Coryell, 1989) מצאו שמתוך אלה עם הפרעת אישיות אחת, כ-25% סבלו לפחות מהפרעה אחת נוספת (ראו גם Mattia & Zimmerman, 2001; Trull et al., 2012). תחלואה נלווית רבה זו מוסיפה לקושי להבין אילו גורמים סיבתיים קשורים לאילו הפרעות אישיות.

חשיבה ביקורתית על DSM-5

מדוע לא הוכנסו שינויים בדרך האבחון של הפרעות אישיות?



השינוי הגדול ביותר נבע מהשילוב של רכיבים ממדיים. תחום האישיות החדש נועד לתאר מאפיינים של כל המטופלים, גם של אלה שאין להם הפרעת אישיות ספציפית. ההצעות היו מאפשרות למטפלים לדרג את רמת הפגיעה בתפקוד האישיות של המטופל וכך לשקף גם היבטים של זהות (תחושה יציבה וברורה של העצמי והיכולת לחפש מטרות משמעותיות בחיים) ושל תפקוד בין-אישי (היכולת לחוש אמפתיה ואינטימיות). נוסף על כך, מאבחנים היו יכולים לציין את דרגת החריגה המשמעותית של המטופל בחמישה תחומי תכונות (רגשיות שלילית, ניתוק, עוינות, חוסר עכבות ופסיכוטיות) המבוססים בעיקר על מודל התכונות של חמשת הגורמים שבו דנו לעיל.

אולם, בסופו של דבר, הוועד המנהל של האגודה האמריקנית לפסיכיאטריה דחה את כל השינויים שהוצעו והחליט לשמור על אותן קטגוריות ישנות של הפרעות אישיות. במילים אחרות, הפרעות האישיות המופיעות ב-DSM-5 הן אותן הפרעות שהיו ב-DSM-IV-TR. מדוע לא התקבלה אף הצעה לשינוי? איננו יודעים בוודאות. אך כפי שבדדאי הבנתם

הרבה הצעות לשינויים חדשים וחדשניים בסעיף הפרעות האישיות עמדו לדיון לקראת פרסומו של DSM-5. התיקונים שהוצעו היו בין הקיצוניים ביותר שהוצעו לכל ההפרעות הנידונות בספר זה. ויכוחים לוהטים ניטשו בנוגע לפרטים, אף שהמטרה הכללית הייתה לאמץ גישה ממדית יותר להערכת הפתולוגיה של הפרעות אישיות ולאבחון (Livesley, 2011; Skodol et al., 2011; Widiger et al., 2009).

המודל שצוות העבודה של DSM-5 הציע בסופו של דבר היה מודל היברידי ממדי-קטגוריאלי. הוא מורכב מרכיבים קטגוריאליים ומרכיבים ממדיים. המודל כולל מערכת קריטריונים כלליים לכל הפרעות האישיות, מדד ממדי כולל של רמת החומרה של חוסר התפקוד האישיותי, מספר מוגבל של סוגי הפרעות אישיות וקבוצה של תכונות אישיות פתולוגיות שאפשר לציין בהיעדר אחד מסוגי הפרעות האישיות. הרכיב הקטגוריאלי שהוצע שמר על 6 מ-10 סוגי הפרעות האישיות הספציפיות המקוריות (אנטי-חברתית, נמנעת, גבולית, נרקיסיסטית, טורדנית-כפייתית וסכזוטיפלית).

את המערכת המוצעת כמערכת ידידותית למשתמש בין היתר משום שהרעיון לדרג בני אדם על פי ממדים זר לאופן שבו מטפלים למדו לחשוב. עם זאת, ההצעות החדשות לא נדחו לגמרי. הן מופיעות כעת בחלק III של DSM-5 כמודל חלופי שעדיין יש לחקור. אפשר שהיה זה מהלך נכון. אולי עם עוד זמן ועם עוד מחקר יתברר אם הגישה החדשה מספקת די יתרונות כדי שאנשים יסכימו לקבל על עצמם את האתגר שלמידת המערכת והשימוש בה דורשים.

מהתיאור שלנו לעיל, שיטת הסיווג החדשה הייתה מסובכת מאוד. ייתכן שהשינויים היו מובילים למערכת סיווג טובה יותר, אך הייתה עלולה להיווצר בעיה שכן היא לא הייתה אינטואיטיבית או ידידותית למשתמש. קהל היעד העיקרי של DSM הוא מטפלים, שקובעים אבחנות של הפרעות נפש אצל אנשים ומטפלים בהם. אנו סבורים כי דחיית המערכת החדשה שהוצעה נובעת מהיותה מסורבלת ומשום שהאמינו כי הלמידה שלה והשימוש בה יגזלו זמן רב מהמטפלים, העמוסים בעבודה. יתרה מזו, מטפלים כנראה לא היו רואים

בעיה נוספת בהסקת מסקנות בדבר הסיבות עולה משום שחוקרים סומכים יותר על מחקרים פרוספקטיביים. במחקרים אלה, צופים בקבוצות של אנשים לפני הופעתה של הפרעה וממשיכים לעקוב אחריהם במשך תקופת זמן מסוימת כדי לראות מי מהמשתתפים מפתח בעיות ואילו גורמים סיבתיים היו מעורבים בהן. אומנם כיום מתחילה מגמת שינוי, אך עד כה נערכו באופן יחסי מעט מחקרים פרוספקטיביים על מרבית הפרעות האישיות. במקום זה, רוב-רובו של המחקר נערך עם אנשים שכבר לקו בהפרעה. חלק מהמסקנות מסתמכות על היזכרות באירועים קודמים, וחלקן מסתמכות על צפייה בתפקוד הביולוגי, הקוגניטיבי, הרגשי והבין-אישי הנוכחי. לפיכך יש להתייחס למסקנות בדבר הסיבות האפשריות כאל זמניות.

אשר לגורמים ביולוגיים אפשריים, יש הטוענים כי מזג של תינוקות (נטייה מולדת להגיב ברגשיות לגירויים סביבתיים) (ראו פרק 3) עשוי לגרום להם מראש לנטייה לפתח תכונות והפרעות מסוימות (למשל, L. A. Clark, 2005; Mervielde et al., 2012b; Paris, 2005). הממדים החשובים ביותר של מזג כוללים בין היתר רגשיות שלילית, חברתיות לעומת עכבה חברתית או ביישנות ורמת פעילות. אפשר לחשוב על מזג כעל מה שמניח את היסודות המוקדמים להתפתחות האישיות הבוגרת, אך הוא אינו הגורם הקובע היחיד של האישיות הבוגרת. מאחר שרוב תכונות המזג והאישיות הן תורשתיות במידה מסוימת (למשל, Bouchard & Loehlin, 2001; Kendler et al., 2008; 2011; Livesley, 2005), אין פלא שהולכות ומצטברות ראיות המצביעות על תרומה גנטית להפרעות אישיות מסוימות (למשל, Kendler et al., 2008; 2011; Livesley, 2005; South et al., 2012; Torgersen et al., 2000; 2008; Livesley & Jang, 2008). אולם נראה כי לפחות לגבי רוב ההפרעות, התרומה הגנטית מתווכת על ידי התרומה הגנטית לממדי התכונות העיקריות בכל הפרעה ולא דווקא להפרעות עצמן (Kendler et al., 2008; Livesley, 2005). נוסף על כך, יש כיום התקדמות מסוימת בהבנת התשתית הפסיכו-ביולוגית של כמה מהתכונות המעורבות באופן בולט בהפרעות אישיות (למשל, Depue & Lenzenweger, 2001, 2006; Depue, 2009; Livesley, 2008; Paris, 2005, 2007; Roussos & Siever, 2012).

באשר לגורמים פסיכולוגיים התורמים להתפתחות הפרעת אופי, תיאורטיקנים פסיכודינמיים ייחסו בעבר חשיבות רבה להגזמה בסיפוק של דחפים או להגזמה



אחת הבעיות בקטגוריות אבחון להפרעות אישיות היא שבדיקת אותן התנהגויות נצפות עשויות להתקשר להפרעות אישיות שונות ובכל הפרעה לקבל משמעות שונה. לדוגמה, התנהגותה של אישה זו והבעות פניה יכולות להצביע על חשדנות ועל התעלמות מרגשי אשם המתאימים להפרעת אישיות פרנואידית. לעומת זאת הן יכולות להצביע על הסתגרות חברתית ועל היעדר חברים, המאפיינים הפרעת אישיות סכיזואידית. הן יכולות גם להצביע על חרדה חברתית הקשורה לאינטראקציה עם אנשים אחרים בשל הפחד מדחייה או מהערכה שלילית, שאנו רואים בהפרעת אישיות נמנעת.

בא־היענות להם שתינוק חווה בשנות חייו הראשונות (Fonagy & Luyten, 2012). בעבר הקרוב יותר, דפוסי הרגלים וסגנונות קוגניטיביים לא הסתגלוניים המבוססים על למידה קיבלו יותר תשומת לב כגורמים סיבתיים אפשריים (למשל הקוגניטיביים הלא הסתגלוניים הללו, ששיערו כי הם ממלאים תפקידים חשובים בהפרעות מסוימות, מתחילים ביחסי היקשרות לקויים בין ההורה לילד ואינם נגזרים פשוט מהבדלים במזג (למשל, Fraley & Shaver, 2005; L. S. Benjamin, 2005; Farrington, 2006; Paris, 2008; Meyer & Pilkonis, 2005; Shiner, 2009). גם פסיכופתולוגיה של ההורים ותפקוד הורי לקוי מעורבים בהפרעות מסוימות (למשל, Paris, 2008; Meyer & Pilkonis, 2005; Shiner, 2009). במחקרים רבים עלתה גם הטענה שהתעללות רגשית, גופנית ומינית בגיל צעיר עשויה להיות גורם בתת-קבוצה של מקרים בכמה וכמה הפרעות אישיות שונות (Battle et al., 2004; Grover et al., 2007).

סוגים שונים של גורמי עקה חברתיים, שינויים חברתיים וערכים תרבותיים זהו אף הם כגורמים סיבתיים חברתיים-תרבותיים (Paris, 2011). בסופו של דבר, המטרה היא כמובן להגיע לנקודת מבט ביו-פסיכו-חברתית על מקורותיה של כל אחת מהפרעות האישיות. נכון לעכשיו, אנו עדיין רחוקים מרחק רב מהשגת המטרה.

שאלות חזרה



- ציינו שלוש סיבות לשכיחות הגבוהה של שגיאות באבחנות של הפרעות אישיות.
- ציינו שתי סיבות לקושי בעריכת מחקרים על הפרעות אישיות.

הפרעות אישיות מאשכול A

יעד לימוד 10.3 למנות את שלוש הפרעות האישיות באשכול A ולתאר את המאפיינים הקליניים העיקריים של כל אחת מהן.

אנשים עם הפרעות אישיות מאשכול A מציגים התנהגויות לא רגילות, כגון חוסר אמון, חשדנות וניתוק חברתי, והם נתפסים לעיתים קרובות כמוזרים או משונים. בסעיפים הבאים נתוודע לשלוש הפרעות אישיות: פרנואידית, סכזואידית וסכזואיפלית.

הפרעת אישיות פרנואידית

הפרעת אישיות פרנואידית
(paranoid personality disorder)

אנשים עם **הפרעת אישיות פרנואידית** הם חשדנים וחסרי אמון באחרים ופעמים רבות הם מייחסים משמעויות נסתרות להערות יום-יומיות. הם נוטים לראות את עצמם כחפים מכל אשמה ומאשימים אחרים בשגיאותיהם ובכישלונותיהם - ואפילו מייחסים מניעים מרושעים לבני אדם אחרים. אנשים אלה נמצאים

במתח תמידי וכל הזמן עומדים על המשמר בציפייה להונאה. הם מחפשים רמזים לאימות ציפיותיהם ומתעלמים מכל ראייה הסותרת אותן. לעיתים קרובות הם מלאי ספקות בדבר נאמנותם של חבריהם ולכן הם נרתעים מלגלות את ליבם בפניהם. פעמים רבות הם נוטרים טינה ומסרבים לסלוח על מה שלתפישתם הוא העלבות וזלזול, והם ממהרים להגיב בחמת זעם ולעיתים אפילו בהתנהגות אלימה (Bernstein & Useda, 2007; Oltmanns & Okada, 2006). כל זה מוביל אותם לקשיים בין-אישיים מרובים. תפוצת הפרעת האישיות הפרנואידית באוכלוסייה היא בין 1% ל-2% הן בקרב נשים והן בקרב גברים (Torgersen, 2012).

מן הראוי לזכור כי אנשים עם אישיות פרנואידית בדרך כלל אינם פסיכוטיים. רוב הזמן יש להם קשר ברור עם המציאות. עם זאת, בתקופות של עקה חזקה הם עלולים לחוות תסמינים פסיכוטיים חולפים שנמשכים דקות ספורות עד כמה שעות (APA, 2013). אחדים מתסמיני הפרעת האישיות הפרנואידית זהים לתסמיני הסכיזופרניה, אולם לאלה האחרונים יש הרבה בעיות נוספות לרבות ניתוק ממושך יותר מן המציאות, הזיות והרהורי שווא. אף על פי כן, אנשים עם הפרעת אישיות פרנואידית נמצאים בסיכון גבוה לסכיזופרניה (Lenzenweger, 2009).

גורמים סיבתיים

הפרעת אישיות פרנואידית לא נחקרה הרבה כהפרעה. אחת הסיבות לכך היא שבני אדם חשדניים מאוד וחסרי אמון נוטים לסרב להשתתף במחקרים. יש הטוענים שקיימת תורשתיות גנטית חלקית שאולי מקשרת את ההפרעה לסכיזופרניה, אולם הסוגיה הזו נבחנה ולא נמצאו ממצאים עקביים, ואם קיים קשר – הוא אינו חזק (Kendler et al., 2006; Miller, Useda, et al. 2001). עם זאת, ישנן ראיות למידה מתונה של השפעה גנטית בהפרעת האישיות הפרנואידית עצמה (Kendler, Myers et al., 2007). השפעה זו יכולה לנבוע מהתורשתיות של רמות גבוהות של אנטגוניזם (נועם הליכות נמוך) ונוירוטיות (כעס-עוינות), שהן מהתכונות הבולטות בהפרעת אישיות פרנואידית (Hopwood & Thomas, 2012; Widiger et al., 2002). גורמים סיבתיים פסיכו-חברתיים הממלאים כנראה גם הם תפקיד בהתפתחות ההפרעה כוללים הזנחה או התעללות הורית וחשיפה למבוגרים אלימים, אם כי קשרים בין חוויות שליליות בגיל צעיר לבין הפרעת אישיות פרנואידית באדם הבוגר בהחלט אינם ספציפיים להפרעת אישיות זו והם עשויים לשחק תפקיד גם בהפרעות אחרות (Battle et al., 2004; Grover et al., 2007; Natsuaki et al., 2009). התסמינים של הפרעת אישיות פרנואידית מתעצמים אחרי פגיעת מוח טראומטית ונראים לעיתים קרובות אצל אנשים המשתמשים בקוקאין באופן כרוני (ראו Hopwood & Thomas, 2012). במקרה שלפנינו, פגיעת ראש ושימוש באלכוהול הם גורמים סיבתיים אפשריים.

הפרעת אישיות פרנואידית

המטופל, גבר בן 46 שעבד כפועל, אושפז בבית חולים פסיכיאטרי אחרי ניסיון התאבדות. בשנות ההתבגרות שלו הוא היה מעורב בתאונת דרכים

ואושפז בשל טראומת ראש וזעזוע מוח. הייתה לו גם היסטוריה ארוכה של שימוש באלכוהול. מכריו תיארו אותו כרגיש ביותר, פגיע, חשדן וחסר אמון. אולם המאפיין הבולט ביותר היה דאגה בדבר נאמנותה של אשתו. הוא האשים אותה שוב ושוב בחוסר נאמנות ולעיתים קרובות "חקר" אותה בנוגע לטווח רחב של עניינים. כאשר הוא שתה, הפרנויה שלו בלטה עוד יותר (נלקח מ-Birkeland, 2013).

הקריטריונים של DSM-5 הפרעת אישיות פרנואידית



6. תפיסת התייחסות לדמותו או לשמו הטוב של האדם כמתקפה שאנשים אחרים אינם מזהים ככזו ותגובה נמהרת של כעס או של התקפה נגדית.
7. חשדות חוזרים ובלתי מוצדקים בדבר הנאמנות של בן הזוג או של השותף ליחסי מין.
- ב. התסמינים אינם מופיעים רק במהלך סכיזופרניה, הפרעה דר-קוטבית או הפרעת דיכאון עם מאפיינים פסיכויים או הפרעה פסיכוטית אחרת, ואי-אפשר לייחס אותם להשפעות הפיזיולוגיות של מצב רפואי אחר.
- הערה:** אם המטופל עונה על הקריטריונים הללו לפני התפרצותה של סכיזופרניה, יש להוסיף "טרם-מחלה" (premorbid), כלומר "הפרעת אישיות פרנואידית (טרם-מחלה)".

- א. חוסר אמון וחשדנות עמוקים באנשים אחרים עד כדי פירוש המניעים שלהם כמרושעים, המתחילים בבגרות המוקדמת, מתקיימים במגוון הקשרים ומתבטאים בארבעה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:
 1. חשדות חסרי בסיס מספק, שאחרים מנצלים את האדם, מזיקים לו או מרמים אותו.
 2. ספקות בלתי מוצדקים בדבר נאמנותם ואמינותם של חברים ומכרים.
 3. הסתייגות של האדם משיתוף אחרים בסודות מחשש בלתי מוצדק שישתמשו במידע נגדו באופן זדוני.
 4. ייחוס משמעויות נסתרות מזלזלות או מאיימות להערות או להתרחשויות תמימות.
 5. נטירת טינה תמידית (למשל חוסר מחילה על העלבה, פגיעה או זלזול).

מקור: צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition (copyright 2013). American Psychiatric Association.

הפרעת אישיות סכיזואידית

הפרעת אישיות סכיזואידית
(schizoid personality disorder)

בני אדם עם **הפרעת אישיות סכיזואידית** מתקשים לקשור קשרים חברתיים ובדרך כלל הם גם אינם מעוניינים בכך. לכן על פי רוב אין להם חברים טובים להוציא אולי בן משפחה קרוב. אנשים כאלה אינם מסוגלים להביע את רגשותיהם, והם נתפסים בעיני זולתם כקרים ומרוחקים. לעיתים קרובות חסרות להם מיומנויות חברתיות ואפשר לתייג אותם כאנשים מתבודדים או מופנמים עם תחומי עניין ועיסוקים המיועדים לאדם אחד בלבד, אם כי לא כל המתבודדים או המופנמים הם בעלי הפרעת אישיות סכיזואידית (Bernstein et al., 2009; Miller).

(Useda et al., 2001). אנשים עם הפרעה זו נוטים לא ליהנות מפעילויות רבות, כולל פעילות מינית, ונדיר שהם מתחתנים. ככלל, התגובות הרגשיות שלהם נמוכה למדי, לעיתים רחוקות בלבד הם חשים רגשות חיוביים או שליליים ובדרך כלל הם אדישים. חסרים אלה תורמים לרושם הקר והמרוחק שהם יוצרים (Miller, Useda, et al., 2001; Mittal et al., 2007). תפוצת הפרעת האישיות הסכיזואידית היא מעט יותר מאחוז אחד והיא שכיחה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים (Torgersen, 2012).



אנשים עם הפרעת אישיות סכיזואידית אינם מגלים עניין רב בטיפוח יחסים חברתיים קרובים.

במונחים של מודל חמשת הגורמים, אנשים עם הפרעת אישיות סכיזואידית מציגים רמות גבוהות מאוד של מופנמות (בייחוד רמה נמוכה בתת־מרכיבים חום, חברותיות ורגשיות חיובית). כמו כן, רמת הפתיחות לרגשות (תת־מרכיב של פתיחות להתנסויות) ורמת ההישגיות שלהם נמוכות (למשל, Hopwood & Thomas, 2012). להלן דוגמה, המקרה של ביל.

..... מנתח מערכות מופנם

ביל, בן 33, מנתח מערכות אינטליגנטי מאוד אך מסוגר ומופנם למדי הופנה להערכה פסיכולוגית על ידי הרופא המטפל שלו, שחשד כי ביל מדוכא ואינו מאושר. למעשה לביל לא היה מגע עם אנשים אחרים. הוא התגורר בגפו בביתו, עבד במשרד קטן לבדו ולרוב לא פגש איש בעבודה פרט לביקוריו המזדמנים של הממונה עליו, שבא לתת לו עבודה ולקחת פרויקטים שהושלמו. את ארוחות הצהריים אכל לבדו, ופעם בשבוע, בימים יפים, היה הולך בהפסקת הצהריים לגן החיות.

ביל היה בודד כל חייו. בילדותו היו לו מעט חברים ותמיד העדיף פעילויות שנעשות ביחידות מבילוי משפחתי (הוא היה הבכור בין חמישה ילדים). בתיכון מעולם לא יצא עם בנות, ובמכללה יצא רק פעם אחת עם אישה וזה היה בחברת קבוצה של סטודנטים אחרי משחק. עם זאת, הוא עסק בספורט ושיחק בנבחרות פוטבול בתיכון ובמכללה. במכללה בילה זמן רב עם חבר אחד קרוב יחסית – בעיקר בשתייה, אבל החבר עבר לגור בעיר אחרת.

ביל דיווח בענייניות כי הוא מתקשה ליצור חברויות, אף פעם אינו יודע מה לומר בשיחה. בהזדמנויות אחדות הוא חשב להתרועע עם אחרים אך פשוט לא הצליח לחשוב על המילים הנכונות "והשיחה פשוט גוועה". הוא סיפר כי בעת האחרונה הקדיש מחשבה לשינוי בחייו בניסיון להיות "חיובי" יותר, אך לא נראה לו שזה שווה את הטרחה. היה לו קל יותר שלא לעשות את המאמץ, כיוון שהיה בא במבוכה כאשר מישו ניסה לדבר איתו. הוא היה הכי שמח כשהיה לבדו.

.....

הקריטריונים של DSM-5 הפרעת אישיות סכיזואידית



7. קור רגשי, ניתוק או רגשיות שטחית.
- ב. התסמינים אינם מופיעים רק במהלך סכיזופרניה, הפרעה דו-קוטבית או הפרעת דיכאון עם מאפיינים פסיכטיים, הפרעה פסיכטית אחרת או הפרעה על הרצף האוטיסטי, ואין ליחס אותם להשפעות הפיזיולוגיות של מצב רפואי אחר.
- הערה:** אם המטופל עונה על הקריטריונים הללו לפני התפרצותה של סכיזופרניה, יש להוסיף "טרום-מחלה" (premorbid), כלומר "הפרעת אישיות פרנואידית (טרום-מחלה)".

מקור: צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (copyright 2013). American Psychiatric Association.

- א. דפוס נרחב של ניתוק מקשרים חברתיים וטווח מוגבל של ביטוי רגשות במסגרות בין-אישיות המתחיל בבגרות המוקדמת, מתקיים במגוון הקשרים ומתבטא בארבעה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:
1. חוסר רצון במערכות יחסים קרובות, כולל השתייכות למשפחה, והיעדר הנאה מהן.
 2. בחירה כמעט בלעדית בפעילות המיועדת לאדם עצמו בלבד.
 3. עניין מועט, אם בכלל קיים, בהתנסויות מיניות עם אדם אחר.
 4. הנאה מועטה, אם בכלל קיימת, מפעילויות שונות.
 5. היעדר חברים טובים או אנשי סוד מעבר לקרובי משפחה מדרגה ראשונה.
 6. אדישות לנוכח דברי שבח או ביקורת מצד אנשים אחרים.

גורמים סיבתיים

בדומה להפרעת אישיות פרנואידית, הפרעת אישיות סכיזואידית לא עמדה במוקד תשומת ליבם של החוקרים. גם במקרה זה אין בכך הפתעה שכן אנשים עם הפרעת אישיות סכיזואידית אינם בדיוק מסוג האנשים שאנו מצפים כי יתנדבו להשתתף במחקר. נמצא כי מרכיב התורשתיות בתכונותיה של אישיות סכיזואידית גבוה למדי ומגיע לכ-55% (Kendler et al, 2006). ישנן גם ראיות, המתיישבות עם רעיונות של חוקרים בעבר, שלפיהן במקרים מסוימים, תסמינים של הפרעת אישיות סכיזואידית מבשרים התפתחות של מחלה פסיכוטית (Bolinskey et al, 2015; Hopwood & Thomas, 2012). קיים גם קשר מסוים בין אישיות סכיזואידית לבין הפרעות על הרצף האוטיסטי. זהו ממצא מעניין שכן מחקרים עדכניים יותר מראים כי ייתכן שלסכיזופרניה ולאויזם יש בסיס גנטי משותף (להרחבה, ראו פרק 13).

יש תיאורטיקנים הטוענים כי ייתכן שהשיבושים החמורים ביחסים החברתיים הנצפים בהפרעת אישיות סכיזואידית נובעים מליקוי חמור במערכת בסיסית של השתייכות (Depue & Lenzenweger, 2005, 2006). תיאורטיקנים קוגניטיביים סבורים כי התנהגותם הקרירה והמרוחקת של הלוקים בהפרעת אישיות סכיזואידית מקורה בסכמות חבויות לא הסתגלויות שבגללן הם רואים את עצמם כאנשים שמסתדרים לבד ותופסים אנשים אחרים כמי שפולשים לפרטיותם. האמונה הדיספונקציונלית הבסיסית עשויה להיות "אני מיסודי לבד" (Beck et al., 1990, p.51) או "יחסים הם עניין מסובך [ו]בלתי רצוי" (Pretzer & Beck, 1996, p.).

60; ראו גם Beck et al., 2004). לצערנו, איננו יודעים מדוע וכיצד בני אדם עשויים לפתח אמונות דיספונקציונליות כאלה.

הפרעת אישיות סכיזוטיפלית

הפרעת אישיות סכיזוטיפלית
(schizotypal personality disorder)

בדומה לאנשים עם הפרעת אישיות סכיזואידית, גם הלוקים ב**הפרעת אישיות סכיזוטיפלית** מכונסים מאוד בעצמם ויש להם מכלול של חסרים חברתיים ובין-אישיים נרחבים. אך יש להם גם עיוותים קוגניטיביים ותפיסתיים וכן התנהגויות ודרכי תקשורת מוזרות ומשונות (Kwapil & Barrantes-Vidal, 2012; Raine, 2006). אומנם הקשר שלהם עם המציאות בדרך כלל נשמר, אך אנשים עם אישיות סכיזוטיפלית מתאפיינים בחשיבה אישית ייחודית מאוד ורוויה באמונות תפלות, ובתנאי עקה קיצוניים הם עלולים לחוות תסמינים פסיכויטיים חולפים (APA, 1994; Widiger & Frances, 2013). אכן, לעיתים קרובות הם מאמינים שיש להם כוחות מאגיים והם עשויים לעסוק גם בטקסי פולחן מאגיים. בעיות קוגניטיביות-תפיסיות אחרות שאנשים עם ההפרעה סובלים מהן כוללות רעיונות ייחוס (האמונה כי לשיחות עם אחרים או למחוויותיהם יש כוונה מיוחדת או משמעות אישית), צורת דיבור מוזרה ואמונות פרנואידיות.

המוזרויות בחשיבה, בדיבור ובהתנהגויות אחרות הן המאפיינים היציבים ביותר של הפרעת אישיות סכיזוטיפלית (McGlashan et al., 2005), והן דומות לאלה הנראות לעיתים קרובות אצל מטופלים עם סכיזופרניה. למעשה, חוקרים רבים רואים בהפרעת אישיות סכיזוטיפלית צורה מוחלשת של סכיזופרניה (Lenzenweger, 2010; Raine, 2006). מעניין כי אף שנראה כי מקצת ההיבטים של סכיזוטיפיות קשורים למודל חמשת הגורמים של אישיות נורמלית (בייחוד תת-המרכיבים מופנמות ונוירוטיות), מודל זה אינו מסביר כראוי את ההיבטים האחרים הקשורים לעיוותים קוגניטיביים ותפיסתיים (Watson et al., 2008). אכן, תסמינים מרכזיים אלה של סכיזוטיפיות (הקוגניטיביים והתפיסתיים) הם הבסיס לתכונה היחידה המוצעת שאינה משתלבת יפה בחמשת הגורמים של אישיות נורמלית. תכונה פתולוגית זו היא פסיכוטיות, המורכבת משלושה תת-מרכיבים: אמונות והתנסויות בלתי שגרתיות, מוזרויות וחוסר ויסות קוגניטיבי ותפיסתי (Krueger, Eaton, Derringer, et al., 2011).

גורמים סיבתיים

שלא כהפרעות האישיות הסכיזואידית והפרנואידית, הפרעת האישיות הסכיזוטיפלית זכתה לכמות משמעותית של מחקרים (Esterberg et al., 2010). למעשה, בהצעה המקורית ל-DSM-5, אישיות סכיזוטיפלית הייתה ההפרעה הקטגורית היחידה שנשמרה מאשכול A. תפוצתה של הפרעה זו באוכלוסייה הכללית היא בסביבות אחוז אחד, ויותר גברים לוקים בה מאשר נשים (Torgersen, 2012).

הפרעת אישיות סכיזוטיפלית היא תורשתית במידה בינונית (Kwapil & Barrantes-Vidal, 2012; Lin et al., 2006; 2007; Raine, 2006). החוקרים חושדים זה זמן רב גם

בקיומו של קשר גנטי בינה לבין סכיזופרניה. למעשה, נראה כי הפרעה זו היא חלק מרצף של הפרעות הקשורות לסכיזופרניה, ופעמים רבות היא מופיעה אצל קרובים מדרגה ראשונה של סכיזופרנים (Kendler & Gardner, 1977; Kwapil & Barrantes, 2006; Tienari et al., 2003; Vidal, 2012; Raine, 2006). הקשרים הביולוגיים בין הפרעת אישיות סכיזופרנית לבין סכיזופרניה הם יוצאי דופן (Jang et al., 2008; Cannon et al., 2004; Yung et al., 2004; Siever & Davis, 2004; al., 2005). במחקרים שנערכו בהשתתפות מטופלים וסטודנטים עם הפרעת אישיות סכיזופרנית (למשל Siever, 2006; Raine, 2006; Cannon et al., 1995) נמצא אותו ליקוי במעקב של העין אחרי מטרה נעה, שמופיע אצל אנשים עם סכיזופרניה (Coccaro, 2001; ראו גם פרק 13). נמצאו גם ליקויים קלים אחרים בתפקוד הקוגניטיבי (Vogelmaier et al., 2005), לרבות ליקויים ביכולתם לשמור על קשב (Lees-Roitman et al., 1997; Raine, 2006) וליקויים בזיכרון העבודה (למשל היכולת לזכור סדרת ספרות), שהם שכיחים בסכיזופרניה. כמו כן, אצל אנשים עם הפרעת אישיות סכיזופרנית, בדומה למטופלים עם סכיזופרניה, ישנם ליקויים ביכולת לעקב קשב לגירוי שני שבא במהירות אחרי הצגת גירוי ראשון. לדוגמה, כאשר מציגים לאדם בריא גירוי שמיעתי חלש כ-0.1 שנייה לפני השמעת צליל רועם (צליל מהסוג הגורם לתגובת בהלה), תגובת הבהלה שלו חלשה יותר מאשר אילו לא היה שומע את הגירוי הקולי החלש קודם (Cadenhead, Light, 2000; Cadenhead, Swerdlow et al., 2000; et al., 2000). זהו אפקט דיכוי נורמלי, ועוצמתו נמוכה יותר אצל הלוקים בסכיזופרניה כמו גם אצל אנשים עם הפרעת אישיות סכיזופרנית. ייתכן שהממצא הזה קשור לרמות גבוהות של הסחת דעת וקושי להישאר מרוכזים (ראו גם Raine, 2006; Hazlett et al., 2003). לבסוף, לאנשים עם הפרעת אישיות סכיזופרנית יש גם איתקניות שפתית, ולא מן הנמנע שיש לכך קשר עם ליקויים בעיבוד השמיעתי שלהם (Dickey et al., 2008).

לאור הממצאים האלה, אין זה מפתיע שנמצא כי מתבגרים עם הפרעת אישיות סכיזופרנית נמצאים בסיכון מוגבר לפתח סכיזופרניה והפרעות על רצף הסכיזופרניה בבגרות (Asarnow, 2005; Cannon et al., 2008; Raine, 2006; Tyrka, 1995; et al., 2006). עם זאת, היו שהציעו סוג שני של הפרעת אישיות סכיזופרנית שאין לה קשר גנטי לסכיזופרניה. סוג זה מאופיין בליקויים קוגניטיביים ותפיסתיים אך יש לו קשר להתעללות ולטראומה בילדות (Berenbaum et al., 2008; Raine, 2006). הפרעת אישיות סכיזופרנית במתבגרים נקשרה לחשיפה רבה לאירועי חיים מעוררי עקה (Anglin et al., 2008; Tessner et al., 2011) ולמעמד חברתי-כלכלי משפחתי נמוך (Cohen et al., 2008).

הקריטריונים של DSM-5 הפרעת אישיות סכיזופרנית



תפיסתיים והתנהגות מוזרה, המתחיל בבגרות המוקדמת, מתקיים במגוון הקשרים ומתבטא בחמישה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:

א. דפוס נרחב של ליקויים חברתיים ובינ-אישיים המתבטא בחוסר נוחות ממשי ביחסים קרובים ויכולת פחותה לקיים יחסים כאלה וכן בעיוותים קוגניטיביים או

1. רעיונות ייחוס (להוציא הרהורי שווא של ייחוס).
 2. אמונות מוזרות או חשיבה מאגית המשפיעות על ההתנהגות ואינן מתאימות לנורמות תרבותיות (למשל אמונות תפלות, אמונה בתפיסה על-חושית, בטלפתיה או ב"חוש שישי". בילדים ובמתבגרים, פנטזיות ועיסוק מחשבתי מוזרים).
 3. חוויות תפיסתיות בלתי רגילות כולל אשליות גופניות.
 4. חשיבה ודיבור מוזרים (למשל מעורפלים, נסיבתיים, מטפוריים, מפורטים מדי או סטריאוטיפיים).
 5. חשדנות או חשיבה פרנואידית.
 6. רגשיות בלתי הולמת או מוגבלת.
 7. התנהגות או הופעה מוזרה, משונה או מיוחדת.
 8. היעדר חברים קרובים או אנשי סוד מלבד קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
9. חרדה חברתית מוגזמת שאינה שוככת לאחר היכרות ונוטה להתקשר לפחדים פרנואידיים ולא לשיפוט עצמי שלילי.
- ב. התסמינים אינם מופיעים רק במהלך סכיזופרניה, הפרעה דו-קוטבית, הפרעת דיכאון עם מאפיינים פסיכויים, הפרעת אישיות אחרת או הפרעה על הרצף האוטיסטי.
- הערה:** אם המטופל עונה על הקריטריונים הללו לפני התפרצותה של סכיזופרניה, יש להוסיף "טרום-מחלה" (premorbid), כלומר "הפרעת אישיות סכיזוטיפלית (טרום-מחלה)".
- מקור:** צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition (copyright 2013). American Psychiatric Association.

שאלת חזרה



- תארו את הפרעות האישיות באשכול A והבחינו ביניהן: פרנואידית, סכיזואידית וסכיזוטיפלית.

הפרעות אישיות מאשכול B

יעד לימוד 10.4 לתאר את ארבע הפרעות האישיות באשכול B ולהסביר את המאפיינים המשותפים להן.

בתת-הסעיפים הבאים נבחן מקרוב את הפרעות האישיות ההיסטריונית, הנרקסיסטית, האנטי-חברתית והגבולית. זכרו כי לאנשים עם הפרעות אישיות מאשכול B משותפת הנטייה להיות דרמטיים, רגשיים ולא יציבים.

הפרעת אישיות היסטריאית

רדיפה מוגזמת אחר תשומת לב ורגשנות מופרזת הן שני המאפיינים המרכזיים של אנשים עם **הפרעת אישיות היסטריאית**. כפי שאפשר לראות במסגרת "הקריטריונים של DSM-5", כאשר אנשים אלה אינם עומדים במרכז תשומת הלב הם נוטים לחוש שלא מעריכים אותם. סגנונם המוחצן מדי, המלא חיים והדרמטי מבטיח להם לעיתים קרובות את יכולתם להקסים אחרים וכך למשוך את תשומת ליבם. אך תכונות אלה אינן מובילות למערכות יחסים יציבות ומספקות משום שהאנשים הסובבים מתעייפים מהענקת מידה כה גבוהה של תשומת לב. בשל התשוקה שלהם לגירויים ולתשומת לב, הופעתם והתנהגותם של

הפרעת אישיות היסטריאית
(histrionic personality disorder)

הלוקים בהפרעה הן תיאטרליות ורגשיות מאוד וכן פרובוקטיביות מבחינה מינית (Freeman et al., 2005). הם עשויים לנסות לשלוט בבני הזוג שלהם באמצעות התנהגות פתיינית ומניפולציה רגשית, אך הם מפגינים גם מידה רבה של תלותיות (למשל Balgov et al, 2007; Bornstein & Malka, 2009; Rasmussen, 2005a). צורת הדיבור שלהם לעיתים קרובות מעורפלת ונועדה להרשים, ובדרך כלל הם נתפסים כמרוכזים בעצמם, יהירים ועסוקים יתר על המידה בקבלת אישור מאנשים אחרים, החושבים שהם מגזימים בתגובותיהם, שטחיים ובלתי כנים.

הקריטריונים של DSM-5

הפרעת אישיות היסטריונית



- דפוס נרחב של רגשיות יתרה ורדיפה אחר תשומת לב המתחיל בבגרות המוקדמת, מתקיים במגוון הקשרים ומתבטא בחמישה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:
1. תחושת אי־נוחות במצבים שבהם האדם אינו נמצא במוקד תשומת הלב.
 2. אינטראקציה עם אחרים מאופיינת לעיתים קרובות בהתנהגות פרובוקטיבית ופתיינית מבחינה מינית.
 3. מעבר מהיר בין רגשות והבעה שטחית של רגשות.
 4. שימוש קבוע בהופעה חיצונית כדי למשוך תשומת לב.
5. סגנון דיבור שמנסה באופן מוגזם להרשים וללא פרטים.
6. דרמטיזציה עצמית, ביטוי רגשות תיאטרלי ומוגזם.
7. האדם נוח להשארה (למשל מושפע בקלות מאחרים או מהנסיבות).
8. הערכתן של מערכות יחסים כאינטימיות יותר מכפי שהן למעשה.

מקור: צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (copyright 2013). American Psychiatric Association.



ייתכן כי אישה זו בסך הכול משתטה עם חברים באחד הערבים. אך אם לעיתים קרובות היא מחפשת הזדמנויות להתנהג באופן פתייני שמושך תשומת לב, אפשר שהיא לוקה בהפרעת אישיות היסטריונית.

תפוצתה של הפרעת אישיות היסטריונית באוכלוסייה הכללית היא מעט יותר מאחוז אחד, אף שיש הסבורים כי שיעור ההפרעה נמצא בירידה (Blashfield et al., 2012; Torgersen, 2012). ישנם מחקרים שלפיהם הפרעה זו נפוצה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים (Lynam & Widiger, 2007; Widiger & Bornstein, 2001). הסיבות האפשריות להבדלים בין המגדרים שנויות במחלוקת עזה. באחת הסקירות נטען שההבדל בין המגדרים אינו מפתיע לנוכח מספר התכונות השכיחות יותר בקרב נשים המעורבות בקריטריונים לאבחנה. לדוגמה, רבים מהקריטריונים להפרעת אישיות היסטריונית (וגם לכמה הפרעות אישיות אחרות כגון הפרעת אישיות תלותית) כוללים משתנים לא הסתגלותיים של תכונות המיוחסות לנשים (למשל Widiger & Bornstein, 2001), כגון דרמטיזציה מוגזמת, יהירות, פתיינות ועיסוק מוגזם בהופעה החיצונית. אולם, תכונות אישיות אחרות הבולטות בהפרעת אישיות היסטריונית שכיחות יותר למעשה בקרב גברים מאשר בקרב נשים (למשל רדיפה אחר ריגושים ומודעות עצמית נמוכה). בנייתו קפדני שנערך בנושא, נמצא שאי־אפשר לנבא את התפוצה הגבוהה יותר של אישיות היסטריונית בקרב נשים על סמך ההבדלים בין המגדרים שיש בתכונות הבולטות בהפרעה. טענה זו מצביעה בהחלט על השפעתה של צורה כלשהי של הטיה מגדרית באבחון של הפרעה זאת (Lynam & Widiger, 2007).

גורמים סיבתיים

מעט מאוד מחקרים שיטתיים נערכו על הפרעת אישיות היסטריונית, אולי בשל הקושי של החוקרים להבחין אותה מהפרעות אישיות אחרות (Bornstein & Malka, 2009) ו/או משום שרבים אינם סבורים כי זוהי אבחנה תקפה (Blashfield et al., 2012). הדבר משתקף בעובדה שהפרעת אישיות היסטריונית הייתה אחת מארבע האבחנות שהוצע להוציאן מ־DSM-5. להפרעת אישיות היסטריונית יש תחלואה נלווית גבוהה של הפרעות האישיות גבולית, אנטי־ חברתית, נרקיסיסטית ותלותית (Bakkevig & Karterud, 2010; Balgov & Westen, 2008; Bornstein & Malka, 2009).

עקרת בית היסטריונית

לולו, עקרת בית בת 24, הגיעה ליחידת אשפוז ימים אחדים לאחר שנעצרה בגין "שוטטות". בעלה השאיר אותה בתחנת אוטובוס כדי שתחזור למשפחתה משום שנמאס לו מהתנהגותה ומן הטיפול בה. לולו הגיעה לשיחה מאופרת למשעי ולבושה בשמלה נשית מאוד ובתסרוקת מיוחדת במינה. במהלך הפגישה עם הפסיכיאטר היא הפגינה מחוות פתייניות מפלרטטות ודי ילדותיות ודיברה באופן די מעורפל על בעיותיה ועל חייה. תלונותיה העיקריות היו שבעלה נטש אותה וכי אינה יכולה לחזור אל משפחתה כיוון ששניים מאחיה התעללו בה. היא אמרה גם שאין לה חברים לפנות אליהם והיא אינה יודעת כיצד היא תסתדר. אכן היא התלוננה שמעולם לא היו לה חברות ושלתחושתה מעולם לא חיבבו אותה, אם כי היא לא ממש הבינה מדוע, והבטיחה למראיין שהיא טובת לב ונחמדה מאוד.

זמן מה לפני כן היא נסעה עם בעלה ועם זוג חברים שלו. אשת החבר האשימה את לולו בהתנהגות פתיינית מאוד כלפי בעלה של האישה, ולולו נפגעה שכן חשבה כי התנהגותה הייתה תמימה לגמרי ובשום אופן לא חרגה מהמקובל. התקרית גררה בעקבותיה ויכוח גדול עם בעלה שלה, אחד מני רבים בששת החודשים האחרונים שבהם הוא התלונן על התנהגותה הבלתי נאותה בקרבת גברים אחרים ועל היהירות שלה והצורך התמידי שלה בתשומת לב. ויכוחים אלה והתנהגותה, שלולו לא הצליחה לשנות, בסופו של דבר גרמו לבעלה לעזוב אותה.

ישנן ראיות שלפיהן קיים קשר גנטי בין הפרעה זו ובין הפרעה אנטי־ חברתית, והרעיון הוא כי קיימת נטייה בסיסית משותפת לשתי ההפרעות, שנוטה יותר להתבטא כהפרעת אישיות היסטריונית אצל נשים וכהפרעה אנטי־ חברתית אצל גברים (למשל Cale & Lilienfeld, 2002a, 2002b). הטענה שנטייה גנטית מסוימת גורמת להתפתחות הפרעה זו מקבלת חיזוק גם מממצאים שלפיהם הפרעת אישיות היסטריונית יכולה להתבטא כהפרעה הכוללת גרסאות קיצוניות של שתי תכונות אישיות שכיחות ונורמליות, מוחצנות ובמידה פחותה יותר – נזירותיות, שתי תכונות אישיות נורמליות בעלות בסיס גנטי חלקי (Widiger & Bornstein, 2001). במונחים

של מודל חמשת הגורמים (חזרו ועיינו בטבלה 10.2), רמות המוחצנות הגבוהות מאוד של מטופלים עם הפרעת אישיות היסטוריונית כוללות רמות גבוהות של חברותיות, רדיפה אחר ריגושים ורגשות חיוביים. הרמות הגבוהות של נירוטיות אצל מטופלים אלה כוללות בעיקר את תת-המרכיבים של דיכאון ומודעות עצמית. יש להם גם רמות גבוהות של פתיחות לפנטזיות (Widiger et al., 2002).

תיאורטיקנים קוגניטיביים מדגישים את חשיבותן של סכמות לא הסתגלויות הסובבות את הצורך בתשומת לב כדי להקנות תוקף לערכם העצמי של המטופלים. אמונות דיספונקציונליות מרכזיות יכולות להיות למשל "אם אני לא כובש את ליבם של אנשים אחרים אני לא שווה כלום" ו"אם אני לא יכול לבדר אנשים הם ינטשו אותי" (Beck et al., 1990, p.50). עד כה לא נערך מחקר שיטתי המסביר כיצד אמונות דיספונקציונליות כאלה מתפתחות.

הפרעת אישיות נרקיסיסטית

הפרעת אישיות נרקיסיסטית
(narcissistic personality disorder)

אנשים עם **הפרעת אישיות נרקיסיסטית** מפגינים תחושה מוגזמת של חשיבות עצמית, צורך לזכות בהערצה והיעדר אמפתיה לרגשות הזולת (Pincus & Lukowitsky, 2010; Ronningstam, 2005, 2009, 2012). מחקרים רבים תומכים ברעיון שקיימים שני סוגים של נרקיסיזם: סוג אחד מאופיין בתחושת גדלות והשגה – בפגיעות (Cain et al., 2008; Ronningstam, 2005, 2012). המופע הנרקיסיסטי של תחושת הגדלות המודגש בקריטריונים של DSM-5, מתבטא בתכונות הקשורות לגדלות, תוקפנות ודומיננטיות. התכונות הללו משתקפות בנטייה חזקה של הלוקים בהפרעה להעריך הערכת יתר את יכולותיהם ואת הישגיהם ובו־בזמן לזלזול ביכולותיהם ובהישגיהם של אנשים אחרים. תחושת הזכאות ("מגיע לי") מדהימה לא פעם את זולתם ואילו הם עצמם אינם רואים בציפיותיהם הגבוהות אלא את מה שמגיע להם. התנהגותם היא סטריאוטיפית (למשל בהתייחסות תמידית לעצמם בדבריהם ובהתרברבות) כדי להשיג את התשבחות ואת ההכרה שהם משתוקקים להן. בשל אמונתם שהם מיוחדים כל כך, לעיתים קרובות הם חושבים שרק אנשים נעלים כמותם מסוגלים להבין אותם או שעליהם להתרועע עם אנשים כאלה בלבד. לבסוף, כפי שהומחש במקרה של אלן בתחילת פרק זה, תחושת הזכאות שלהם קשורה גם לסירובם לסלוח לאחרים על מה שהם תופסים כעלבונות, והם עצמם נעלבים בקלות (Exline et al., 2004).

הקריטריונים של DSM-5 הפרעת אישיות נרקיסיסטית



1. תחושת חשיבות עצמית מופרזת (למשל הערכה מוגזמת של כישורים והישגים, ציפייה להכרה בעליונות בהיעדר הישגים שהולמים אותה).
 2. עיסוק מחשבתי בפנטזיות על הצלחה, כוח, תבונה, יופי או אהבה אידיאלית בלתי מוגבלים.
- דפוס נרחב של תחושת גדלות (בפנטזיה או בהתנהגות), צורך בהערצה והיעדר אמפתיה המתחיל בבגרות המוקדמת, מתקיים במגוון הקשרים ומתבטא בחמישה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:

3. אמונה של האדם שהוא "מיוחד" ויחיד במינו וכי רק אנשים (או מוסדות) ייחודיים ונעלים כמותו יכולים להבין אותו ורק איתם עליו להתרועע.
 4. דרישה להתפעלות מוגזמת.
 5. תחושה של זכאות (כלומר ציפיות בלתי מתקבלות על הדעת מצד האדם ליחס מועדף או להיענות אוטומטית לציפיותיו).
 6. נצלנות בקשרים עם הזולת (למשל מנצל אחרים כדי להשיג את מטרותיו).
 7. היעדר אמפתיה. חוסר נכונות להכיר ברגשותיהם של אחרים ובצורכיהם של אחרים או להזדהות איתם.
 8. קנאה תכופה של האדם באחרים או אמונה שאחרים מקנאים בו.
 9. התנהגות או גישה יהירה ומתנשאת.
- מקור:** צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (copyright 2013). American Psychiatric Association.

המופץ הנרקסיסטי של הפגיעות אינו משתקף בקריטריונים של DSM באותה בהירות, אך גם הוא מייצג סוג שחוקרים ומטפלים בוחנים כבר זמן רב. לאנשים עם הפרעת אישיות נרקסיסטית מהסוג הפגיע יש תחושת הערכה עצמית בלתי יציבה ושברירית ביותר, ואצל אנשים אלה, יהירות והתנשאות אינן אלא כיסוי לבושה עזה ולרגישות יתר לדחייה ולביקורת (Caine et al., 2008; Miller et al., 2010; Pincus & Lukowitsky, 2010; Ronningstam, 2005, 2012). נרקסיסטים פגיעים עשויים להיות שקועים ראשם ורובם בפנטזיות על הישגים יוצאים מן הכלל ובה־בעת לחוש בושה כבדה בשל השאפתנות שלהם. הם עשויים להימנע מיחסים בין־אישיים בגלל חשש מדחייה או מביקורת.

כיום, הולכות ומצטברות ראיות שלפיהן מופעי הגדלות והפגיעות של נרקסיסם קשורים זה בזה אך גם נבדלים זה מזה בדרכים חשובות. במונחים של מודל חמשת הגורמים, שני הסוגים נקשרים לרמות גבוהות של אנטגוניזם או לרמות נמוכות של נועם הליכות (הכוללות את התכונות של צניעות נמוכה, יהירות, תחושת גדלות ועליונות), אלטרואיזם נמוך (ציפייה ליחס מועדף וניצול של אחרים) ונוקשות (היעדר אמפתיה). עם זאת, אצל אדם עם המופע הנרקסיסטי של גדלות, תת־מרכיבים מסוימים של נורוטיות הם נמוכים והמוחצנות גבוהה. כאשר הנרקסיסם כולל יותר תחושת גדלות, חברים ובני משפחה עשויים להיות מוטרדים יותר מהתנהגותו של האדם מאשר הוא עצמו. באחד המחקרים הגיעו החוקרים למסקנה כי "השיבוש החזק ביותר הקשור להפרעת אישיות נרקסיסטית אינו מצוקת "הכאב והסבל" של הלוקה בהפרעה אלא של הקרובים המשמעותיים בחייו" (Miller, 2007, p. 176). לעומת זאת, המקרה של הנרקסיסט הפגיע שונה למדי שכן רמות הרגשיות השלילית / נורוטיות שלו גבוהות מאוד (Cain et al., 2008; Miller et al., 2010). בנות ובני זוג של מטופלים משני הסוגים – הגדלות או הפגיעות – מתארים אותם כ"שתלטים, חסרי סובלנות, אכזריים, נקמנים, לא ישרים, אופורטוניסטים, רברבנים, יהירים ותובעניים", אך רק אלה עם רמות גבוהות של תחושת גדלות תוארו גם כ"תוקפניים, עקשנים, ישירים, אסרטיביים ונחושים", ואילו נרקסיסטים עם רמות גבוהות של פגיעות תוארו כ"מודאגים, רגשניים, הגנתיים, חרדים, מרימים, לחוצים ומתלוננים" (Wink, 1991, p. 595). חשוב לציין כי בקרב הלוקים בהפרעת אישיות נרקסיסטית, יש העשויים לעבור חליפות בין תחושת גדלות לבין פגיעות (Pincus & Lukowitsky, 2010; Ronningstam, 2009).

לאנשים עם אישיות נרקסיסטית יש עוד תכונה מרכזית משותפת – הם אינם רוצים או אינם מסוגלים לאמץ את נקודת המבט של זולתם, לראות דברים לא רק "דרך המשקפיים שלהם". יתרה מזו, אם הם אינם מקבלים את האישור או את הסיוע שהם מקווים לו, הם נוטים להיות ביקורתיים ונקמניים מאוד (Rasmussen, 2005b). ואכן, במחקר שבו השתתפו סטודנטים גברים עם רמות גבוהות של תכונות נרקסיסטיות נמצא שיש להם נטייה גבוהה יותר לכפייה מינית כאשר נדחו על ידי מושא תשוקותיהם המיניות בהשוואה לגברים עם רמות נמוכות יותר של תכונות נרקסיסטיות. כשצפו בתיאורי אונס מצולמים, הם גם דירגו אותם כפחות בלתי רצויים ויותר מהנים ומעוררים מינית מאשר גברים עם רמות נמוכות יותר של תכונות נרקסיסטיות (Bushman et al., 2003).

לפי מדגמים בקהילה, קצת פחות מאחוז אחד של אנשים עונים על הקריטריונים האבחנותיים להפרעת אישיות נרקסיסטית, ונראה שההפרעה שכיחה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים (Torgersen, 2012). אפשר היה לצפות להבדל מגדרי זה לנוכח הבדלים ידועים בין המינים בתכונות אישיות בולטות בהפרעת אישיות נרקסיסטית (Lynam & Widiger, 2007).

גורמים סיבתיים

מידע על הפרעת אישיות נרקסיסטית היה קיים זמן רב, אך רובו היה תיאורטי ורק נתונים אמפיריים מעטים פורסמו על הגורמים הסביבתיים והגנטיים המעורבים באטיולוגיה של הפרעת אישיות נרקסיסטית (Kohut & Wolff, 1978; Millon & Davis, 1995; Widiger & Bornstein, 2001). למרבה המזל, ישנם כמה חוקרים הפועלים נמרצות להבנת הסיבות להפרעה מרתקת זו. ממצא מרכזי מלמד שהסוג של תחושת גדלות באישיות נרקסיסטית וזה של פגיעות קשורים לגורמים סיבתיים שונים. נרקסיזם מהסוג של תחושת הגדלות על פי רוב אינו קשור להתעללות בילדות, להזנחה או להורות לקויה. לאמיתו של דבר, ישנן ראיות לקשר בין סוג זה של נרקסיזם לבין הערכת יתר של הורים את ילדיהם. נרקסיזם מהסוג הפגיע, לעומת זאת, קשור להתעללות רגשית, גופנית ומינית, וכן לסגנונות הורות המאופיינים כחודרניים, שולטים וקרים (Horton et al., 2006; Miller, 2011; Miller & Campbell, 2008; Otway & Vignoles, 2006).

הפרעת אישיות אנטי-חברתית

הפרעת אישיות אנטי-חברתית
ASPD – Antisocial Personality
(Disorder)

המאפיין הבולט ביותר אצל אנשים עם **הפרעת אישיות אנטי-חברתית** הוא נטייתם התמידית להתעלם מזכויות הזולת ולהפר אותן. הם עושים זאת באמצעות שילוב של התנהגויות ערמומיות, תוקפניות ואנטי-חברתיות. לאנשים אלה יש דפוס קבוע ומתמשך של התנהגות לא חברתית וחסרת אחריות עם דאגה מועטה לביטחון – שלהם או של אחרים. מאפיינים אלה מביאים אותם שוב ושוב לקונפליקטים עם החברה, ורבים מהם מגיעים בסופו של דבר לכלא. רק מבוגרים בני 18 ומעלה יכולים לקבל אבחנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית. כדי לקבוע אבחנה זו, צריכים להופיע אצל האדם תסמינים של הפרעת התנהגות לפני גיל 15 (ראו פרק 15). אחרי גיל 15 צריכות להופיע גם ראיות של התנהגות לא חוקית,

מרמה, אימפולסיביות, תוקפנות או חוסר אחריות קבוע בעבודה או בענייני כספים. הנה לדוגמה המקרה של מארק.

גנב עם הפרעת אישיות אנטי-חברתית

מארק, בן 22, המתין למשפט בגין גניבת מכונית ושוד מזוין. מסמכי התיק שלו כללו היסטוריה ארוכה של מעצרים שהחלה כשהיה בן 9, כאשר נעצר על השחתת רכוש. הוא הורחק מבית הספר התיכון בשל היעדרויות והפרעות. בכמה מקרים הוא ברח מן הבית למשך ימים או שבועות בכל פעם – ותמיד חזר פרוץ ותשוש. עד כה הוא לא החזיק מעמד בשום מקום עבודה יותר מימים אחדים אף שהקסם האישי שלו אפשר לו באופן כללי להשיג עבודה בקלות. הוא תואר כמתבודד עם חברים מעטים. אף שנראה בהתחלה מקסים, בדרך כלל לא חלף זמן רב עד שמארק עורר התנגדות אצל מי שפגש בשל התנהגותו התוקפנית והממוקדת בעצמי. זמן קצר אחרי פגישת הטיפול הראשונה שלו, הוא ברח, בזמן שהיה משוחרר בערבות וכנראה עזב את העיר כדי לחמוק מהמשפט שלו. המטפל שלו מעולם לא פגש אותו שוב.

תפוצת הפרעת האישיות האנטי-חברתית באוכלוסייה הכללית נאמדת ב־2% עד 3% (Glenn et al., 2013). ההפרעה שכיחה יותר בקרב גברים (כ־3%) מאשר בקרב נשים (כ־1%), אם כי ישנם כמה מחקרים שלפיהם חלקם של הגברים גדול עוד יותר, קרוב ל־5% גברים לכל אישה (Hare et al., 2012). כפי שאפשר לצפות, לאחר שרואים את הקריטריונים האבחנתיים, הפרעת אישיות אנטי-חברתית רווחת ביותר בבתי כלא. כ־47% מהאסירים ו־21% מהאסירות עונים על הקריטריונים לאבחנת אישיות אנטי-חברתית (ראו Glenn et al., 2013).

הקריטריונים של DSM-5

הפרעת אישיות אנטי-חברתית



- | | |
|---|--|
| <p>4. רגזנות ותוקפנות המתבטאים במריבות או בתקיפות פיזיות.</p> <p>5. התעלמות חסרת אחריות מהביטחון של האדם או של זולתו.</p> <p>6. חוסר אחריות עקבי המתבטא בכישלון חוזר ונשנה לשמור על התנהגות מתאימה בסביבת עבודה או לכבד התחייבויות כספיות.</p> <p>7. היעדר חרטה המתבטא באדישות או ברציונליזציה של פגיעה בזולת, יחס לא נאות כלפיו או גניבה ממנו.</p> | <p>א. דפוס נרחב של התעלמות מזכויות הזולת והפרתן המופיע מגיל 15 ומתבטא בשלושה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:</p> <p>1. חוסר יכולת לציית לנורמות חברתיות בהקשר של התנהגויות בתחום החוק המתבטא בפעולות חוזרות שהן עילה למעצר.</p> <p>2. רמאות המתבטאת בשקרים חוזרים, בהתחזות או בהונאת אחרים למטרת רווח או תענוג אישי.</p> <p>3. אימפולסיביות או היעדר תכנון.</p> |
|---|--|

- ב. האדם בן 18 לפחות.
 ג. ישנן ראיות להפרעת התנהגות שהחלה לפני גיל 15.
 ד. ההתנהגות האנטי-חברתית אינה מופיעה רק במהלך סכיזופרניה או הפרעה דו-קוטבית.

מקור: צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (copyright 2013). American Psychiatric Association.

לעיתים קרובות מבלבלים בטעות בין המונחים הפרעת אישיות אנטי-חברתית ופסיכופתיה. אומנם יש חפיפה מסוימת בין הפרעת אישיות אנטי-חברתית ובין פסיכופתיה, אך הן אינן היינו הך. הקריטריונים הנוכחיים ב-DSM לאבחנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית שמים דגש חזק על התנהגויות הניתנות לצפייה כגון שקרנות, הסתבכות בסכסוכים או חוסר יכולת לכבד התחייבויות כספיות. לעומת זאת, המושג פסיכופתיה מפנה תשומת לב רבה יותר למאפייני אישיות כגון קסם אישי מלאכותי, היעדר אמפתיה ומניפולטיביות. בשל הבלבול הרב בין הפרעת אישיות אנטי-חברתית ובין פסיכופתיה ומכיוון ששתי התופעות מהוות נטל כבד על החברה שלנו, נחזור ונדון בהן ביתר פירוט בהמשך הפרק.

גורמים סיבתיים

על פי המחקר, לגנים יש תפקיד בהפרעת אישיות אנטי-חברתית ובפשיעה. במחקרים רבים נערכו השוואות של שיעורי התאמה בין זוגות תאומים זהים ולא זהים. באחרים השתמשו בשיטת האימוץ, והשוו שיעורי פשיעה של ילדים מאומצים מהורים שהם פושעים עם שיעורי הפשיעה של ילדים מאומצים מהורים שאינם עבריינים. לפי התוצאות של שני סוגי המחקרים קיים מרכיב תורשתי מסוים בהתנהגות אנטי-חברתית או פושעת (Carey & Goldman, 1997; Hare et al., 2012; Sutker & Allain, 2001; Waldman, 2006). עם זאת, עדיין לא ברור מהו הדבר שעובר בתורשה. אולי זו אימפולסיביות, רמות נמוכות של חרדתיות, נטיות תוקפניות או צירוף של כל אלה עם נטיות אחרות.

גורמים סביבתיים רבים מעורבים גם הם בהתפתחות הפרעת אישיות אנטי-חברתית. הגורמים הללו כוללים הכנסה משפחתית נמוכה, חיים בשכונות עירוניות צפופות, פיקוח הורי לקוי, אם צעירה, חיים במשפחה חד-הורית, קונפליקט בין ההורים, אח עברייני, הזנחה, משפחה גדולה וגם משמעת נוקשה מצד ההורים (Farrington, 2006; Granic & Patterson, 2006). גורמים סביבתיים חשובים אחרים שאינם משותפים (אינם משותפים מכיוון שלא כל הילדים במשפחה בהכרח מתנסים בהם) הם חברים עבריינים, התעללות גופנית או מינית והתנסויות לימודיות או חברתיות שונות. חוקרים גם מציינים כי השפעות חברתיות אלה מקיימות אינטראקציה עם נטיות גנטיות מוקדמות (יחסי גומלין גנוטיפ-סביבה), וזו קובעת אילו אנשים יעשו פושעים או בעלי אישיות אנטי-חברתית (Carey & Goldman, 1997; Hare et al., 2012; Moffitt, 2005). ואכן, כפי הנראה כך קורה, על פי העלייה הדרמטית בפשיעה בארצות הברית ובבריטניה מאז 1960 ושיעור מקרי הרצח בארצות הברית הגדול פי עשרה משיעורם בבריטניה (Rutter, 1996).

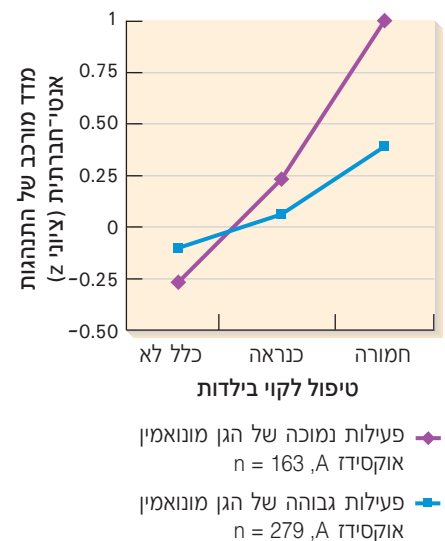
א-אפשר להסביר ממצאים כאלה באמצעות גורמים גנטיים בלבד אלא חייב להיות שילוב של גורמים סביבתיים פסיכו-חברתיים וחברתיים-תרבותיים.

במחקר המעולה של קדורט ועמיתיו (Cadoret et al., 1995; ראו גם Riggins- Caspers et al., 2003) נמצא כי ילדים להורים ביולוגיים עם הפרעת אישיות אנטי-חברתית שנמסרו לאימוץ היו בסיכון גבוה לפתח אישיות אנטי-חברתית אם הוריהם המאמצים חשפו אותם לסביבה עוינת, יותר מילדים שהוריהם המאמצים חשפו אותם לסביבה נורמלית. בסביבות עוינות היו כמה מאפיינים אפשריים: עימותים בין ההורים או גירושין, הסתבכות עם רשויות החוק ופסיכופתולוגיה הורית. ממצאים דומים של יחסי גומלין גנים-סביבה נמצאו גם בתאומים שהיו בסיכון גבוה או נמוך להפרעת התנהגות (בדרך כלל זהו סמן ראשוני בילדות של הפרעת אישיות אנטי-חברתית). במחקר זה, גורם הסיכון הסביבתי היה טיפול פיזי לקוי (Jaffee et al., 2005).

מחקר רב השפעה על יחסי הגומלין גנים-סביבה בהפרעת אישיות אנטי-חברתית זיהה גן מועמד שנראה חשוב (Caspi et al., 2002). הגן, הידוע כמונואמין אוקסידז A (*MAOA gene – Monoamine Oxidase A gene*), מעורב בפירוק נוירורנסמיטרים כגון נוראפינפרין, דופמין וסרוטונין – כולם נוירורנסמיטרים המושפעים מעקה עקב טיפול לקוי, שיכולה להוביל להתנהגות אלימה (ראו **תרשים 10.1**). במחקר זה עקבו אחרי יותר מאלף ילדים מהלידה עד גיל 26. נמצא כי אנשים עם פעילות נמוכה של הגן מונואמין אוקסידז A היו נתונים בסיכון גבוה יותר לאין ערוך לפתח הפרעת אישיות אנטי-חברתית אם עברו טיפול לקוי בילדותם מאשר אנשים עם פעילות גבוהה של מונואמין אוקסידז A שעברו טיפול לקוי בילדותם, וגם מאנשים עם פעילות נמוכה של מונואמין אוקסידז A שלא עברו טיפול לקוי בילדותם. הממצא הבסיסי על האינטראקציה בין מונואמין אוקסידז A לבין הסביבה (יחסי גומלין גן-סביבה) חזר על עצמו במספר גדול של מחקרים (ראו Foley et al., 2004; Kim-Cohen et al., 2006).

הקשר בין התנהגות אנטי-חברתית ובין שימוש מזיק בחומרים חזק דיו עד כי היו שתיהן אם קיים אולי גורם משותף המוביל הן לאלכוהוליזם והן לאישיות אנטי-חברתית. תמיכה בהשערה זו מגיעה מהמחקר, שלפיו ישנה מעורבות גנטית משמעותית ברמת התחלואה הנלווית בין שתי התופעות (Krueger et al., 2002; Slutske et al., 1998; Taylor & Lang, 2006). יתרה מזו, באחד המחקרים נמצא כי הפרעת אישיות אנטי-חברתית והפרעות מוחצנות נוספות (כגון תלות באלכוהול ובסמים והפרעת התנהגות) שותפות כולן לפגיעות גנטיות דומה. לגורמים סביבתיים נודעה חשיבות רבה יותר בקביעת סוג ההפרעה שאדם מסוים יפתח (Hicks et al., 2004; Krueger et al., 2007).

קשה כמובן לקבוע במדויק את התרומה היחסית של השפעות גנטיות וסביבתיות על הפרעת אישיות אנטי-חברתית, וזאת מכמה סיבות. ייתכן כי אנשים אנטי-חברתיים קיבלו את הגנים שלהם מהורים אנטי-חברתיים. במקרים כאלה, אפשר שההורים גם חושפים את הילד לסביבה ביתית שעשויה להיות מודל לפשיעה



תרשים 10.1

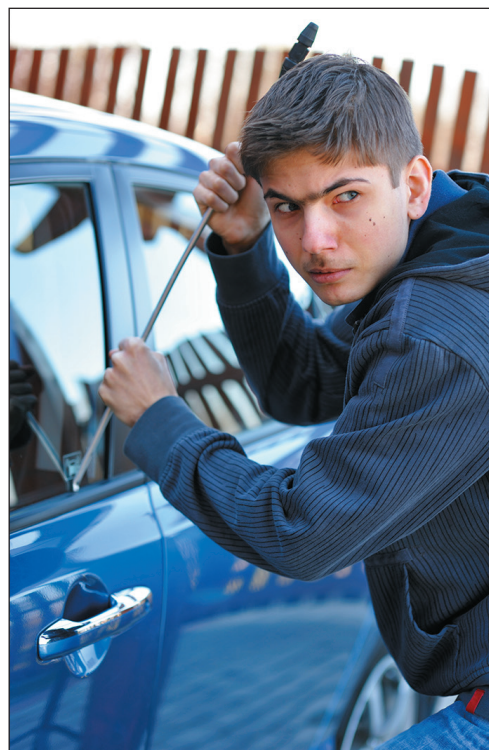
מומצעים במודל מורכב של התנהגות אנטי-חברתית כפונקציה של פעילות גבוהה או נמוכה של מונואמין אוקסידז A ושל היסטוריה של טיפול לקוי בילדות.

(גוטט באישור של Caspi et al. (2002), *Science*, 297, 851-854. copyright © 2002 AAAS)

או להכיל גורמי סיכון כגון התעללות, הזנחה, פרידות של ההורים, אלימות וגורמים רבים נוספים. ילד עם נטייה גנטית להתנהגות אנטי-חברתית עשוי לעורר בעיות אצל אנשים אחרים בגלל התנהגותו (מצב הידוע כקשר מעורר גן-סביבה – evocative gene-environment correlation). גורמים סביבתיים כאלה שהילד מעורר, עשויים לכלול קונפליקט זוגי, עלייה בבעיות בריאות הנפש אצל ההורים או הנהגת משמעת נוקשה מצידם (Jackson & Beaver, 2015). במילים אחרות, הקשרים בין הסביבה המשפחתית לבין התנהגות אנטי-חברתית הם מסובכים. קשה להתיר סבך של השפעות גנטיות והשפעות סביבתיות. החשיבות היחסית של שני סוגי ההשפעות הללו עשויה אף היא להשתנות במהלך ההתפתחות. כפי שהורים משפיעים על ילדיהם, כך יש לראות בילדים סוכנים המסוגלים לעצב דינמיקה משפחתית. במילים אחרות, מודלים סיבתיים דו-כיווניים של גורמים מחליפים כיום מודלים פשוטים חד-כיווניים (למשל מהמשפחה אל הילד).

השקפה התפתחותית

שורשיה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית נטועים בילדות, בייחוד אצל בנים. מספר ההתנהגויות האנטי-חברתיות הנצפות בילדות הוא המנבא היחיד הטוב ביותר של מי יפתח בבגרותו הפרעת אישיות אנטי-חברתית, וככל שהגיל שבו הבעיות מתחילות צעיר יותר כך הסיכון גבוה יותר (Robins, 1978, 1991). במחקרים פרוספקטיביים נמצא כי ילדים עם הפרעת התנגדות, המאופיינת בדפוס התנהגות עוין ומתריס כלפי דמויות סמכות שלרוב מתחיל עד גיל 6 ובעקבותיו מופיעה בסביבות גיל 9 הפרעת התנהגות, הם הילדים הנתונים בסיכון הגבוה ביותר לפתח בבגרותם הפרעת אישיות אנטי-חברתית (Lahey et al., 2005, למשל).



ילדים ומתבגרים המציגים דפוס קבוע של תוקפנות כלפי בני אדם או בעלי חיים, השחתת רכוש, רמאות או גניבות והפרה חמורה של חוקים בבית או בבית הספר עשויים להימצא בסיכון להתפתחות של הפרעת התנהגות והפרעת אישיות אנטי-חברתית.

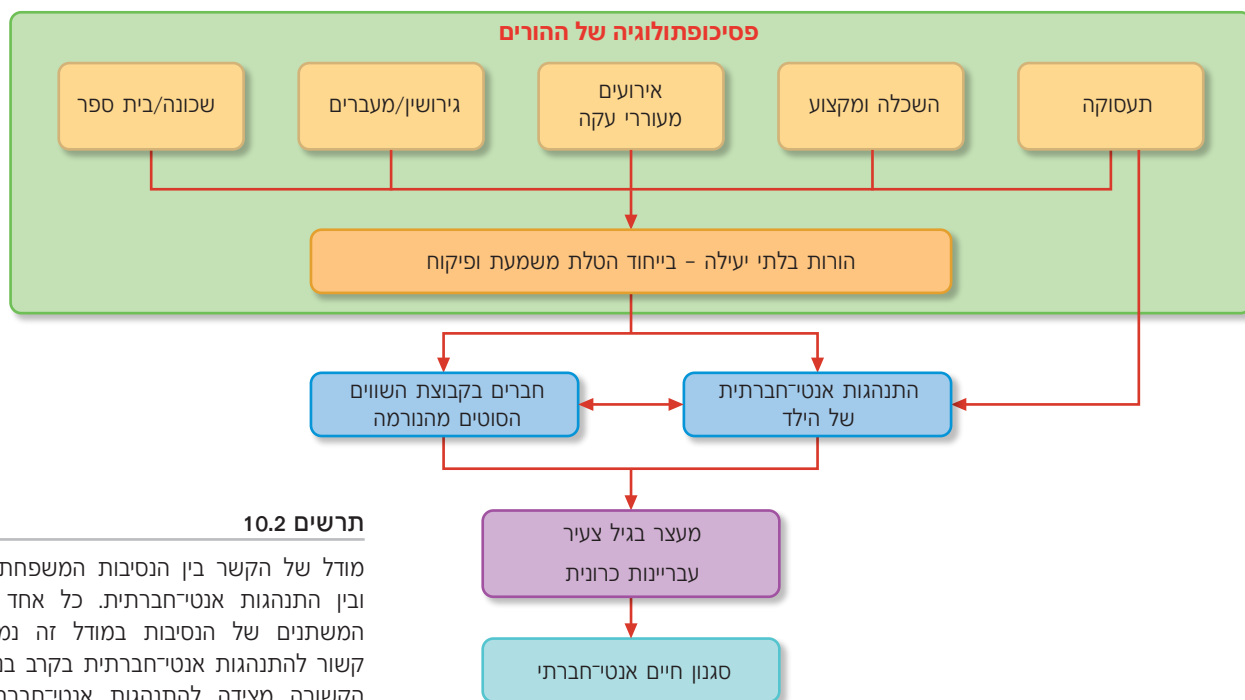
האבחנה המוקדמת השנייה שהיא לעיתים קרובות סמן ראשוני של הפרעת אישיות אנטי־ חברתית אצל אדם בוגר היא הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHA – Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder). הפרעה זו מאופיינת בהתנהגות קצרת רוח, לא קשובה ואימפולסיבית, משך קשב קצר ומוסחות (ראו פרק 15). כאשר הפרעת קשב והיפראקטיביות מתקיימת בד בבד עם הפרעת התנהגות (מצב שקורה ב־30% עד 50% מן המקרים לפחות), אזי יש הסתברות גבוהה שהאדם יפתח צורה תוקפנית מאוד של הפרעת אישיות אנטי־ חברתית וייתכן שגם פסיכופתיה, שבה נדון מיד (Abramowitz et al., 2004; Lahey et al., 2000; Patterson et al., 2005).

לסיכום, הולכות ומצטברות ראיות לכך שנטיות גנטיות לבעיות נוירופסיכולוגיות מתוונות כגון אלה המובילות להיפראקטיביות או לקשיי קשב, יחד עם מזג קשה, עשויות להיות גורמים משפיעים חשובים בהקשר של הפרעת התנהגות המופיעה מוקדם, העשויה פעמים רבות להוביל להפרעת אישיות אנטי־ חברתית לכל החיים אצל האדם הבוגר. לבעיות ההתנהגות שנטיות מוקדמות אלה יוצרות יש שרשרת של השפעות שהולכות ומתפשטות במרוצת הזמן. לדוגמה, על בסיס מחקר אורך פרוספקטיבי, מופיט, כספי ועמיתיהם (Moffitt, Caspi et al., 2002; Moffitt, 2006) העלו טענה:

התנהגות אנטי־ חברתית "לכל החיים" מתהווה בגיל צעיר, כאשר ההתנהגות הקשה של ילד צעיר בסיכון גבוה מוחמרת על ידי סביבה חברתית עם סיכון גבוה. לפי התיאוריה, הסיכון שבו הילד נתון נובע משונות נוירופסיכולוגית תורשתית או נרכשת, המופיעה בתחילה כליקויים קוגניטיביים קלים, מזג קשה או היפראקטיביות. הסיכון הסביבתי מורכב מגורמים כגון הורות לקויה, קשרי משפחה משובשים ועוני. מרחב הסיכון הסביבתי מתרחב אל מעבר למשפחה ככל שהילד גדל, וכולל יחסים גרועים עם אנשים כמו בני קבוצת הגיל ומורים ומאחר יותר עם בני זוג ומעסיקים בעבודה. במהלך עשרים שנות ההתפתחות הראשונות, יחסי הגומלין בין האדם והסביבה בונים בהדרגה אישיות שיש לה הפרעה עם התכונות האופייניות של אלימות פיזית והתנהגות אנטי־ חברתית הנמשכות עד אמצע החיים (Moffitt et al., 2002, p. 180).

בתרשים 10.2 אפשר לראות מודל מתווך המתאר כיצד כל זה מתרחש. אך כיצד בדיוק שונות גנטית ועקה סביבתית פועלות יחד לסלול את הדרך לבעיות מאוחרות יותר? עדיין מוקדם להסיק מסקנות מוצקות. עם זאת, קרוב לוודאי שלבעיות בהתפתחות המוח יש תפקיד בעניין. לדוגמה, יש הסבורים כי שונות בגן מונואמין אוקסידז A, שתואר לעיל, עשויה לשנות את רמות הסרוטונין במהלך ההתפתחות. זה מצידו עשוי להעמיד בסיכון את מבנה המוח, את תפקודו ואת יכולת הקישוריות שלו ככל שהאדם מתבגר (Buckholtz & Meyer-Lindenberg, 2014). כמו כן ידוע שאצל אנשים אנטי־ חברתיים ישנם ליקויים הן במבנה הקורטקס הקדם־מחכי והן בתפקודו (Yang & Raine, 2009) אם כי מקורותיהם של ליקויים אלה אינם ברורים לפי שעה. למרות זאת, לנוכח התפקיד החשוב שאזור מוח חשוב זה ממלא בקבלת החלטות ובשליטה על ההתנהגות ועל הרגשות, היינו מצפים שאנשים עם

ליקויים בתפקוד באזור זה יציגו קשת שלמה של התנהגויות לא חכמות ואנטי-חברתיות (ראו Buckholtz, 2015). כמובן, אנו עדיין רחוקים מאוד מהשלמת כל חלקי הפאזל בשלב זה. אך עם זאת, הקשרים בין גנים, התנסויות סביבתיות שליליות, התפתחות המוח ויכולתו של האדם לנהוג באופן חברתי או אנטי-חברתי מציעים לנו מסלולי מחקר מרתקים בעתיד.



תרשים 10.2

מודל של הקשר בין הנסיבות המשפחתיות ובין התנהגות אנטי-חברתית. כל אחד מן המשתנים של הנסיבות במודל זה נמצא קשור להתנהגות אנטי-חברתית בקרב בנים, הקשורה מצידה להתנהגות אנטי-חברתית במבוגרים. התנהגות אנטי-חברתית בקרב בנות שכיחה הרבה פחות, ובמרוצת הזמן היא גם פחות יציבה ולכן קשה יותר לנבא אותה.

מקור: Capaldi & Patterson, 1994. Interrelated influences of contextual factors on antisocial behavior. In D. C. Fowles et al. (Eds.), *Progress in Experimental Personality and Psychopathology Research*. Springer Publishing Company.

הפרעת אישיות גבולית
BPD – Borderline Personality
(Disorder)

הפרעת אישיות גבולית

למונח אישיות גבולית יש היסטוריה ארוכה ומבלבלת למדי (Hooley et al., 2012). במקור, הוא שימש לתיאור מטופלים שההתמודדות איתם הייתה מאתגרת ושמצבם נחשב "על הגבול" בין נירוטיות לפסיכוטיות. מאוחר יותר השתמשו בו כדי לתאר מטופלים עם מאפיינים של סכיזופרניה (כמו בסכיזופרניה גבולית). בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת, ההיבטים הקליניים העיקריים של **הפרעת אישיות גבולית** הובהרו דיים כדי להיכנס ל-DSM כאבחנה בפני עצמה. כיום זוהי הצורה הנחקרת ביותר של פתולוגיה של האישיות. אומנם שם הפרעה כשלעצמו אינו מספק מידע רב (ב-ICD-10 משתמשים במונח הפרעת חוסר יציבות רגשית), אך הפרעת אישיות גבולית היא מצב קליני מרתק. הלוקים בה סובלים סבל רב והמטפלים לא תמיד מבינים אותה כהלכה ולעיתים מצמידים לה תווית שלילית.

דפוס ההתנהגות של אנשים עם הפרעת אישיות גבולית מתאפיין באימפולסיביות ובחוסר יציבות ביחסים בין-אישיים, בדימוי העצמי ובמצבי הרוח שלהם. מאפיין

מרכזי הוא חוסר יציבות רגשית שמתבטא בתגובות רגשיות עוצמתיות במיוחד לגירויים סביבתיים וחזרה איטית למצב הרגשי ההתחלתי. חוסר יציבות רגשית מתאפיין גם בתנודות חדות ומהירות מרגש אחד לאחר (Livesley 2008; Paris, 2007). חוסר יציבות רגשית מתחבר לתחושת עצמי או לדימוי עצמי מאוד לא יציבים. לבעלי הפרעת אישיות גבולית יש תחושות תמידיות של ריקנות והם מתקשים לגבש תחושה של מי הם באמת. הם גם עושים מאמצים גדולים להתמודד עם מושג עצמי שלילי ביותר ומתקשים להיות לבד.

לנוכח חוסר היציבות הרגשית שלהם המשולב עם דימוי עצמי בלתי יציב, אין פלא שמערכות היחסים הבין-אישיות של אנשים עם הפרעת אישיות גבולית הן כל כך בלתי יציבות. מערכות היחסים האלה נוטות להיות עוצמתיות אך סוערות, והן מתאפיינות בדרך כלל באידיאליזציה מוגזמת של החבר או האהוב (או אפילו של המטפל) ומסתיימות בהתפכחות מרירה, באכזבה ובכעס (Gunderson et al., 1995; Lieberman et al., 2004). אחת הבעיות היא שאנשים עם הפרעת אישיות גבולית חוששים מאוד מנטישה. ייתכן שזו הסיבה שהם קשובים כל כך לסימני דחייה וממהרים לפרש התנהגות של אנשים אחרים כדחייה (Staeble et al., 2011). ממחקרים עולה גם שאנשים עם הפרעת אישיות גבולית מיומנים מאוד בזיהוי (מדויק) של סימני כעס בהבעות פניהם של אחרים. עם זאת, כאשר מציגים להם הבעות פנים ניטרליות הם נוטים לתפוס אותן בטעות כהבעות של כעס (Veague & Hooley, 2014). אפשר שבגלל הפחד שלהם מדחייה, אנשים עם הפרעת אישיות גבולית לעיתים קרובות "בוחנים" את מערכות היחסים הקרובות שלהם. כל כישלון של הזולת נהפך לראיה לדחייה או לנטישה הממשמשת ובאה. המחקר תומך בקיומו של קשר סיבתי בין תפיסה של דחייה לבין זעם בלתי נשלט בהפרעת אישיות גבולית (Berenson et al., 2011).



אנשים עם הפרעת אישיות גבולית מאמצים לעיתים קרובות התנהגויות המכוונות להרס עצמי, לרבות חתכים וצורות אחרות של פגיעה עצמית. אך לא כל מי שעוסק בפגיעה עצמית סובל מהפרעת אישיות גבולית. ב-DSM-5 נוספה באופן זמני הפרעה בשם הפרעת פגיעה עצמית לא אובדנית כהפרעה שנדרשים לה מחקרים נוספים.

חשיבה ביקורתית על DSM-5

פגיעה עצמית לא אובדנית: הפרעה בפני עצמה או תסמין של הפרעת אישיות גבולית?



בפגיעה עצמית לא אובדנית נתונים בסיכון גבוה להתאבדות מאוחר יותר, מדאיגה מאוד (Wilkinson et al., 2011). לנוכח הדברים האלה, צוות העבודה של DSM-5 נדרש להחליט אם לקבוע לאנשים המציגים התנהגות של פגיעה עצמית משמעותית לא אובדנית אבחנה של הפרעה חדשה בשם הפרעת פגיעה עצמית לא אובדנית.

הפרעת פגיעה עצמית לא אובדנית מופיעה אצל גברים ואצל נשים כאחת וכן אצל בני אדם מכל הקבוצות האתניות ומרקעים כלכליים שונים. נראה כי הסיכון ללקות בהפרעה גבוה יותר בגיל ההתבגרות, עם שיעורי תפוצה במהלך חיים

פגיעה עצמית לא אובדנית (NSSI – Nonsuicidal Self-Injury) כוללת גרימת נזק מכוונת לרקמות גוף כפי שיכול לקרות מחיתוך או מצריבת העור (Nock, 2009). התנהגות זו (המכונה לפעמים חבלה עצמית קשה [self mutilation]) מתרחשת ללא כוונה למות (ומכאן המונח לא אובדנית). התנהגות של חבלה עצמית קשה נכללה זמן רב ב-DSM כתסמין של הפרעת אישיות גבולית. אך אנשים רבים המתנסים בפגיעה עצמית אינם לוקים בהפרעת אישיות גבולית, אם כי הם מדווחים על רמות גבוהות של תסמינים דיכאוניים, חרדה, אובדנות ובאופן כללי רמות תפקוד נמוכות (Selby et al., 2012). העובדה שאנשים שעוסקים

170 p). אולי יש בכך כדי להסביר מדוע אנשים כאלה בוחרים לווסת את רגשותיהם באמצעות התנהגויות של פגיעה עצמית ולא באמצעות אסטרטגיות התמודדות בריאות יותר כגון שיחה עם חבר או ריצה.

הפרעת פגיעה עצמית לא אובדנית היא בעיה הולכת וגדלה ולכן היא התווספה כעת ל-DSM-5. ההפרעה מופיעה בחלק III כמצב המצריך מחקר נוסף. הצעד הזה צפוי לעודד עריכת מחקרים חדשים. כשנלמד יותר, נהיה בעמדה טובה יותר להבין את ההפרעה הזו שתפוצתה הולכת וגדלה, לטפל בה ואולי אפילו למנוע אותה.

של כ-17% (Swannell et al., 2014). עם זאת, שיעורי התפוצה גבוהים גם בקרב בוגרים צעירים (13%) וגם בקרב מבוגרים, ששיעורי התפוצה הקהילתיים אצלם הם כ-5%.

מדוע בני אדם פוגעים בעצמם באמצעות חתכים או צריבה? הקלת מתח היא אחד ההסברים השכיחים. לעיתים קרובות הפרעת פגיעה עצמית לא אובדנית משמשת לוויסות רגשות עזים או שליליים. הולי, הו ועמיתיהן (Hooley, Ho et al., 2010) גם מצאו כי סבולת הכאב של בני אדם שפוגעים בעצמם גבוהה יותר משל אחרים. כמו כן, יש להם סגנון קוגניטיבי של ביקורת עצמית חזקה והם "עשויים לראות בסבל ובכאב דבר שמגיע להם" (Hooley, Ho et al., 2010).

תכונה חשובה נוספת של הפרעת אישיות גבולית היא אימפולסיביות, המאופיינת בתגובה מהירה לגירויים סביבתיים ללא חשיבה על התוצאות לטווח ארוך (או דאגה מהן) (Paris, 2007). רמות האימפולסיביות הגבוהות המשולבות עם חוסר היציבות הרגשית הקיצוני של הלוקים בהפרעה מובילות לעיתים להתנהגויות בלתי צפויות של פגיעה עצמית, כגון התנהגות מינית מסוכנת, או נהיגה חסרת אחריות. גם ניסיונות התאבדות אינם נדירים כלל ועיקר. במדגמים שנערכו בקהילה, כמעט רבע מן האנשים עם אבחנה של הפרעת אישיות גבולית מדווחים שהיה להם לפחות ניסיון התאבדות אחד (Pagura et al., 2010). במדגמים קליניים השיעור אפילו גבוה יותר (כ-35%) (ראו Asnaani et al., 2007). יתרה מזו, אומנם לעיתים הניסיונות הללו נחשבים מניפולטיביים, אך יש להתייחס אליהם ברצינות רבה כיוון ש-8% עד 10% מהלוקים בהפרעת אישיות גבולית שמים קץ לחייהם בהתאבדות עצמי חוזר (היא מאפיין נוסף של אישיות גבולית. עם זאת, כפי שאפשר לראות במסגרת "חשיבה ביקורתית על DSM-5", רבים מהאנשים הגורמים לעצמם פגיעה בכוונה תחילה אינם בעלי אישיות גבולית. הקריטריונים לאבחנה של הפרעת אישיות גבולית מפורטים במסגרת "הקריטריונים של DSM-5". הם גם מומחשים היטב בתיאור המקרה של ר').

ר': הפרעת אישיות גבולית

ר' היא בת 19. אין לה היסטוריה רשמית של טיפול פסיכיאטרי אך היא מדווחת על היסטוריה ממושכת של מצב רוח לא יציב, התנהגות אובדנית וחיתוך עצמי של העור. כמו כן היו לה כמה וכמה מערכות יחסים סוערות, לרבות התעללות פיזית ושלוש הפלות. היא אושפזה לראשונה אחרי שאיימה להרוג את עצמה בעקבות ריב עם החבר שלה ותאונה עם המכונית המשפחתית. המטופלת מספרת שלאחרונה עזבה את בית משפחתה ועברה לגור עם החבר שלה. אחרי ריב איתו, שהשאיר אותה עם שפה מדממת, היא

הרגישה "מדוכאת". היא חזרה הביתה והתחילה לריב עם אימה. ר' גנבה את המכונית המשפחתית והתרסקה לתוך עמוד. לשכן שמצא אותה היא אמרה שהיא עומדת להרוג את עצמה. בשל כך אימה הביאה אותה לבית החולים. עם אשפוז, ר' אמרה שהיא "מדוכאת" ואובדנית. היא תוארה ככעסנית, חושבת שהכול מגיע לה, מניפולטיבית ו"בנסיגה". היא קיבלה אבחנה של הפרעת אישיות גבולית ונרשמו גם תכונות נרקסיסטיות (מתוך Avery et al., 2012).

הקריטריונים של DSM-5 הפרעת אישיות גבולית



5. התנהגות, סימנים או איומים חוזרים הקשורים בהתאבדות או התנהגות של חבלה עצמית קשה.
 6. חוסר יציבות רגשית עקב תגובתיות בולטת במצב הרוח (למשל אפיזודות אינטנסיביות של דיספוריה,* עצבנות או חרדה הנמשכים לרוב שעות אחדות ובמקרים נדירים יותר מכמה ימים).
 7. תחושה תמידית של ריקנות.
 8. כעס עז בלתי הולם או קושי לשלוט בכעס (למשל ביטויים תכופים של זעם, כעס תמידי, תגרות ידיים חוזרות).
 9. חשיבה פרנואידית זמנית הקשורה לעקה או תסמיני ניתוק זמניים חמורים.
- דפוס נרחב של חוסר יציבות ביחסים בין-אישיים, בדימוי עצמי וברגשיות, ואימפולסיביות ניכרת המתחיל בבגרות המוקדמת, מתקיים במגוון הקשרים ומתבטא בחמישה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:
1. מאמצים קדחתניים להימנע מנטישה אמיתית או מדומיינת (**הערה:** אין לכלול התנהגות אובדנית או חבלה עצמית קשה המתוארות בקריטריון 5).
 2. דפוס של יחסים בין-אישיים אינטנסיביים ובלתי יציבים המאופיין במעברים קיצוניים בין אידיאליזציה קיצונית של זולתם לבין הפחתה קיצונית בערכו.
 3. הפרעת זהות: דימוי עצמי או תחושת עצמי בלתי יציבים באופן בולט ועקבי מאוד.
 4. אימפולסיביות לפחות בשני תחומים עם פוטנציאל לנזק עצמי (למשל בזבז כסף, מין, שימוש מזיק בחומרים, נהיגה חסרת אחריות, אכילה בולמוסית) (**הערה:** אין לכלול התנהגות אובדנית או של חבלה עצמית קשה המתוארות בקריטריון 5).
- מקור:** צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (copyright 2013). American Psychiatric Association.
- * דיספוריה (dysphoria): מצב רוח של חוסר שביעות רצון או אי-נוחות משמעותיים.

מלבד התסמינים של התנהגות רגשית ואימפולסיבית, ל-75% מהלוקים בהפרעת אישיות גבולית יש גם תסמינים קוגניטיביים. התסמינים כוללים אירועים קצרים יחסית או חולפים שבהם נראה כי הם מנותקים מן המציאות והם חווים תסמינים דמויי תסמינים פסיכוטיים כגון הזיות, מחשבות פרנואידיות או תסמיני ניתוק

חמורים (Lieb et al., 2004; Skodol, Gunderson, et al., 2002). הסבירות גבוהה שאירועים פסיכויים קצרים אלה יתרחשו בעת לחץ אם כי הם מתרחשים גם בזמנים אחרים (Stiglmayr et al., 2008). לנוכח התסמינים הרבים והמגוונים של הפרעת אישיות גבולית אין פלא שההפרעה יוצרת שיבושים בתפקוד החברתי, הלימודי והתעסוקתי (Bagge et al., 2004; Grant et al., 2008).

מעריכים כי אחוז אחד עד שניים באוכלוסייה מתאימים לאבחנה של הפרעת אישיות גבולית (Lenzenweger et al., 2007). אך הפרעת אישיות גבולית שכיחה מאוד בסביבות קליניות ומגיעה ל-10% אצל מטופלים במרפאות חוץ ול-15% עד 20% בקרב מטופלים פסיכיאטריים מאושפזים (Asnaani et al., 2007; Hooley et al., 2012; Trull, 2015). למרות הממצאים של מחקרים מוקדמים שלפיהם 75% מהאנשים המקבלים אבחנה זו בסביבות קליניות הם נשים, ייתכן כי ההבדלים בין המגדרים נובעים מחוסר איזון ביניהם בפנייה לטיפול ולאו דווקא בשיעורי תפוצת ההפרעה. הדבר מתיישב גם עם מחקרים אפידמיולוגיים חדשים יותר של תושבים בקהילה, שמצביעים על יחס מגדרי דומה (Coid et al., 2009; Grant et al., 2008).

הפרעת אישיות גבולית ותחלואה נלווית

נדיר שהפרעת אישיות גבולית מאובחנת כהפרעה בפני עצמה. לרוב היא מופיעה עם מגוון הפרעות אחרות. אולם הייחודיות של הפרעת אישיות גבולית היא נטייתה להיות נלווית גם להפרעות הפנמה (כגון הפרעות מצב רוח וחרדה) וגם להפרעות החצנה (כגון הפרעות שימוש מזיק בחומרים) (Eaton et al., 2011). במחקר רחב היקף של תושבים בקהילה, הפרעת אישיות גבולית נקשרה יותר מכול להפרעת דיכאון קשה ולמאניה וגם להפרעת פאניקה, אגורפוביה, הפרעת חרדה כללית והפרעת עקה פוסט-טראומטית (Tomko et al., 2014). מעניין מאוד שבמחקר הזה, 85% מהמשתתפים שאובחנה אצלם ההפרעה ענו גם על הקריטריונים להפרעת חרדה בהווה או בעבר, 83% סבלו כל חייהם מהפרעת מצב רוח או מאפיזודה של דיכאון ו-78% ענו על הקריטריונים להפרעת שימוש מזיק בחומרים בעבר או בהווה. בעבר אומנם הציעו לראות בהפרעת אישיות גבולית וריאנט של הפרעת מצב רוח בשל התחלואה הנלווית הגבוהה בינה לבין דיכאון, אך הטווח הרחב של הפרעות אחרות הנלוות להפרעת אישיות גבולית אינו מתאים להצעה זו. יתרה מזו, נתונים של הדמיה מוחית מצביעים על תגובות נוירולוגיות שונות לגירויים רגשיים אצל אנשים עם הפרעת אישיות גבולית לעומת אלה הנצפות אצל הלוקים בדיכאון כרוני (Hooley, Gruber, et al., 2010).

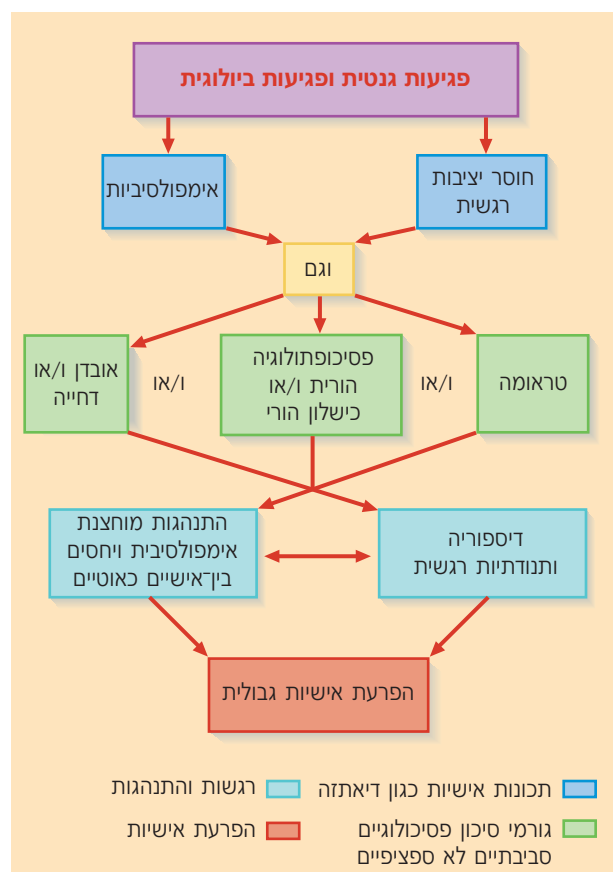
הפרעת אישיות גבולית גם מופיעה פעמים רבות יחד עם הפרעות אישיות אחרות, ובייחוד עם ההפרעות סכיוטיפליות, נרקיסיסטית ותלותית (Tomko et al., 2014). אף שהיא נחשבת כאבחנה קטגורית בפני עצמה ב-DSM-5 (כלומר כישות אבחנתית נפרדת), נוח מאוד לתאר הפרעת אישיות גבולית באמצעות גישה של תכונות פתולוגיות (Few et al., 2015). במונחים של מודל חמשת הגורמים, הפרעת אישיות גבולית מומשגת ככרוכה ברמת נוירוטיות גבוהה, נועם הליכות נמוך, תחושת חובה נמוכה ופתיחות גבוהה לרגשות ולפעולות (חזרו ועיינו בטבלה 10.2).

גורמים סיבתיים

הפרעת אישיות גבולית עוברת בתורשה במשפחות. במחקר המתודולוגי הקפדני ביותר עד כה, נמצא כי הסיכון להפרעת אישיות גבולית גבוה פי ארבעה אצל קרובים ביולוגיים של מטופלים עם ההפרעה מאשר אצל קרובי משפחה של אנשים שלא אובחנה אצלם ההפרעה (Gunderson et al., 2011). כמובן, עלינו לזכור שהעובדה שהפרעה עוברת במשפחה אין פירושה בהכרח שהסיבה היא גנים. עם זאת, במקרה של הפרעת אישיות גבולית יש לנו הרבה סיבות להאמין שהגנים חשובים. אכן, אפשר שהם מסבירים 40% מהשונות בהפרעה (Amad et al., 2014). אולם אין פירוש הדבר שהפרעת אישיות גבולית, כהפרעה, עוברת בתורשה. למעשה, מה שהלוקים בהפרעה כפי הנראה ירשו הם גנים שמקנים רגישות לתכונות אישיות מסוימות כגון נוירוטיות או אימפולסיביות שהן היבטים בולטים של הפרעת אישיות גבולית (Hooley et al., 2012; Paris, 2007). תכונות מורשות אלה גם הן אינן ייחודיות להפרעת אישיות גבולית אלא יש בהן סיכון לטווח של מצבים פסיכופתולוגיים אחרים. הבנת הדברים האלה מסייעת לנו להבין מדוע הפרעת אישיות גבולית מופיעה לעיתים קרובות כל כך בשילוב עם הפרעות אחרות. היא גם מסייעת לנו להבין מדוע אנו רואים הפרעות מצב רוח וחרדה, הפרעות שליטה בדחפים והפרעות אישיות אחרות אצל בני משפחה של אנשים שאובחנה אצלם הפרעת אישיות גבולית (Zanarini et al., 2009).

אולם אילו גנים מעורבים כאן? נכון להיום איננו יודעים בוודאות. עד כה המחקר התמקד בגנים מועמדים הקשורים למערכת הסרוטונין (סרוטונין הוא נוירורנסמיטר הקשור למצבי רוח ולאיימפולסיביות), ולמערכת הדופמין (דופמין מעורב בין היתר בשליטה בדחפים, בקוגניציה, ברגישות לתגמול ובתהליכים נוספים). פורסמו גם שני מחקרים למציאת קשרים שנערכים על פני כל הגנום (מכלול הגנים, genome), (GWAS – Genome-Wide Association Studies) (Lubke et al., 2014; Witt et al., 2014). ואולם, עד כה התוצאות היו מאכזבות ואין בידנו ממצאים עקביים או חד־משמעיים (לסקירה ראו Amad et al., 2014). ייתכן כי הסיבה לכך היא בחלקה שעד כה המחקרים כללו מדגמים קטנים יחסית (למחקר גנטי). בעיה נוספת היא שהפרעת אישיות גבולית היא הפרעה מסובכת והטרופית מאוד מן הבחינה הקלינית ועשויים להיות מעורבים בה מספר גדול מאוד של גנים. סיבה נוספת היא שרק לעיתים רחוקות מביאים בחשבון את השפעתם של גורמים סביבתיים.

לדברים הללו יש חשיבות מכיוון שחוקרים סבורים כי גורמים סביבתיים מסבירים את החלק היחסי הגדול ביותר (55%) מהשונות של תכונות האישיות הגבולית. אנו יודעים גם שגנים משפיעים על מידת הרגישות לגורמי עקה סביבתיים (Caspri et al., 2010). סביר שהתנסויות כאלה והשפעות סביבתיות נוספות יוצרות אינטראקציה עם גנים כדי לקבוע מי יפתח בעיות במועד מאוחר יותר (להצגת מודל אפשרי של דיאטזה-עקה, ראו **תרשים 10.3**). במילים אחרות, במקום לחפש גנים הקשורים להפרעות ספציפיות, ייתכן כי עלינו לחפש גנים העשויים להשתתף בהקניית רגישות מעטה או רבה להיבטים החיוביים והשליליים של סביבתנו (Amad et al., 2014).



תרשים 10.3

תיאוריית הדיאטזה-עקה הרב-ממדית של הפרעת אישיות גבולית

(על פי Paris, 1999)



מחקרים רבים מצביעים על כך שאנשים עם הפרעת אישיות גבולית מדווחים על מספר גדול של אירועים שליליים ואף טראומטיים בילדות. אלה כוללים התעללות והזנחה, פרידה ואובדן.

בהקשר של ההיבטים השליליים, טיפול לקוי בילדות וחוויות קיצוניות אחרות בגיל צעיר נקשרו כבר לפני זמן רב להפרעת אישיות גבולית. שני מחקרים פרוספקטיביים שנערכו בקהילה הראו שמצוקה וטיפול לקוי בילדות מגדילים את הסיכון לפתח הפרעת אישיות גבולית בבגרות (Johnson et al., 1999; Widom et al., 2009). מחקרים אלה מתיישבים עם שפע של מחקרים רטרוספקטיביים המראים שהלוקים בהפרעה זו מדווחים לרוב על מספר גבוה של אירועים שליליים ולעיתים טראומטיים בילדותם. לדוגמה, במחקר רחב על התעללות והזנחה, זנאריני ועמיתיה (Zanarini et al., 1997) דיווחו על תוצאות של ראיונות מפורטים של יותר מ-350 מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית ויותר מ-100 עם הפרעות אישיות אחרות. המטופלים עם הפרעת האישיות הגבולית דיווחו על שיעורי התעללות גבוהים בהרבה מאשר מטופלים עם הפרעות אישיות אחרות (שגם הם היו גבוהים למדי): התעללות רגשית (73% לעומת 51%), התעללות פיזית (59% לעומת 34%) והתעללות מינית (61% לעומת 32%). באופן כללי, כ-90% מהמטופלים עם הפרעת האישיות הגבולית דיווחו על סוג כלשהו של התעללות או הזנחה בילדותם.

מספרים אלה אומנם מרשימים, אך אין לראות במצוקה בילדות גורם סיכון ספציפי רק להפרעת אישיות גבולית. גורם זה מדווח בשיעורים גבוהים יחסית מצד אנשים עם כל הפרעות האישיות האחרות (Hengartner et al., 2013; Moran et al., 2010). מצוקה בילדות קשורה גם לצורות עדינות יותר של בעיות אישיות.

לדוגמה, נמצא כי התעללות רגשית קשורה לכל חמש התכונות של מודל חמשת הגורמים וקשורה לנוירוטיות מוגברת ופתיחות גבוהה יותר, וגם לפחות מוחצנות, נועם הליכות ותחושת חובה (Hengartner et al., 2015). עלינו גם לזכור כי התעללות בילדות כמעט תמיד מתרחשת במשפחות עם מגוון בעיות אחרות, לרבות עוני, בעיות בחיי הנישואין, פרידה של ההורים, הורים המשתמשים בחומרים ואלימות במשפחה. כל זה אינו סותר את הממצאים בדבר שכיחותה הגבוהה של מצוקה בילדות בקרב אנשים עם הפרעת אישיות גבולית. עם זאת, במקום להסתכל על סוגים ספציפיים של טיפול לקוי בילדות, אולי רצוי כי נכיר בכך שחוויות שליליות בילדות מגדילות את הסיכון לפתח מערך של בעיות אישיות, כולל הפרעת אישיות גבולית, אך לא רק אותה.

אם כך, כיצד ניטיב להבין את הסיבות להפרעת אישיות גבולית? בעת הזו, הגיוני לטעון שיש אנשים שבשל הנטייה הגנטית המוקדמת שלהם, עשויים להיות רגישים מאוד להשפעות של חוויות שליליות בילדותם. התנסויות מלחיצות מוקדמות אלה עלולות ליצור חוסר ויסות ארוך טווח של ציר ההיפותלמוס-יותרת המוח-יותרת הכליה (שעליו למדתם בפרק 5) ולעצב את התפתחות המוח, ובתוך כך אולי לפגוע במעגלי מוח עיקריים המעורבים בוויסות רגשות (ראו, Hooley et al., 2012). לפי מחקרים שבהם השתמשו בהדמיה מוחית, הפרעת אישיות גבולית קשורה לפעילות מוגברת של האמיגדלה במצבים המעוררים רגשות ולהפחתה בוויסות הקדם-מצחי (Leichsenring et al., 2011). אך הסיבות להתפתחות הבעיות האלה בתפקוד המוח עדיין אינן ידועות. אנו טוענים, אם כי רק כהשערה בשלב זה, שגורמים גנטיים יכולים ליצור אינטראקציה עם חוויות שליליות בילדות וכך נוצרות בעיות במעגלים העצביים המעורבים בוויסות מצב הרוח, החשיבה וההתנהגות. השערה זו עוזרת לנו להסביר מדוע תחומי תפקוד רבים כל כך מושפעים בהפרעת אישיות גבולית ומדוע אנשים הלוקים בה מתקשים כל כך לשלוט ברגשותיהם.

שאלת חזרה



■ תארו את הפרעות האישיות באשכול B והבחינו ביניהן: היסטריזם, נרקיסיסטית, אנטי-חברתית וגבולית.

הפרעות אישיות מאשכול C

יעד לימוד 10.5 למנות את שלוש הפרעות האישיות באשכול C ולתאר את המאפיינים הקליניים העיקריים של כל אחת מהן.

אצל אנשים עם הפרעות אישיות מאשכול C נראה לעיתים קרובות חרדה ופחדנות. אלה הם מאפיינים שאיננו רואים בשני האשכולות האחרים. בסעיפים שלהלן נבחן את הפרעות האישיות נמנעת, תלותית וטורדנית-כפייתית.

הפרעת אישיות נמנעת

הפרעת אישיות נמנעת
(avoidant personality disorder)

הלוקים בהפרעת אישיות נמנעת מציגים עכבה חברתית ומופנמות קיצוניות המוליכות לדפוסים של יחסים חברתיים מוגבלים וחוסר רצון להיכנס לאינטראקציות חברתיות למשך כל חייהם. בגלל רגישותם היתרה לביקורת כלפיהם ולחוסר הערכה כלפיהם ובשל החשש שלהם ממצבים אלה, אנשים עם הפרעת אישיות נמנעת אינם מחפשים את חברתם של בני אדם אחרים. למרות זאת, הם משתוקקים לחיבה ולעיתים קרובות חשים בדידות ושעמום. שלא כאנשים עם אישיות סכיזואידית, בעלי הפרעת אישיות נמנעת אינם נהנים מבדידותם. הם רוצים לקיים קשר עם בני אדם אחרים אך אייכולתם לקיים קשר נינוח עם זולתם גורמת להם חרדה רצינית. בסביבות חברתיות הם מודעים לעצמם עד כאב ומרבים בביקורת עצמית. לא מפתיע שהפרעת אישיות נמנעת מקושרת פעמים רבות לדיכאון (Grant, Hasin, et al., 2005; Sanislow et al., 2012).

תחושת חוסר התאמה והיעדר כשירות חברתית הם שני המאפיינים השכיחים והיציבים ביותר בהפרעת אישיות נמנעת (McGlashan et al., 2005). חוקרים גם דיווחו כי אצל אנשים עם הפרעה זו נראה יותר ביישנות כללית והימנעות ממצבים ומרגשות חדשים רבים (כולל רגשות חיוביים) וליקויים ביכולתם לחוות הנאה (Taylor et al., 2004). ההפרעה מאובחנת יותר אצל נשים, ותפוצתה היא בסביבות 2% עד 3%.



אדם עם הפרעת אישיות נמנעת משתוקק למגע חברתי אך נמנע ממנו בשל חשש מדחייה.

הספרנית הנמנעת

סאלי, ספרנית בת 35, חיה בבדידות יחסית. היו לה מעט מכרים ולא היו לה חברים קרובים. מאז ילדותה, הייתה סאלי ביישנית ומסוגרת מאוד והיא התרחקה מקשרים הדוקים עם אחרים כדי לא להיחשף לפגיעה או לביקורת. שנתיים לפני תחילת הטיפול היא קבעה עם מכר שפגשה בספרייה

ללכת למסיבה. ברגע שהגיעו למסיבה, סאלי חשה אי־נוחות קיצונית משום שלא הייתה "לבושה כמו שצריך". היא הסתלקה במהירות וסירבה לפגוש שוב את המכר.

בפגישות הטיפול הראשונות, סאלי ישבה ושמרה על שתיקה רוב הזמן כיוון שהתקשתה לדבר על עצמה. אחרי כמה פגישות, היא פיתחה אמון במטפל וסיפרה על תקריות אחדות בילדותה, שבהן הייתה "הרוסה" מהתנהגותו הדוחה של אביה האלכוהוליסט בפרהסיה. היא ניסתה להסתיר מחבריה בבית הספר את הבעיות המשפחתיות שלה, אך כאשר הדבר שוב לא היה אפשרי היא הגבילה את קשרי החברות שלה וכך גוננה על עצמה מפני אפשרות של מבוכה או ביקורת.

בתחילת הטיפול, סאלי נמנעה מלפגוש אנשים אלא אם הייתה בטוחה שהם "יחבבו אותה". בעזרת טיפול שהתמקד בחיזוק האסרטיביות והמיומנויות החברתיות שלה, הצליחה סאלי להתקדם מעט ביכולתה לגשת לאחרים ולשוחח איתם.

.....

מנקודת מבט קלינית, הפרעת אישיות נמנעת דומה מאוד להפרעת אישיות סכיזואידית. בשתי ההפרעות, האדם מבודד חברתית. ההבדל העיקרי בין שתי ההפרעות הוא שהאדם עם הפרעת אישיות סכיזואידית אינו מעוניין ליצור יחסים קרובים. אנשים כאלה נוטים להיות מסוגרים, קרירים ואדישים יחסית לביקורת (Millon & Martinez, 1995). לעומת זאת, האדם עם הפרעת אישיות נמנעת מעוניין בקשר בין־אישי אך הוא ביישן, חסר ביטחון ובעל רגישות יתרה לביקורת. הבחנה פחות ברורה היא זו שבין הפרעת אישיות נמנעת לבין פוביה חברתית (פרק 6). הרבה מחקרים מצאו חפיפה ניכרת בין שתי ההפרעות הללו וזו הובילה חלק מהחוקרים למסקנה שהפרעת אישיות נמנעת אולי אינה אלא ביטוי קיצוני יותר של פוביה חברתית (Alpert et al, 1997; Carter & Wu, 2010; Tillfors et al., 2004). שאינו מצדיק אבחנה נפרדת (Chamless et al., 2008). מסקנה זו מתיישבת עם הממצא שלפיו יש מקרים רבים של פוביה חברתית בלי הפרעת אישיות נמנעת אך מעט מאוד מקרים של הפרעת אישיות נמנעת בלי פוביה חברתית. בהפרעת אישיות נמנעת נמצאו רמות גבוהות מעט יותר של ליקויי תפקוד ושל מצוקה, לרבות תחושות עקביות יותר של הערכה עצמית נמוכה (Hummelen et al., 2007; Millon & Martinez, 1995; Tillfors et al., 2004).

הקריטריונים של DSM-5 הפרעת אישיות נמנעת



דפוס נרחב של עכבה חברתית, תחושת חוסר התאמה ורגישות יתר להערכה שלילית המתחיל בבגרות המוקדמת, מתקיים במגוון הקשרים ומתבטא בארבעה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:

1. הימנעות מפעילויות תעסוקה הכרוכות בקשר בין-אישי משמעותי מתוך חשש מביקורת, חוסר הערכה או דחייה.
2. סירוב של האדם להיקשר חברתית כל עוד אין לו ביטחון מלא שיחבבו אותו.
3. הפגנת איפוק ביחסים אינטימיים מתוך חשש של האדם להיות מובך או שילעגו לו.
4. עיסוק מחשבתי בדחייה או בביקורת בסיטואציות חברתיות.
5. התנהגות עצורה בסיטואציות חברתיות חדשות בשל תחושת אי-התאמה.
6. האדם תופס את עצמו כלא מתאים מבחינה חברתית, בלתי מושך מבחינה אישית או נחות ביחס לאחרים.
7. הסתייגות מלקיחת סיכונים אישיים או מהתנסות בפעילויות חדשות מתוך חשש לגלות כי הם מביכים.

מקור: צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (copyright 2013). American Psychiatric Association.

גורמים סיבתיים

יש הסבורים כי האישיות הנמנעת מקורה במזג "מעוכב" מולד שמשאיר תינוקות וילדים ביישנים ובעלי עכבות במצבים חדשים ומעורפלים. במחקר תאומים מקיף שנערך בנורבגיה נמצא כי תכונות בולטות בהפרעת אישיות נמנעת מושפעות באופן מתון מהגנטיקה וכי הפגיעות הגנטית להפרעה זו משותפת, לפחות בחלקה, לה ולפוביה חברתית (Reichborn-Kjennerud, Czajkowski, Torgersen et al., 2007). יתרה מזו, ישנן גם ראיות המלמדות כי הפחד מהערכה שלילית, הבולט בהפרעת אישיות נמנעת, הוא תורשתי במידה מסוימת (Stein et al., 2002). גם רמות מופנמות ונוירוטיות גבוהות יותר (חזרו ועיינו בטבלה 10.2), וגם הן תורשתיות במידה מסוימת. המזג המעוכב הזה, המבוסס על גנטיקה וביולוגיה, עשוי לשמש לעיתים קרובות כדיאטזה המובילה להפרעת אישיות נמנעת אצל חלק מהילדים שחוו התעללות רגשית, דחייה או השפלה מצד הוריהם שאינם מרבים במיוחד לגלות רגשי חיבה (Alden et al., 2002; Bernstein & Travaglini, 1999; Kagan, 1997). התעללות ודחייה כאלה יובילו, קרוב לוודאי, לדפוסי היקשרות מלאי חרדה ופחד בילדים בעלי מזג מעוכב (Bartholomew et al., 2001).

הפרעת אישיות תלותית

הפרעת אישיות תלותית
(dependent personality disorder)

לאנשים עם **הפרעת אישיות תלותית** יש צורך קיצוני שיטפלו בהם, מה שמוביל להתנהגות נצמדת וכנועה. יש להם גם פחד ממשי מן האפשרות של פרידה ולפעמים אפילו מן הכורח הפשוט להיות לבד, משום שלדעתם אינם מסוגלים לכך (Bornstein et al., 2015; Widiger & Bornstein, 2001). בני אדם אלה בונים את חייהם בדרך כלל סביב אנשים אחרים ומשעבדים את צורכיהם ואת דעותיהם כדי לשמור על האחרים בקשר איתם. לפיכך הם עשויים לבחור בני זוג ללא אבחנה. לעיתים קרובות הם נמנעים מלהביע כעס מוצדק על זולתם מחשש לאבד את תמיכתם, כלומר אנשים עם אישיות תלותית עשויים להישאר במערכות יחסים פוגעניות מן הבחינה הפסיכולוגית או הגופנית. הם מתקשים מאוד לקבל החלטות, אפילו החלטות יום-יומיות פשוטות ביותר, בלי מידה רבה של עצות ועידוד. משום שהם

חסרי ביטחון עצמי, והם מרגישים חוסר אונים אפילו אם למעשה הצליחו לפתח מיומנויות עבודה טובות או כישורים אחרים. הם יכולים לתפקד היטב כל עוד אינם נדרשים להישאר בגפם.

הרעיה התלותית

שרה, בת 32 ואם לשניים, יועצת מס במשרה חלקית, הגיעה ערב אחד למרכז חירום לטיפול במשברים לאחר שמייקל, בעלה זה שנה וחצי, התעלל בה גופנית ועזב את הבית. אף שמעולם לא פגע פיזית בילדים, הוא איים לעשות זאת לעיתים קרובות בהיותו שיכור. שרה נראתה חרדה מאוד ומודאגת באשר לעתיד ו"הייתה צריכה שיגידו לה מה לעשות". היא רצתה שבעלה יחזור אליה ונראה כי לא הייתה מוטרדת במיוחד מהדפוס הקבוע של התעללות פיזית. באותה עת, מייקל היה מובטל והשתתף בתוכנית אשפוז יום במרכז שיקום לצרכני סמים לשעבר. הוא היה כמעט תמיד במצב רוח זועף ו"על סף פיצוץ".

אומנם שרה עבדה והרוויחה היטב, אך היא ביטאה דאגה גדולה באשר ליכולתה להסתדר בכוחות עצמה. היא הבינה שטיפשי להיות "תלויה" בבעלה, שאותו הגדירה כ"לא יוצלח גמור" (היו לה יחסים דומים עם בעלה הראשון, שעזב אותה ואת בנה הבכור כשהייתה בת 18). פעמים אחדות במהלך החודשים האחרונים, שרה החליטה להיחלץ מן הנישואין אך לא יכלה להביא את עצמה לקום וללכת. היא הייתה מאיימת לעזוב אך כשהגיעה השעה לעשות זאת היא הייתה "קופאת במקום בפתח הבית", עם קהות חושים בגופה ותחושת ייאוש לנוכח המחשבה ש"לא תהיה עם מייקל".

על פי אומדנים, קרוב לאחוז אחד מהאוכלוסייה הכללית לוקה בהפרעת אישיות תלותית, והיא שכיחה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים (Bornstein et al., 2015; Torgersen, 2012). הבדל מגדרי זה אינו נובע מהטיה מגדרית באבחון אלא מהתפוצה הרחבה יותר של תכונות אישיות מסוימות המאפיינות נשים, כגון נזירותיות ונועם הליכות, הבולטות בהפרעת אישיות תלותית (Lynam & Widiger, 2007). הפרעת אישיות תלותית מופיעה לעיתים קרובות עם הפרעות אחרות, כולל הפרעות מצב רוח, הפרעות חרדה, הפרעות אכילה והפרעות תסמינים סומטיים. התחלואה נלווית קיימת גם בין הפרעת אישיות תלותית לבין הפרעות אישיות אחרות, בייחוד ההפרעות סכיזואידית, נמנעת, גבולית והיסטריונית (Bornstein et al., 2015).

התחלואה הנלווית יכולה לנבוע בחלקה מחפיפה בין המאפיינים של הפרעת אישיות תלותית לאלה של הפרעות אישיות גבולית, היסטריונית ונמנעת. עם זאת, גם ברמה הקלינית קיימים הבדלים משמעותיים (חזרו ועיינו בטבלה 10.2).

לדוגמה, גם אנשים עם אישיות גבולית וגם בעלי אישיות תלותית פוחדים מנטישה, אולם האישיות הגבולית, שלרוב מתאפיינת ביחסים סוערים ואינטנסיביים, מגיבה בתחושת ריקנות או זעם אם היא חווה נטישה, ואילו האישיות התלותית מגיבה בהתחלה בהכנעה ובפיוס ואחר כך בסופו של דבר מחפשת בבהילות מערכת יחסים חדשה. לאנשים עם אישיות היסטריונית ולאלה עם אישיות תלותית יש צורך עז באישור ובעידוד, אך האישיות ההיסטריונית הרבה יותר חברותית וראונית ותובעת תשומת לב בעוד שהאישיות התלותית כנועה יותר ומבטלת את עצמה. ההבחנה בין אישיות תלותית לאישיות נמנעת יכולה אף היא להיות קשה. כפי שכבר צוין, לאנשים עם אישיות תלותית קשה מאוד עם פרידות במערכות יחסים מכיוון שהם מרגישים חסרי יכולת בהיותם לבדם ויש להם צורך שמישהו ידאג להם, ואילו אנשים עם אישיות נמנעת מתקשים ליזום מערכות יחסים בשל הפחד מן ההשפלה שתיגרם להם אם ייתקלו בביקורת או שיידחו אותם (Millon & Martinez, 1995). למרות זאת, עלינו לזכור שלעיתים קרובות אישיות נמנעת והפרעת אישיות תלותית מופיעות יחד (Arntz et al., 2009; Bernstein & Bornstein et al., 2015). הדבר מתיישב עם הממצא שהלוקים בהפרעת אישיות נמנעת אינם נמנעים מכל אחד וכי מאפייני הפרעת האישיות התלותית שלהם מתמקדים באדם אחד או אנשים אחדים שהם אינם נמנעים מקשרים איתם (Alden et al., 2002). במונחי מודל חמשת הגורמים, הפרעת אישיות תלותית קשורה לרמות גבוהות של נירוטיות ונועם הליכות (Lowe et al., 2009).

הקריטריונים של DSM-5 הפרעת אישיות תלותית



5. השקעת מאמצים מרחיקי לכת כדי לזכות בטיפוח ובתמיכה מאחרים, עד כדי עשיית דברים בלתי נעימים בהתנדבות.
6. תחושת אי־נוחות או חוסר אונים של האדם בהיותו לבד מתוך חשש מוגזם של חוסר יכולת לדאוג לעצמו.
7. חיפוש בהול אחר קשר חדש שיהווה מקור תמיכה והשגחה כשמערכת יחסים קרובה מגיעה לסיומה.
8. עיסוק מחשבתי לא מציאותי של האדם בפחד מנטישה שתחייב אותו לדאוג לעצמו.

- צורך קבוע ומופרז של האדם בטיפול ובדאגה מצד אדם אחר, המביא להתנהגות כנועה ונצמדת ולפחד מפרידה המתחיל בבגרות המוקדמת, מתקיים במגוון הקשרים ומתבטא בחמישה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:
1. קושי בקבלת החלטות יום־יומיות ללא כמות מופרזת של עצות ואישורים מאחרים.
2. צורך של האדם באחרים שיקבלו אחריות על מרבית תחומי החיים שלו.
3. קושי בהבעת אי־הסכמה עם הזולת מתוך חשש לאבד את התמיכה או האישור (הערה: אין לכלול פחדים מציאותיים מעונש).
4. קושי ליזום פרויקטים או עשייה עצמאית (עקב חוסר ביטחון עצמי בשיפוט או ביכולת ולא בשל חוסר מוטיבציה או אנרגיה).

מקור: צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition (copyright 2013). American Psychiatric Association.

גורמים סיבתיים

על פי אומדנים אפשר לייחס בין 30% ל-60% מהשונות בתסמיני הפרעת האישיות התלותית לגורמים גנטיים (Bornstein et al., 2015; Gjerdet et al., 2012). יתרה מזו, גם לתכונות אישיות אחרות כגון נזירותיות ונועם הליכות, הבולטות בהפרעת אישיות תלותית, יש רכיב גנטי (Widiger & Bornstein, 2011). ייתכן שאנשים עם נטייה גנטית מוקדמת לתלותיות ולחרדה מועדים במיוחד להשפעות השליליות של הורים סמכותניים ומגוננים מדי (אינם מטפחים אוטונומיה וייחוד בילדיהם אלא מחזקים התנהגות תלותית). משום כך, ילדים עלולים להאמין שהם חייבים להישען על אחרים למען רווחתם האישית ואינם כשירים לעמוד ברשות עצמם (Widiger & Bornstein, 2011). תיאורטיקנים קוגניטיביים מתארים את הסכמות הלא הסתגלותיות אצל אנשים אלה כסכמות הכוללות אמונות ליבה בהקשר של חולשה וכשירות וצורך באחרים כדי לשרוד, כגון "אני לגמרי חסר אונים" ו"אני יכול לתפקד רק אם יש לי גישה למישהו בעל יכולת" (Beck et al., 1990, p. 60; Beck et al., 2004). מחקר של העת האחרונה תומך בהשערה שאמונות אלה מאפיינות אנשים עם הפרעת אישיות תלותית (Arntz et al., 2011).

הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית

שאיפה לשלמות ועיסוק מופרז בשמירה על הסדר ובשליטה הם מאפיינים של אנשים עם הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית. אל תזונו דבר על שולחנם המסודר. העיסוק המחשבתי שלהם בשמירה על שליטה נפשית ובין-אישית נעשה בין השאר באמצעות תשומת לב קפדנית לכללים, לסדר וללוחות זמנים. הם זהירים מאוד בפעולותיהם כדי להימנע מטעויות, אך במקרים רבים הם עוסקים בפרטי פרטים זניחים ולכן אינם מנצלים היטב את זמנם ומתקשים לראות את התמונה הכוללת שלהם (Ayicegi-Dinn et al., 2009; Yovel et al., 2005). החתירה המוגזמת שלהם לשלמות היא פעמים רבות לא יעילה שכן היא עלולה להביא לכך שלעולם לא ישלימו משימה. כמו כן, הם נוטים להתמסר לעבודתם עד כדי ויתור על פעילויות פנאי, והם עלולים להתקשות לצאת לחופשה, להירגע או לעשות משהו לשם ההנאה בלבד (Widiger & Frances, 1994). אפילו תחביבים הם פעולות רציניות המחייבות שלמות. ברמה הבין-אישית, אנשים עם הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית מתקשים להאציל סמכויות לאנשים אחרים ("הם לא יעשו זאת בדיוק כמו שצריך ובדיוק כפי שאני רוצה שהם יעשו זאת"). הם נתפסים כנוקשים, עיקשים וקרים. ממחקרים עולה כי נוקשות, עקשנות ושאיפה לשלמות וגם הסתייגות מהאצלת סמכויות הם המאפיינים השכיחים והיצביים ביותר בהפרעת אישיות טורדנית-כפייתית (Ansell et al., 2008; Grilo et al., 2004; McGlashan et al., 2005; Samuel & Widiger, 2011).

הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית
OCPD – Obsessive-Compulsive
(Personality Disorder)

למרות השם הדומה, אנשים עם הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית אינם עוסקים בטקסים כפייתיים כמו אלה עם הפרעת טורדנות-כפייתית (הפרעת טורדנות-כפייתית נדונה בפרק 6). ואכן, רק 20% מהאנשים עם הפרעת טורדנות-כפייתית לוקים במקביל בהפרעת אישיות טורדנית-כפייתית. נתונים אלה אינם שונים משמעותית משעור הפרעת האישיות הטורדנית-כפייתית בקרב מטופלים

עם הפרעת פאניקה (Albert et al., 2004). מעניין שבין 20% ל-61% מהלוקים באנורקסיה נרבוזה מקבלים גם אבחנה של הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית (Samuels & Costa, 2012). יש בכך מן ההיגיון לנוכח העובדה ששאיפה לשלמות ונוקשות היא מאפיין מרכזי בשני המצבים. תחלואה נלווית משמעותית קיימת גם בין הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית לבין הפרעות מצב רוח וחרדה (Reichborn-Kjennerud & Knudsen, 2015).



אנשים עם הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית שואפים לשלמות באורח מוגזם. הם מתקשים להאציל סמכויות לביצוע משימות ויש להם בעיות להשלים פרויקטים. מסירותם לעבודה מופרזת, והם אינם גמישים בסוגיות מוסר ואתיקה. הם גם נוטים להיות לא נדיבים כלפי עצמם וכלפי זולתם.

מפקח תנועת הרכבות השואף לשלמות

נדמה היה כי אלאן התאים מאוד לעבודתו כמפקח על תנועת הרכבות. הוא היה מצפוני, שואף לשלמות והקפיד על הפרטים הקטנים ביותר. עם זאת, הוא לא היה קרוב לעמיתיו לעבודה, ולפי הדיווחים הם חשבו שהוא "לא בסדר". הוא היה מתרגז מאוד על כל שינוי, ולו הזעיר ביותר בשגרת יומו. לדוגמה, הוא נעשה מתוח ועצבני אם עמיתיו לעבודה לא פעלו בדיוק לפי לוחות הזמנים והתוכניות שבנה בדקדקנות. כמו כן, אלאן חש קושי כאשר עמיתיו הציעו דרכים אחרות לבצע משימות הקשורות לעבודה. הוא לא היה מסוגל להכיר בכך שיתכן כי ישנן דרכים אחרות, לא פחות טובות, לעשות דברים ומיהר לבטל כל הצעה או רעיון של עמיתיו לעבודה.

בקצרה, אלאן כמעט לא נהנה מן החיים והיה מוטרד דרך קבע מבעיות שוליות. אי-אפשר היה לעמוד בנהלים הנוקשים שהוא קבע לעצמו ולעיתים קרובות הוא פיתח כאבי ראש או כאבי בטן בשל מתח משלא הצליח לעמוד בתוכניות המסובכות שתכנן. הרופא שלו, שהבחין בתכיפות תלונותיו הגופניות ובגישתו הכללית לחיים השואפת תמיד לשלמות, הפנה

אותו להערכה פסיכולוגית. הומלץ לו להתחיל בטיפול פסיכולוגי אך הוא לא נשמע להמלצה מכיוון שהרגיש שאינו יכול להרשות לעצמו להיעדר מן העבודה.

.....

התפוצה הנקודתית של הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית במדגמים בקהילה היא כ-2%, ומעריכים כי ההפרעה מעט שכיחה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים (Torgersen, 2012). כמה ממאפייני הפרעת האישיות הטורדנית-כפייתית חופפים למאפיינים מסוימים בהפרעות אישיות נרקיסיסטית, אנטי-חברתית וסכיזואידית, אף שקיימים גם מאפיינים שמבחינים ביניהן. לדוגמה, אנשים עם הפרעת אישיות נרקיסיסטית או הפרעת אישיות אנטי-חברתית יכולים להיות לא נדיבים כלפי אחרים, תכונה המאפיינת גם את הלוקים בהפרעת אישיות טורדנית-כפייתית. אולם הלוקים בהפרעות הראשונות נוטים לפנק את עצמם ואילו אלה עם הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית אינם מוכנים להיות נדיבים כלפי זולתם וכלפי עצמם. כמו כן, גם לאישיות הסכיזואידית וגם לאישיות הטורדנית-כפייתית יש מידה מסוימת של רשמיות וניתוק חברתי אך רק לאישיות הסכיזואידית חסרה היכולת לקיים יחסים קרובים. אנשים עם הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית מתקשים ביחסים בין-אישיים בשל מסירות יתר לעבודה ובגלל הקושי הרב להביע רגשות.

הקריטריונים של DSM-5 הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית



4. תחושת חובה יתרה, רגישות מוסרית וחוסר גמישות בנושאי מוסר, אתיקה וערכים (שאי-אפשר לייחס לזהות תרבותית או דתית).
 5. חוסר יכולת להשליך חפצים מרופטים או חסרי ערך גם כשהם חסרי ערך סנטימנטלי.
 6. הסתייגות של האדם מהאצלת סמכויות וחוסר רצון לעבוד עם אחרים אלא אם הם מוכנים לפעול בדיוק בדרך שלו.
 7. סגנון קמצני בהוצאות כסף בעבור האדם עצמו ובעבור אחרים כאחד. כסף יש לחסוך למקרי אסון בעתיד.
 8. הפגנת נוקשות ועקשנות.
- דפוס נרחב של עיסוק בסדר, בשאיפה לשלמות ובשליטה מנטלית ובין-אישית על חשבון גמישות, פתיחות ויעילות, המתחיל בבגרות המוקדמת, מתקיים במגוון הקשרים ומתבטא בארבעה (או יותר) מהתסמינים שלהלן:
1. עיסוק בפרטים, בכללים, ברשימות, בסדר, בארגון או בלוחות בזמנים עד שמהות הפעילות אובדת.
 2. הפגנת שאיפה לשלמות שמפריעה להשלמת המשימה (למשל אי-יכולת של האדם לסיים פרויקט שכן אינו יכול להגיע לאמות המידה המחמירות שלו עצמו).
 3. מסירות מוגזמת לעבודה וליצרנות עד כדי ויתור על פעילות בשעות הפנאי ועל קשרים חברתיים (שאי-אפשר להסביר באמצעות צורך כלכלי ברור).

מקור: צוטט באישור של *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition (copyright 2013). American Psychiatric Association.

גורמים סיבתיים

תיאורטיקנים המצדדים בגישה הממדית של חמשת הגורמים להבנת הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית מציינים שללוקים בהפרעה יש רמות גבוהות ביותר של תחושת חובה (Samuel & Widiger, 2011). מכאן נגזרת המסירות הקיצונית לעבודה, החתירה לשלמות וההתנהגות המופרזת של שליטה. יש להם גם רמות גבוהות של אסרטיביות (תת-מרכיב של מוחצנות) ורמות נמוכות של היענות (תת-מרכיב של נועם הליכות). קלונינגר (Cloninger, 1987) מציע גישה ממדית ביולוגית אחרת בעלת השפעה. הוא מתאר שלושה ממדים עיקריים של אישיות: חיפוש אחר חידושים, תלות בתגמול והימנעות מפגיעה מצד אחרים. אנשים עם אישיות טורדנית-כפייתית מתאפיינים ברמות נמוכות של חיפוש אחר חידושים (למשל הם נמנעים משינויים) ושל תלות בתגמול (הם עובדים באופן מוגזם על חשבון עיסוקים מהנים), אך יש להם רמות גבוהות של הימנעות מפגיעה (למשל הם מגיבים בחוזקה לגירויים עוינים ומנסים להימנע מהם). מחקרים גם הראו שהגנטיקה משפיעה במידה קלה על תכונות ההפרעה (Calvo et al., 2009; Reichborn-Kjennerud, Czajkowski, Neale et al., 2007).

שאלת חזרה



■ תארו את הפרעות האישיות מאשכול C והבחינו ביניהן: נמנעת, תלותית וטורדנית-כפייתית.

גורמים סיבתיים חברתיים-תרבותיים כלליים להפרעות אישיות

יעד לימוד 10.6 להסביר את התפקידים שגורמים חברתיים-תרבותיים עשויים למלא בתפוצה של הפרעות אישיות.

לפי שעה, אין לנו הבנה מלאה של הגורמים החברתיים-תרבותיים התורמים להפרעות אישיות. כמו בצורות אחרות של פסיכופתולוגיה, ההיארעות והתכונות הייחודיות של הפרעות אישיות משתנות בהתאם לזמן ולמקום, אם כי פחות מן הצפוי (Allik, 2005; Rigozzi et al., 2009). אכן, השונות בין תרבויות נמוכה מהשונות בתוך תרבויות. אפשר אולי לייחס זאת לממצאים שלפיהם כל התרבויות (מערביות ושאינן מערביות, לרבות אסיה ואפריקה) חולקות את אותן חמש תכונות בסיסיות שבהן דנו מוקדם יותר, ודפוסי השונות המשותפת שלהם נראים גם הם אוניברסליים (לסקירה ראו Allik, 2005).

ישנם חוקרים הסבורים כי חלה עלייה בשיעור של הפרעות אישיות מסוימות בחברה האמריקנית בשנים האחרונות (למשל Paris, 2001). אם טענה זו נכונה, נגלה כנראה שהעלייה קשורה לשינויים שחלו בהעדפות ובפעילויות הכלליות בתרבות האמריקנית. האם הדגש שאנו שמים על סיפוק דחפים, על פתרונות

מהירים ועל רווח ללא מאמץ מוביל יותר ויותר בני אדם לפתח את סגנון החיים האגוצנטרי שאנו רואים בצורות קיצוניות יותר של הפרעות אישיות? לדוגמה, יש ראיות לכך שהפרעת אישיות נרקיסיסטית רווחת יותר בתרבויות המערב, שבהן מעודדים ומחזקים אמביציה והצלחה אישית (למשל, Widiger & Bornstein, 2001). קיימות גם ראיות שלפיהן אישיות היסטריאטית תהיה (ועודה) שכיחה פחות בתרבויות אסיאניות, שבהן אין רואים בעין יפה פיתוי מיני ומשיכת תשומת לב. לעומת זאת, אישיות כזו יכולה להיות שכיחה יותר בתרבויות היספאניות שבהן נטיות כאלה רווחות ומתקבלות בסובלנות (למשל Bornstein et al., 2015). במחקר שנערך בארצות הברית נמצאו שיעורי גבוהים יותר של הפרעת אישיות היסטריאטית בקרב נשים אפריקניות-אמריקניות ביחס לנשים לבנות (Grant, Hasin, et al., 2004). שוב, בארצות הברית שיעורי הפרעת האישיות הגבולית גבוהים יותר בקרב היספאנים מאשר בקרב אפריקנים-אמריקנים ובקרב לבנים, אולם שיעורי הפרעת האישיות הסכיזופרנית גבוהים יותר בקרב אפריקנים-אמריקנים מאשר בקרב לבנים (Chavira et al., 2003).

חוקרים אחרים טענו שאפשר לייחס את העליות הידועות זה 70 שנה מאז מלחמת העולם השנייה בחוסר ויסות רגשי (למשל דיכאון, התנהגות של פגיעה עצמית והתאבדות) ובהתנהגויות אימפולסיביות (שימוש מזיק בחומרים והתנהגות עבריינית) לעלייה בתפוצתן של הפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות אנטי-חברתית באותו פרק זמן. אפשר שעלייה זו נובעת משבר גדל במבנה המשפחה ובמבנים מסורתיים אחרים (Paris, 2001, 2007). הבדלים בעוצמתם של שינויים חברתיים אלה עשויים להשפיע באופן שונה על העלייה בתפוצתן של הפרעות אלה במדינות השונות.

שאלת חזרה



■ תארו את תפקיד הגורמים החברתיים-תרבותיים בהסבר של תפוצת הפרעות אישיות.

טיפול בהפרעות אישיות ותוצאותיהם

יעד לימוד 10.7 להסביר את האתגרים בטיפול בהפרעות אישיות ולסכם את הגישות שבהן משתמשים.

הטיפול בהפרעות אישיות הוא בדרך כלל קשה מאוד, בין היתר משום שהן, בהגדרה, דפוסי התנהגות וחוויות פנימיות מתמשכים יחסית, נרחבים וחסרי גמישות. יתרה מזו, אפשר לנסח מטרות שונות לטיפול, ואת חלקן קשה יותר להשיג מאשר אחרות. המטרות יכולות לכלול הפחתה של מצוקה סובייקטיבית, שינוי התנהגויות לקויות ספציפיות ושינוי דפוסי התנהגות שלמים או שינוי כל מבנה האישיות.

במקרים רבים, אנשים עם הפרעות אישיות מגיעים לטיפול עקב התעקשותו של אדם אחר ולעיתים קרובות הם אינם חושבים שעליהם להשתנות. ואם לא די בזה, אלה מאשכול A המוזר / משונה ומאשכול B הבלתי יציב / דרמטי מתקשים ליצור יחסים בין-אישיים טובים ולשמרם, לרבות הקשר עם המטפל. המטופלים מאשכול B הבלתי יציב / דרמטי מביאים לטיפול את דפוס ההחצן הטיפוסי למערכות היחסים האחרות שלהם. במקום לעסוק בבעיותיהם במישור המילולי הם עלולים לכעוס על המטפל וליצור עימות במהלך הפגישות הטיפוליות. הפסקת הטיפול לפני סיומו היא בעיה שכיחה בטיפול בהפרעות אישיות. באחת הסקירות דווח כי בממוצע 37% מהמטופלים עם הפרעת אישיות נושרים מהטיפול לפני הזמן (McMurran et al, 2010).

כמו כן, הלוקים בהפרעת אישיות ובהפרעה נוספת (כגון דיכאון או הפרעת אכילה) נוטים להתקדם בטיפול פחות טוב ממטופלים שאין להם הפרעות אישיות נלוות נוספות (Crits-Christoph & Barber, 2002, 2007; Pilkonis, 2001). סיבה חלקית לכך היא שלאנשים עם הפרעות אישיות יש תכונות אישיות נוקשות מושרשות היטב שלעיתים מזומנות מובילות ליחסים טיפוליים גרועים וגם גורמים למטופלים להתנגד לעשות את מה שיסייע להם לשפר את בעיותיהם האחרות.

התאמת טכניקות טיפול להפרעות אישיות ספציפיות

טכניקות טיפול לעיתים קרובות חייבות להשתנות. לדוגמה, הטיפול הפרטני המסורתי נוטה לעודד תלות אצל אנשים שממילא כבר תלותיים יתר על המידה (כמו בהפרעת אישיות תלותית, היסטוריונית וגבולית) ולכן עדיף לעיתים לפתח אסטרטגיות טיפול ספציפיות המיועדות לשנות תכונות כאלה. מטופלים מאשכול C, של חרדה / פחד, כגון אנשים עם אישיות תלותית או נמנעת עשויים להיות רגישים במיוחד לכל ביקורת נתפסת של המטפל, לכן שומה על המטפלים לנקוט משנה זהירות כדי להבטיח שהדבר לא יקרה.

לאנשים עם הפרעות אישיות קשות, הטיפול עשוי להיות יעיל יותר במצבים שבהם אפשר לרסן התנהגות מוחצנת. לדוגמה, מטופלים רבים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית מאושפזים מדי פעם מסיבות בטיחותיות בשל התנהגותם האובדנית התכופה. מכל מקום, כיום הולך ומתרחב השימוש בתוכניות אשפוז חלקי כחלופות ביניים לאשפוז מלא שהן יקרות פחות (Azim, 2001). בתוכניות אלה, המטופלים גרים בביתם ומקבלים טיפול פרטני וקבוצתי מקיף בימי חול. במחקרים שנערכו בהולנד נמצא כי אשפוז קצר מועד יעיל יותר מטיפול במרפאות חוץ בהפרעות אישיות מאשכול B ו-C (Bartak et al., 2010, 2011).

גם השימוש בגישות קוגניטיביות הולך ומתרחב. בבסיס הטיפול הקוגניטיבי בהפרעות אישיות עומדת ההנחה שהרגשות וההתנהגויות הדיספונקציונליות הקשורות להפרעות אישיות הן ברובן תוצאה של סכמות (סגנונות חשיבה) הנוטות ליצור שיפוטיות מוטות באופן קבוע וכן נטיות לשגיאות קוגניטיביות

(למשל; Beck et al., 2003; Cottraux & Blackburn, 2001; Leahy & McGinn, 2012; Pretzer & Beck, 2005). קשה לשנות סכמות דיספונקציונליות, אך השינוי הוא לב-ליבו של הטיפול הקוגניטיבי בהפרעות אישיות. גישות קוגניטיביות משתמשות בטכניקות כגון ניטור מחשבות אוטומטיות, אתגור של היגיון שגוי והטלת משימות התנהגותיות בניסיון לאתגר את האמונות הדיספונקציונליות של המטופל. **טבלה 10.3** מציגה דוגמאות לכמה מהאמונות המרכזיות הקשורות להפרעות אישיות שונות.

טבלה 10.3 אמונות הקשורות להפרעות אישיות ספציפיות

הפרעת אישיות	אמונה בסיסית
פרנואידית	אני יכול לבטוח באנשים.
סכיזואידית	מערכות יחסים הן מלוכלכות, לא רצויות.
סכיזופלית	עדיף להיות מבודד מאנשים אחרים.
היסטריאית	אנשים קיימים כדי לשרת אותי או להעריך אותי.
נרקיסיסטית	אני מיוחד, לכן אני זכאי לכללים מיוחדים.
אנטי-חברתית	זכותי להפר כללים.
גבולית	מגיע לי עונש.
נמנעת	אם אנשים יכירו את ה"אני" האמיתי שלי, הם ידחו אותי.
תלותית	אני זקוק לאנשים כדי לשרוד, להיות מאושר.
טורדנית-כפייתית	אנשים צריכים להשתפר, להתאמץ יותר.

מקור: Beck, Freeman, & Davis (2002). *Cognitive Therapy of Personality Disorders*. New York: Guilford Press.

הטיפול בהפרעת אישיות גבולית

מכל הפרעות האישיות, רוב תשומת הלב הקלינית והמחקרית הופנתה לטיפול בהפרעת אישיות גבולית. הסיבה לכך היא חומרתה של הפרעה זו והסיכון הגבוה להתאבדות המתקשר אליה. טיפול פסיכולוגי נחשב לחיוני. משתמשים גם בתרופות, אך השימוש ההולם ביותר בהן הוא לזמן מוגבל וכהשלמה לטיפול הפסיכולוגי (Bateman et al., 2015).

טיפולים פסיכו-חברתיים

לפי מקרים קליניים, ישנם כמה סוגי טיפולים פסיכולוגיים העשויים להיות יעילים בטיפול בהפרעת אישיות גבולית. אולם, כפי שצוין קודם, לטיפולים הללו יש שתי נקודות חולשה: הם מסובכים וממושכים יחסית. משום כך הרחבת השימוש בהן לכלל האוכלוסייה היא אתגר לא פשוט (Paris, 2009).

טיפול התנהגותי דיאלקטי (DBT – Dialectical Behavior Therapy)

טיפול התנהגותי דיאלקטי, שפיתחה מרשה לינהאן (Linehan), הוא סוג ייחודי של טיפול קוגניטיבי והתנהגותי שהותאם במיוחד לטיפול בהפרעת אישיות גבולית (שכפי שמתואר במסגרת "העולם סביבנו", התמודדה בעצמה עם הפרעת אישיות גבולית בעבר), סבורה כי אחת הבעיות המרכזיות בהפרעה זו היא אי-היכולת של הלוקים בה לשאת מצבים קשים של רגשיות שלילית. אחת המטרות העיקריות של הטיפול היא לעודד את המטופלים לקבל רגשיות שלילית זו בלי להגיע להתנהגויות של הרס עצמי או להתנהגויות לא הסתגלותיות אחרות. לפיכך, לינהאן פיתחה טיפול הממוקד בבעיה המבוסס על מדרג יעדים ברור שבראשו הפחתה של התנהגות אובדנית והתנהגות של פגיעה עצמית ושיפור מיומנויות ההתמודדות. הטיפול משלב רכיבים אישיים וקבוצתיים וכן אימון באמצעות הטלפון. במסגרת הקבוצה, המטופלים לומדים מיומנויות בין-אישיות, ויסות רגשות ויכולת לשאת מצוקה. המטפל מצידו, מנצל את הפגישות האישיות ואת האימון הטלפוני כדי לעזור למטופל לזהות את דפוסי ההתנהגות הבעייתית ולשנות אותם וליישם ביעילות מיומנויות חדשות שלמד.

נראה כי טיפול התנהגותי דיאלקטי הוא טיפול יעיל בהפרעת אישיות גבולית (Binks et al., 2006; Neacsiu & Linehan, 2014). עם זאת, עדיין לא נערכו די מחקרים עם הקצאה מקרית לקבוצת טיפול ולקבוצת ביקורת כדי לקבוע אם הטיפול הזה יעיל לגברים באותה מידה שהוא יעיל עבור נשים ואם הוא יעיל לקבוצות מיעוט (Lynch & Cuper, 2012). אצל אנשים המקבלים טיפול התנהגותי דיאלקטי נראית הפחתה בפגיעה העצמית ובהתנהגויות האובדניות וכן ברמות הכעס שלהם (Linehan et al., 2006; Lynch et al., 2007). ישנן גם ראיות שלפיהן ההישגים האלה נשארים יציבים לאורך זמן (Zanarini et al., 2005). הודות למאמציה הרבים של לינהאן לסייע למטופלים ללמוד את השיטות שלה, הטיפול ההתנהגותי דיאלקטי הולך ונעשה זמין למטופלים. כיום מפתחים גם גרסאות מקוצרות של הטיפול (ראו Stanley et al., 2007; Neacsiu & Linehan, 2014).

שיטת טיפול פסיכו-חברתית נוספת להפרעת אישיות גבולית היא גרסה של טיפול פסיכולוגי פסיכודינמי. קרנברג (Kernberg 1985, 1996) ועמיתיו (Koenigsberg et al., 2000; ראו גם Clarkin et al., 2004) פיתחו צורה של טיפול פסיכודינמי שהיא ישירה הרבה יותר מהטיפול הפסיכודינמי הטיפוסי. השיטה נקראת פסיכותרפיה הממוקדת בהעברה (transference-focused psychotherapy) (Yeomans et al., 2013). היעד העיקרי של הטיפול הוא חיזוק האגו החלש של אנשים אלה, עם התמקדות מיוחדת בפיצול – מנגנון ההגנה הפרימיטיבי העיקרי שלהם. הפיצול מוביל אותם לחשיבה של שחור או לבן, הכול או לא כלום, ולשינויים מהירים מאוד בתגובותיהם לעצמם ולזולתם (לרבות המטפל) בין "טובים לגמרי" או "רעים לגמרי". אחת המטרות העיקריות היא לעזור למטופלים לראות גווני אפור בין נקודות הקיצון הללו ולשלב היבטים חיוביים ושליליים על עצמם ועל אחרים כדי להגיע לראייה מגוונת יותר. אף שטיפול זה הוא בדרך כלל יקר וממושך (לעיתים קרובות הוא נמשך כמה שנים), נמצא, לפחות במחקר אחד, כי הוא יעיל כמו טיפול התנהגותי דיאלקטי, שנחשב כיום לטיפול המבוסס והיעיל ביותר (Clarkin et al.,

(2007). כעת אנו ממתנינים לשחזור של ממצאים אלה במרכזי טיפול נוספים כדי לחזק את הממצא של יעילות השיטה.

לבסוף, מן הראוי לציין שיטת טיפול מבטיחה נוספת. בייטמן ופונאגי (Bateman & Fonagy, 2010) פיתחו שיטת טיפול חדשה בשם מנטליזציה (mentalization). בשיטה זו משתמשים ביחסים הטיפולים כדי לעזור למטופלים לפתח מיומנויות הנחוצות להם להבנה מדויקת של רגשותיהם ושל תחושותיהם, וגם את אלה של זולתם. במחקר שבו חילקו את המטופלים באופן מקרי בין שיטת המנטליזציה לשיטה הרגילה (טיפול פסיכיאטרי בקהילה בעזרת תרופות או אשפוזים במידת הצורך), התגלה ששיטת המנטליזציה יעילה בטיפול בהפרעת אישיות גבולית יותר מהשיטה הרגילה. יתרה מזו, שיפורים קליניים רבים נשמרים אפילו אחרי מעקב של 8 שנים (Bateman & Fonagy, 2008). אומנם טיפול דיאלקטי התנהגותי הוא עדיין פופולרי מאוד, אך מעודד לדעת שכיום עומדות לרשותם של אנשים עם הפרעת אישיות גבולית גם אפשרויות טיפול אחרות.

העולם סביבנו



מרשה לינהאן חושפת את מאבקה האישי בהפרעת אישיות גבולית

ולהשלים עם הפער בין מי שהיא הייתה רוצה להיות ובין מי שהיא באמת. היא נרשמה ללימודים מתקדמים וסיימה דוקטורט בפסיכולוגיה. והיא התחילה לנצל את ניסיונה כדי לעזור לאנשים הנאבקים בהפרעת אישיות גבולית – האבחנה שלדבריה הייתה נותנת לעצמה כשהייתה צעירה. במהלך הזמן היא פיתחה, ליטשה וניסתה שיטת טיפול חדשנית ועוצמתית וקראה לה טיפול התנהגותי דיאלקטי – טיפול שמיועד להעניק למטופלים את סוג העזרה שהיא עצמה הזדקקה לה כל כך בשלב מוקדם יותר בחייה. שיטת הטיפול שלה הצילה חיים וסיפקה עתיד טוב יותר לאין־ספור אנשים. אולם, הסיפור האישי של לינהאן הביא לדבר נוסף. בעקבות החשיפה האמיצה שלה, לינהאן נהפכה לדוגמה חיה של התגברות על הפרעת אישיות גבולית. בחשיפת המאבק שלה עצמה במחלת הנפש, היא העניקה לכל המטופלים בהפרעת אישיות גבולית סיבה חדשה לתקווה.

עד כמה חשוב לדעתכם שאדם כמו מרשה לינהאן מגלה עבר אישי של הפרעת נפש? מדוע לדעתכם עברו כל כך הרבה שנים עד שסיפרה את סיפורה? לו הייתם במקומה, מה הייתם עושים? מדוע?

בצעד נחוש ואמיץ, חשפה מרשה לינהאן, מפתחת שיטת הטיפול ההתנהגותי דיאלקטי, את חווייתה האישית עם הפרעת נפש (ראו Carey, 2011). כשהייתה בת 17, הייתה לינהאן מאושפזת במשך 26 חודשים. באותה עת היא קיבלה אבחנה של סכיזופרניה, טופלה בתרופות אנטי־פסיכוטיות חזקות ובתרופות אחרות, הוחזקה בבידוד באגף סגור, קיבלה 30 טיפולים בנזעי חשמל ועברה פסיכואנליזה. אולם נראה היה שכל המאמצים עלו בתוהו. איש לא הבין למה באמת לינהאן, שנחשבה לאחת המטופלות הקשות ביותר בבית החולים, זקוקה. היא צרבה את עצמה בסיגריות, חתכה את זרועותיה, את רגליה ואת בטנה בכל חפץ חד שמצאה ובסופו של דבר, עם אשפוז והכנסתה לבידוד, היא חבטה בראשה בקיר חדרה הנעול. "הייתי בגיהנום", היא אמרה. "הרגשתי מרוקנת לגמרי, כמו איש הפח".

אחרי שהשתחררה מבית החולים, לינהאן המשיכה להיאבק. עם שובה לראשונה לביתה היא ניסתה להתאבד ואחר כך העתיקה את מגוריה למקום אחר כדי לפתוח דף חדש. היו לה הרבה עליות ומורדות, אך לאט לאט התחילה לינהאן להתקדם בנתיב חדש. היא החלה לקבל את עצמה ואת חייה

טיפול בילוגיים

פעמים רבות משתמשים בתרופות בטיפול בהפרעת אישיות גבולית. מטופלים רבים עם הפרעה זו נוטלים כמה וכמה תרופות, אף שיש רק ראיות מעטות התומכות בשימוש בהן (Bateman et al., 2015). ישנן תרופות נוגדות דיכאון (רובן ממשפחת המעכבים הברנניים של קליטת סרוטונין חוזרת, SSRIs) הרווחות בשימוש, אך אין ראיות מוצקות ליעילותן. הן מתאימות מאוד רק במטופלים שיש להם גם הפרעת מצב רוח (Silk & Feurino, 2012). תרופות אנטי־פסיכוטיות מהדור השני (כגון aripiprazole ו־olanzapine) ומייצבי מצב רוח (כגון topiramate, valproate ו־lamotrigine) עשויים להפחית מעט את התסמינים בטווח הקצר. אולם, כמו כל התרופות, יש לשקול בזהירות הראויה את הסיכונים ואת היתרונות שלהם.

הטיפול בהפרעות אישיות אחרות

לפי שעה, הטיפול בהפרעות מאשכול A ובהפרעות אחרות מאשכול B אינו נראה מבטיח כמו ההתקדמות שחלה בעת האחרונה בטיפול בהפרעת אישיות גבולית. בהפרעת אישיות סכיזופרנית, מינון נמוך של תרופות אנטי־פסיכוטיות (כולל תרופות אנטי־פסיכוטיות לא טיפוסיות חדשות) (למשל Keshavan et al., 2004; Koenigsberg et al., 2007; raine, 2006) עשוי להביא לשיפורים צנועים. תרופות נוגדות דיכאון ממשפחת ה־SSRIs עשויות גם הן להביא תועלת. עם זאת, עד כה שום טיפול לא הצליח לחולל תוצאה המתקרבת לריפוי רוב הלוקים בהפרעה זו (Koenigsberg et al., 2002, 2007; Markovitz, 2001, 2004; Silk & Feurino, 2012). להוציא מחקרים לא מבוקרים או תיאורי מקרה בודדים, אין לפי שעה מחקרים מבוקרים שיטתיים על טיפול באמצעות תרופות או טיפולים פסיכולוגיים בבני אדם עם הפרעות פרנואידיות, סכיזואידיות, נרקסיסטייות או היסטריוניות (Beck et al., 2003; Crits-Christoph & Barber, 2007). אחת הסיבות לכך היא שבני אדם אלה (בשל טבעה של פתולוגיית האישיות שלהם) פונים לטיפול רק לעיתים נדירות.

הגם שהוא טרם נחקר בהרחבה, הטיפול בכמה מההפרעות מאשכול C כגון הפרעת אישיות תלותית והפרעת אישיות נמנעת, נראה מבטיח קצת יותר. וינסטון ועמיתיו (Winston et al., 1994) מצאו שיפור ניכר במטופלים עם הפרעות מאשכול C בעזרת צורה של טיפול פסיכולוגי קצר טווח שהוא פעיל ונושא אופי של עימות (ראו גם Pretzer & Beck, 1996). במחקרים אחדים שבהם השתמשו בטיפול קוגניטיבי־התנהגותי להפרעת אישיות נמנעת דווח גם כן על הישגים משמעותיים (ראו Crits-Christoph & Barber, 2007), ובניתוח־על הגיעו החוקרים למסקנה שגם טיפול קוגניטיבי־התנהגותי וגם טיפול פסיכודינמי מביאים להישגים ארוכי טווח (Simon, 2009). במחקר שנערך בהולנד נמצא שטיפול קצר־מועד במטופלים מאושפזים עם הפרעות מאשכול C יעיל אף יותר מטיפול ארוך טווח במאושפזים או במטופלים במרפאות חוץ (Bartak et al., 2011). גם תרופות נוגדות דיכאון ממשפחות מעכבי המונואמין אוקסידז וה־SSRIs עשויות לפעמים לסייע בטיפול בהפרעת אישיות נמנעת, בדיוק כפי שהן מסייעות בפוביה חברתית, הדומה לה מאוד (Koenigsberg et al., 2007; Markovitz, 2011).

שאלות חזרה



- מדוע הפרעות אישיות עמידות במיוחד לטיפול?
- באילו נסיבות אנשים עם הפרעות אישיות מתחילים בדרך כלל טיפול פסיכולוגי?
- מה ידוע על מידת יעילותם של טיפולים בהפרעת אישיות גבולית?

פסיכופתיה

יעד לימוד 10.8 לתאר את המאפיינים הקליניים של פסיכופתיה ולהסביר את הדמיון ואת השוני בינה ובין הפרעת אישיות אנטי-חברתית.

השימוש במושג הפרעת אישיות אנטי-חברתית החל ב־1980 כאשר הפרעות אישיות נכללו לראשונה ב־DSM (ב־DSM-III). עם זאת, עוד קודם למועד זה, מטפלים וחוקרים התעניינו בתסמונת שכונתה בתחילה אישיות סוציופתית אך כיום ידועה כ**פסיכופתיה**. התסמונת זוהתה לראשונה במאה ה־19 כאשר תיארו אותה במושגים כגון אי־שפיות ללא דליריום (manie sans delire), חולשה מוסרית או אי־שפיות מוסרית (ראו Patrick & Drislane, 2015). קלקלי (Cleckley, 1941) סיפק בשנות הארבעים של המאה ה־20 את התיאור המוקדם המקיף ביותר של פסיכופתיה. בספרו משנת 1941, *The Mask of Sanity*, תיאר קלקלי חקרי מקרים מפורטים של אנשים שהוא זיהה כפסיכופתים. הוא גם ציין 21 תכונות ליבה של פסיכופתיה. במרוצת הזמן, הן עודכנו ופחתו ל־16 תכונות (Cleckley, 1988), כפי שמופיע ב**טבלה 10.4**.

פסיכופתיה (psychopathy)

טבלה 10.4 הקריטריונים של פסיכופתיה על פי קלקלי

קסם אישי שטחי ו"אינטליגנציה" טובה
היעדר הרהורי שווא או סימנים אחרים של חשיבה לא הגיונית
היעדר עצבנות או ביטויים פסיכונרוטיים
חוסר מהימנות
חוסר יושר וכנות
היעדר חרטה או בושה
התנהגות אנטי-חברתית מתוך מוטיבציה בלתי הולמת
שיקול דעת לקוי והיעדר למידה מניסיון
אגוצנטריות פתולוגית ואי־יכולת לאהוב
דלות כללית בתגובות רגשיות עיקריות
היעדר תובנות באשר לעצמם*

חוסר תגובתיות ביחסים בין-אישיים כלליים
התנהגות פנטסטית ובלתי מזמינה, עם שתיית אלכוהול ולעיתים בלעדיה
התאבדות במקרים נדירים בלבד
חיי מין לא אישיים, פשוטים ומזדמנים
כישלון בדבקות בתוכנית כלשהי לחיים

מקור: Cleckley, H. (1988). *The Mask of Sanity*, 5th ed., Augusta, GA: Emily S. Cleckley, pp. 337-338.

* קלקלי כתב "specific loss of insight" וציין שלפסיכופתים אין תובנות על טבע ועל כמות הבעיות הפסיכולוגיות שלהם וגם אין להם יכולת לראות את עצמם כפי שאחרים רואים אותם.

תפוצתה של פסיכופתיה אינה ידועה מכיוון שלא נערכו מחקרים אפידמיולוגיים המודדים אותה. עם זאת, התפוצה בקרב גברים באמריקה הצפונית נאמדת ב-1% עד 2% (Patrick & Drislane, 2015). שיעור התפוצה המוערך בקרב נשים קטן בהרבה (פחות מאחוז אחד). יש גם לציין כי המאפיינים של הפרעת אישיות אנטי-חברתית ב-DSM-5, השמים דגש חזק על קריטריונים התנהגותיים שניתנים למדידה באופן אובייקטיבי, אינם משקפים במלואם את מבנהו המקורי של מושג הפסיכופתיה. הדבר נעשה בכוונה תחילה בניסיון להגדיל את מהימנות האבחנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית (כלומר רמת תמימות הדעים של מטפלים לגבי אבחנה זו). עם זאת, חוקרים רבים הביעו חשש מכך שהמהימנות הודגשה מאוד על חשבון התוקף וכי מאפיינים מרכזיים רבים של פסיכופתיה לא נכללו בקריטריונים האבחנתיים. סוגיות אלה עוררו שאלות בדבר הדמיון בין המבנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית לבין פסיכופתיה. ככלל, מסכימים על כך שישנה מידה לא קטנה של חפיפה ביניהן, אף שהאבחנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית כוללת יותר ומשקפת פשיעה רבה ואילו האבחנה של פסיכופתיה צרה יותר וממוקדת הרבה יותר במבנה האישיות.

ממדי הפסיכופתיה

רוברט הייר (Hare, 1980, 1991, 2003) תרם תרומה גדולה כאשר זיהה את הצורך בכלי הערכה מהימן ותקף ופיתח רשימת תיוג של 20 פריטים לאבחון פסיכופתיה (PCL-R – Psychopathy Checklist-Revised). רשימת התיוג מאפשרת למטפלים ולחוקרים לאבחן פסיכופתיה על בסיס הקריטריונים של קלקלי באמצעות ריאיון מפורט ובדיקה קפדנית של רשומות מבית הספר, מהמשטרה ומהכלא. מדד זה רווח בשימוש בהערכות משפטיות.

במחקרים מקיפים שבהם השתמשו ברשימת תיוג זו נמצא כי ההבנה הטובה ביותר של פסיכופתיה יכולה להגיע בעזרת ארבעת הממדים שלהן (Hare et al., 2012). שימו לב כי במחקרים המוקדמים יותר, הממד הבין-אישי והממד הרגשי שולבו יחד ונקראו גורם 1. בדומה, הממדים של סגנון חיים ואנטי-חברתיות שולבו ונקראו גורם 2. משום כך, אנו מסמנים את ארבעת הממדים כ-1א, 1ב, 2א ו-2ב.

- 1א. הממד הבין-אישי משקף סגנון אישיות המתאפיין בחלקלקות / קסם אישי שטחי, הערכה עצמית מוגזמת, שקרנות פתולוגית ומניפולציות להונאת הזולת.
- 1ב. הממד הרגשי משקף תכונות כגון היעדר חרטה או רגשי אשם, קשיחות / היעדר אמפתיה, רגשיות רדודה וחוסר יכולת של האדם לקבל אחריות על התנהגותו.
- 2א. הממד של סגנון חיים משקף צורך בגירויים, נטייה להשתעמם מהר, אימפולסיביות, חוסר אחריות, היעדר מטרות ארוכות טווח המתקבלות על הדעת וסגנון חיים טפילי.
- 2ב. לבסוף, הממד האנטי-חברתי משקף את ההיבטים של פסיכופתיה הכוללים שליטה לקויה בהתנהגות, בעיות התנהגות בגיל צעיר, עבריינות ופשיעה.

ממד סגנון החיים והממד האנטי-חברתי קרובים הרבה יותר לאבחנות של הפרעת אישיות אנטי-חברתית ב-DSM מאשר הממדים הבין-אישי והרגשי (Widiger, 2006). אין פלא אפוא כי בהשוואות שנערכו בבתי כלא בין שיעור העבריינים המתאימים לאבחנה של פסיכופתיה לבין אלה המתאימים לאבחנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית נמצא על פי רוב כי 70% עד 80% מהם עונים על הקריטריונים של הפרעת אישיות אנטי-חברתית ורק 25% עד 30% מתאימים לקריטריונים של פסיכופתיה (Patrick, 2005). בניסוח אחר במקצת, מספר משמעותי של אסירים מציגים את ההתנהגויות האנטי-חברתיות והתוקפניות הנחוצות לאבחנת הפרעת אישיות אנטי-חברתית, אך אינם מציגים התנהגויות אנוכיות, קשוחות ונצלניות המצדיקות אבחנה של פסיכופתיה.

הסוגיות סביב האבחנות האלה עדיין שנויות במחלוקת עזה. צוות העבודה של DSM-5 קיים דיונים רבים על הרחבת הקריטריונים לאבחנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית כדי לכלול בה יותר תכונות של פסיכופתיה. בסופו של דבר לא הוכנסו שינויים רשמיים. גישה חלופית לאבחון הפרעת אישיות אנטי-חברתית (ששמה יותר דגש על תכונות אישיות פתולוגיות) מופיעה כעת בחלק III ב-DSM-5 וכנראה תזכה בתשומת לב רבה יותר בעתיד. הדברים מסתבכים עוד יותר כיוון שחוקרים רבים ממשיכים להשתמש באבחון של פסיכופתיה על פי קלקלי או הייר ולא באבחון של הפרעת אישיות אנטי-חברתית לפי DSM-5, לא רק בשל המסורת הארוכה והעשירה של חקר הפסיכופתיה אלא גם משום שהוכח כי האבחנה של פסיכופתיה מנבאת טוב יותר תת-מרכיבים חשובים של התנהגות עבריינית מאשר האבחנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית (Hare et al., 2012). ככלל, נראה כי אבחנה של פסיכופתיה היא המנבא היחיד הטוב ביותר לאלימות ולהפרות חוק החוזרות לאחר מאסר (Douglas et al., 2006; Grette et al., 2004). ראו גם (Leistico et al., 2008). יתרה מזו, כפי שת^{רשים} 10.4 ממחיש, מתבגרים עם ציוני פסיכופתיה גבוהים מועדים יותר לעבריינות חוזרת, יש גם סיכוי גבוה יותר שיחזרו על ההתנהגות הזו מהר יותר (Grette et al., 2004).

מה בדבר אנשים שאינם נתפסים? בעיה נוספת בדבר ההמשגה העכשווית של הפרעת האישיות האנטי-חברתית היא שזו אינה כוללת אנשים שיש להם הרבה מן

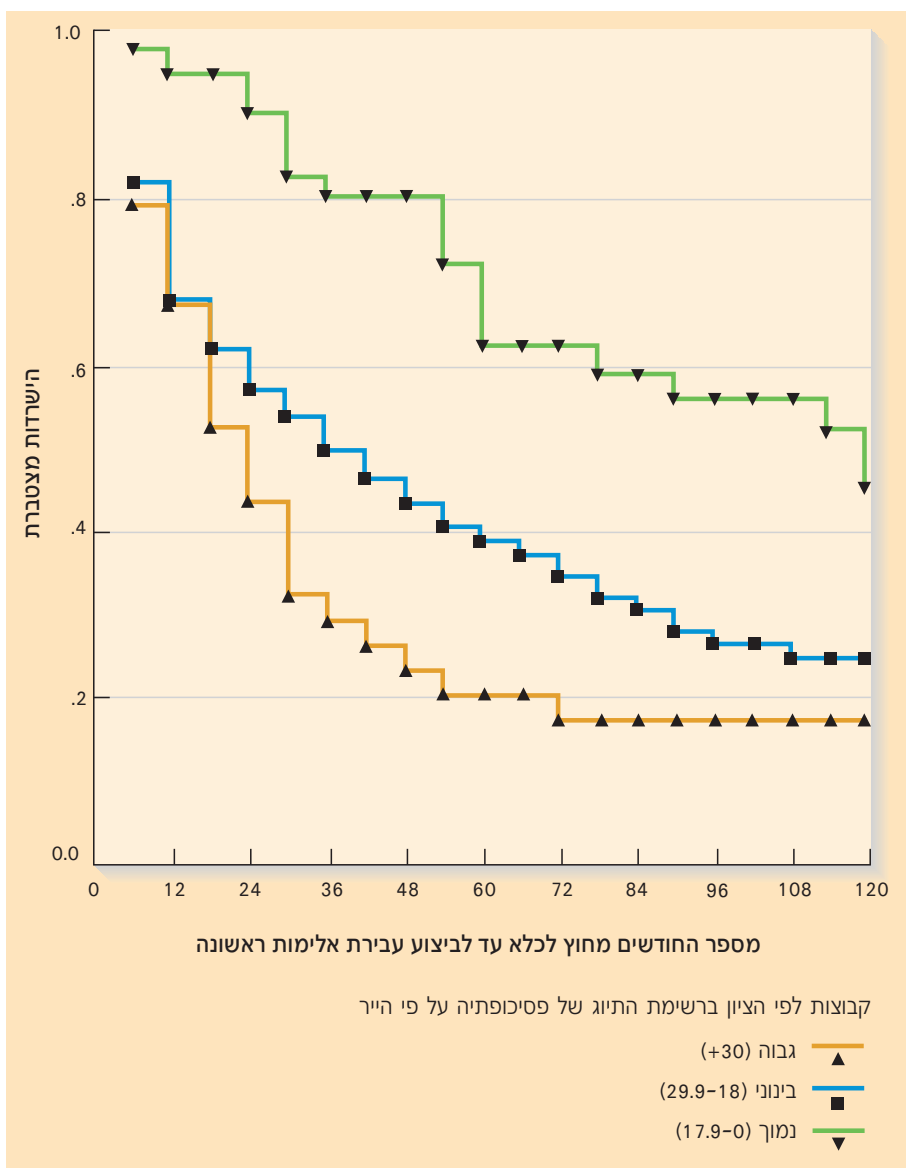
תרשים 10.4

עקומת הישרדות

עקומת הישרדות* על פי מספר החודשים ששהו בקהילה (לאחר השחרור) עד לביצוע עבירה אלימה חוזרת בפעם הראשונה, כפונקציה של הציון בגרסת הנוער של רשימת התיוג של הייר לפסיכופתיה. עקומת ההישרדות ממחישה את אחוז האנשים בכל קבוצה שלא ביצעו עבירה אלימה חוזרת במרווחים של 12 חודשים. האנשים שבקבוצת הציונים הגבוהים ברשימת התיוג של הייר, מועדים יותר לבצע שוב עבירה אלימה לעומת אלה שבשתי הקבוצות האחרות (הסתברות נמוכה יותר להישרדות), ויש סיכוי שיעשו זאת מהר יותר אחרי השחרור מהכלא (על כך מצביע השיפוע התלול יותר).

(מתוך: Gretton et al. (2004). Psychopathy and offending from adolescence to adulthood: A 10-year follow-up. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72, 636-645. Copyright © 2004 by the American Psychological Association. (Reproduced with permission

* "שורד" הוא מי שאינו עובר על החוק.



התכונות בממדים הרגשי והבינאישי של פסיכופתיה אך מספר לא גדול של תכונות בממד של סגנון חיים ושל אנטי-חברתיות, או שהן לפחות מעטות דיין כדי שאנשים אלה לא יסתבכו עם רשויות החוק. קבוצה זו יכולה להכיל לדוגמה אנשי מקצוע בלתי מוסריים ונצלנים בתחום הפיננסי והעסקי, עורכי דין מניפולטיביים, מטיפי דת עקשנים ופוליטיקאים מושחתים (Hall & Benning, 2006). קלקלי בוודאי לא חשב שהתנהגות תוקפנית היא מרכזית במושג של פסיכופתיה (Patrick, 2006). לפני שנים, החוקרת קאתי וידום (Widom, 1977) רצתה לחקור פסיכופתים שהצליחו להימנע ממאסר ופרסמה מודעה מתוחכמת בעיתון מחתרתי חדש בבוסטון:

האם אתם הרפתקנים? פסיכולוג חוקר בני אדם הרפתקנים וחסרי דאגה שמנהלים חיים מרגשים ואימפולסיביים. אם אתם מסוג האנשים שיעשו כמעט הכול בשביל אתגר ומעוניינים להשתתף בניסוי בתשלום, שלחו שם,

כתובת, מספר טלפון ותקציר של הביוגרפיה שלכם המוכיחה עד כמה אתם מעניינים ל... (p. 675).

גרסה מאוחרת יותר של המודעה:

דרושים אנשים בעלי קסם אישי, תוקפניים וחסרי דאגה, חסרי אחריות ואימפולסיביים אך יודעים כיצד לנהל בני אדם ודואגים בראש ובראשונה לעצמם. שלחו שם, כתובת...

מספר התשובות שוידום קיבלה היה מוגבל למדי. אדם אחד כתב: "האם את מחפשת יצאניות או שמא את מכינה רשימה של כל הסוציופתים בבוסטון?" (p. 675). אולם כאשר אלה שהשיבו קיבלו סוללה של מבחנים, התברר שהם דומים במבנה האישיות לזה של פסיכופתים במוסדות סגורים. כמה מחקרים נוספים על אנשים עם פסיכופתיה לא פלילית (לעיתים קרובות הם מכוונים פסיכופתים מצליחים) איששו ממצא זה (Hall & Benning, 2006; Hare et al., 1999). אף על פי כן, בהחלט ייתכן ששתי הקבוצות הללו נבדלות מבחינה ביולוגית בדרכים משמעותיות כלשהן.

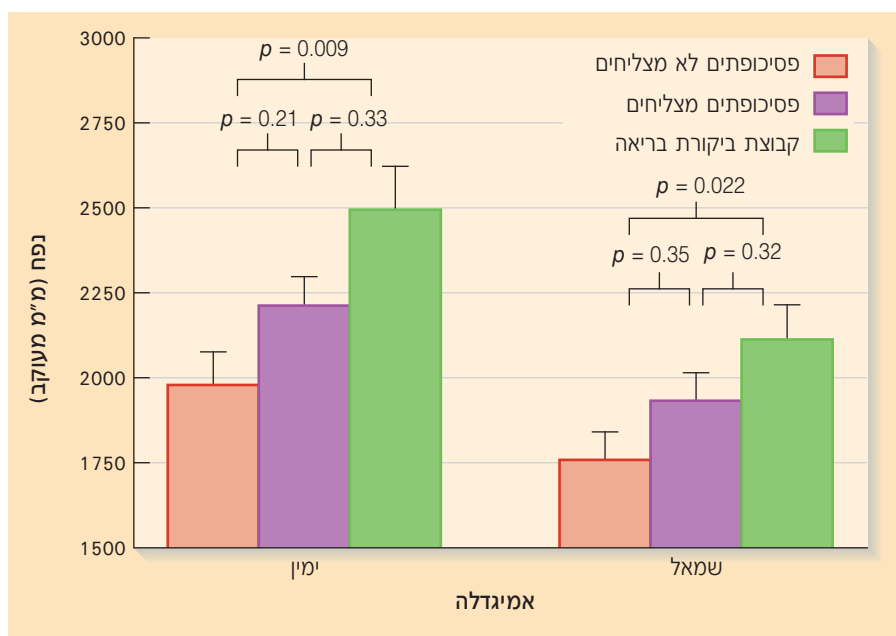
ריין ועמיתיו העלו רעיון חכם של גיוס פסיכופתים פושעים "מצליחים" ו"לא מצליחים" החיים בקהילה וקבוצת ביקורת מסוכנויות לתעסוקה זמנית (Ishikawa et al., 2001). באחד המחקרים, כל משתתף התבקש להציג בנאום קצר את חולשותיו ואת חסרונותיו האישיים והחוקרים צפו בו וצילמו אותו בוידאו. בזמן שהמשתתפים הכינו את הנאום שלהם והציגו אותו, החוקרים ניטרו את קצב ליבם. התוצאות הראו שקצב הלב של פסיכופתים מצליחים (שביצעו בערך את אותו מספר עבירות של הפסיכופתים הלא מצליחים ומאותו הסוג אך מעולם לא הורשעו) היה מהיר יותר בעת לחץ מזה של קבוצת הביקורת וגם של הפסיכופתים הלא מצליחים. אחת האפשרויות שעלו בעקבות הממצאים הללו הייתה שהקצב המוגבר של פעילות הלב אצל הפסיכופתים המצליחים עשוי לשרת אותם בעיבוד המתרחש בעת מצבים מסוכנים וייתכן שכך קל להם יותר לקבל החלטות שעשויות לסייע בידם להתחמק מהיתפסות. כפי שאפשר לראות במסגרת "התפתחויות במחקר", חוקרים לומדים כעת את תפוצתה של פסיכופתיה בסביבות עסקיות.

ישנם דיווחים גם על הבדלים אחרים במבנה המוח ובתפקודו. חוקרים סבורים כי ליקויים בקורטקס הקדם-מצחי (המעורב בשליטה על ההתנהגות ובקבלת החלטות) ובאמיגדלה (אזור מרכזי במוח המעורב ברגשות ובהתניית פחד) ממלאים תפקיד במקצת השיבושים ההתנהגותיים והרגשיים הקשורים לפסיכופתיה (Kiehl, 2006; Yang & Raine, 2009). אולם, נראה כי לפסיכופתים לא מצליחים יש ליקויים ברורים יותר באזורים אלה לעומת פסיכופתים מצליחים או חברי קבוצת הביקורת, הבריאים (Yang et al., 2010). לדוגמה, כפי שתראים **10.5** ממחיש, אצל הפסיכופתים הלא מצליחים ניכרת ההפחתה הרבה ביותר בנפח האמיגדלה בהשוואה לקבוצת הביקורת. לעומת זאת, ההפחתה בנפח האמיגדלה אצל הפסיכופתים המצליחים ניכרת הרבה פחות והיא אינה שונה באופן מובהק מקבוצת הביקורת. ליקויים באמיגדלה עשויים להיות קשורים להתניית פחד (שכפי שתלמדו בקרוב, משובשת אצל פסיכופתים) וכן לשיבושים בהתפתחות המוסרית ובקבוצות.

תרשים 10.5

נפחי האמיגדלה בצד הימני ובצד השמאלי (דו־צדדי) מופחתים אצל פסיכופתים "לא מצליחים" יחסית לפסיכופתים "מצליחים" ולקבוצת ביקורת בריאה. אצל פסיכופתים מצליחים יש אומנם הפחתה מסוימת בנפח האמיגדלה, אך הוא אינו שונה באופן מובהק מנפח האמיגדלה של קבוצת הביקורת. האמיגדלה היא אזור במוח המעורב בהתניית פחד. פחד מונע מאיתנו הסתבכות בצרות. אמיגדלה בנפח גדול יחסית עשויה לעזור לנו להבין מדוע פסיכופתים מצליחים נמנעו מהרשעה פלילית ואילו פסיכופתים לא מצליחים הורשעו.

(מקור: Yang et al., 2010)



התפתחויות במחקר

האם הבוס שלכם הוא פסיכופת?



עלה שציון גבוה בפסיכופתיה היה קשור לדירוגו של האדם (על ידי עמיתיו) כבעל מיומנויות תקשורת טובות וחשיבה אסטרטגית וכיצרתי וחדשני. אולם, ציון גבוה בפסיכופתיה היה קשור גם לתפיסה שהאדם אינו עובד טוב בצוות ושגנון הניהול שלו גרוע. בהתאם לממצאים אלה, מי שקיבלו ציונים גבוהים בפסיכופתיה נטו לקבל דירוג נמוך בהערכת ביצועים.

לפי ממצאי המחקר הזה, שיעורי הפסיכופתיה עשויים להיות גבוהים יותר במדגמים בתעשייה (4%) מאשר במדגמים בקהילה (1%) אך הם אינם מגיעים לשיעורים הגבוה בקרב פושעים גברים (15%). כמו כן, הממצאים מראים שפסיכופתים יכולים להגיע רחוק בעולם התעשייה למרות הערכות ביצוע שליליות ומיומנויות ניהול גרועות. בבביאק ועמיתיו (Babiak et al., 2010) משערים שתכונות של הפסיכופת כגון קסם אישי וחשיבות עצמית נתפסות בטעות כמיומנויות מנהיגות וחזון. בדומה, היעדר אמפתיה או חרטה יכול להיתפס כקור רוח בעת מתקפה וכיכולת לקבל החלטות קשות ובלתי פופולריות. כך או כך, נראה כי לפחות בחלק מסביבות העבודה, תכונות פסיכופתיות אינן בהכרח מכשול בסולם הקידום בחברה.

כותרות באמצעי התקשורת וסרטי פשע בטלוויזיה נוטים לחזק את התפיסה הרווחת בציבור שפסיכופתיה קשורה תמיד לאללימות ולמעשים פליליים. אולם, כפי שרוברט הייר העיר פעם כבדרך אגב "לא כל הפסיכופתים נמצאים מאחורי סורג ובריח. חלקם נמצאים בחדר הישיבות של ההנהלה" (ראו Babiak et al., 2010, p. 174). מחקרים מראים שהוא צדק. בבביאק ועמיתיו חקרו 203 אנשי מקצוע בתעשייה שעבדו בחברות בארצות הברית. כחלק מהערכה שעברו כדי להתקבל לתוכנית לפיתוח מנהלים, כל המועמדים מילאו את סולם הפסיכופתיה של הייר. נוסף על כך, 5 עד 10 מעמיתיהם דירגו אותם כחלק מהערכת משוב של 360 מעלות (מכונה כך מכיוון שהנתונים על היעד נאספים מכל סביבתו של האדם המוערך: כפיפים, מנהלים, עמיתים).

כפי שאפשר היה לצפות, רוב האנשים קיבלו ציון בטווח הנמוך של הסולם. עם זאת, הציון של ארבעה אחוזים מן המשתתפים חרג מעל סף הפסיכופתיה. יתרה מזו, מתוך אלה שקיבלו ציונים בטווח הגבוה, שניים היו סגני מנהל החברה, שניים – דירקטורים ושניים – מנהלים או מפקחים! במילים אחרות, הם הגיעו למעמד גבוה בחברות שלהם. מן הממצאים

התמונה הקלינית בפסיכופתיה

במפגש ראשון עם פסיכופתים הם לרוב מקסימים, ספונטניים וקל לחבב אותם, אך פסיכופתים הם ערמוניים ומניפולטיביים והם מנצלים בחוסר רגישות את זולתם להשגת מטרותיהם. רגשותיהם של אחרים אינם מכבידים עליהם והם חופשיים להתנהג כחיות טרף חברתיות, לקחת מכל הבא ליד ולעשות ככל העולה על רוחם, לפעמים ללא סיבה טובה יותר משעמום. לפיכך הם מסוכנים מאוד לאחרים והרסניים עבור החברה.

להלן נסכם את המאפיינים העיקריים של פסיכופתים ואחר כך נתאר מקרה המדגים את הטווח הרחב של דפוסי ההתנהגות העשויים להיראות אצלם. אומנם בדרך כלל לא כל המאפיינים שעליהם נעמוד בסעיפים הבאים מתקיימים בכל מקרה ומקרה, אך הם טיפוסיים לפסיכופתים, כפי שתיאר לראשונה קלקלי (Cleckley, 1941). קבוצה של מאפיינים אלה מתקיימת גם בהפרעת אישיות אנטי-חברתית.

התפתחות לא נאותה של המצפון

נראה כי פסיכופתים מסוגלים להבין ולקבל ערכים אתיים רק ברמה המילולית. הם יכולים לטעון בחלקלקות שהם דבקים בסטנדרטים מוסריים גבוהים, אך אין כל קשר ביניהם לבין התנהגותם בפועל. התפתחות המצפון שלהם מפגרת פיגור חמור או שכלל לא קיימת התפתחות כזאת, והם מתנהגים כאילו תקנות וחוקים חברתיים אינם חלים עליהם (Frick & Marsee, 2006; Salekin, 2006). מאפיינים אלה קשורים קשר הדוק לליבה הבין-אישית והרגשית של פסיכופתיה (Fowles & Dindo, 2006). על אף העיכוב בהתפתחות המצפון שלהם, ההתפתחות האינטלקטואלית שלהם תקינה בדרך כלל. אף על פי כן, אינטליגנציה היא תכונה שיש לה קשרים אחרים עם הממדים השונים של פסיכופתיה. הממדים הרגשי והבין-אישי קשורים באופן חיובי לאינטליגנציה מילולית (Salekin et al., 2004) וממד סגנון החיים וממד האנטי-חברתיות קשורים באופן שלילי לאינטליגנציה (Frick, 1998; Hare et al., 1999).

התנהגות לא אחראית ואימפולסיבית

פסיכופתים לומדים לקחת במקום להרוויח ביושר את מה שהם רוצים. מאחר שהם מועדים לרדיפה אחר ריגושים ואחר התנהגות חריגה ובלתי מקובלת, הם לעיתים קרובות עוברים על החוק באימפולסיביות ובלי לחשוב על התוצאות. רק לעיתים רחוקות הם מוותרים על הנאה מיידיית למען רווחים עתידיים ומטרות לטווח ארוך. היבטים אלה של פסיכופתיה קשורים קשר הדוק עם ממד סגנון החיים והממד האנטי-חברתי של פסיכופתיה (Patrick, 2005).

מחקרים רבים מצביעים על שיעורים גבוהים של שימוש מזיק ותלות באלכוהול ושל הפרעות נוספות הקשורות לשימוש מזיק או תלות בחומרים אחרים בקרב אנשים עם אישיות אנטי-חברתית ואצל מקצת הפסיכופתים (למשל Taylor & Waldman & Slutske, 2000; Lang, 2006). שימוש מזיק באלכוהול קשור רק

לממדים סגנון חיים / אנטי-חברתיות ברשימת התיג של הייר (Patrick, 2005; Reardon et al., 2002). שיעור ניסיונות ההתאבדות וההתאבדות, גם הם קשורים רק לממדים אלה ולא לממדים הבין-אישי והרגשי (Verona et al., 2001).

יכולת להרשים אחרים ולנצל אותם

לעיתים קרובות לפסיכופתים יש קסם אישי מלאכותי והם מתחבבים בקלות, עם סגנון שובה לב המאפשר להם לרכוש חברים חדשים בקלות (Cleckley, 1941; Patrick, 2006; 1976). נראה כי הם ניחנו בהבנה טובה של צורכי הזולת ושל חולשותיו והם מנצלים אותם במיומנות רבה. הם שקרנים אך בדרך כלל נדמה שהם מצטערים בכנות אם נתפסו בשקר. הם מבטיחים לתקן את דרכיהם אך אינם עושים כן. אין תמה אפוא שרק לעיתים נדירות פסיכופתים מסוגלים לשמור על חברים קרובים. נראה שהם אינם יכולים להבין אהבה אצל אנשים אחרים או להשיב אהבה לזולתם. במערכות יחסים מיניות, פסיכופתים הם שותפים חסרי אחריות ובוגדניים, והם מניפולטיביים, נצלנים ולפעמים כופים את עצמם בכוח.

הייר, חוקר בעל השפעה רבה בתחום זה, מסכם את הפסיכופת הטיפוסי במילים אלה:

המשגת הפסיכופתים כחיות טרף שאינן יודעות רחם סייעה לי להבין את מה שלעיתים קרובות נראה כמו התנהגות חסרת כל היגיון. אלה הם אנשים חסרי מצפון ורגש כלפי בני אדם אחרים שקל להם להשתמש בקסם אישי, במניפולציות, באימים ובאלימות כדי לשלוט באחרים ולספק את הצרכים החברתיים שלהם עצמם [...] בלי שמץ תחושת אשם או חרטה [...] הם מהווים חלק יחסי משמעותי מהפושעים הכרוניים, מסוחרים הסמים, מהאנשים המתעללים בבני או בבנות זוגם ובילדים, מהרמאים ומהנוכלים [...]. הם מיוצגים היטב בעולם העסקים והתעשייה, בייחוד כשעורכים שינויים גדולים במבנה הארגון, כאשר אין מקפידים על החוקים ועל אכיפתם [...]. פסיכופתים רבים מופיעים כ"פטרוטים" וכ"מושיעים" בחברות שעוברות מהפך חברתי, כלכלי ופוליטי (למשל רואנדה, יוגוסלביה לשעבר וברית המועצות לשעבר) [...], והם עושים זאת באמצעות ניצול מתחים ומחאות אתניים, תרבותיים ובין-גזעיים (Hare, 1998, pp.128-129).

חקר המקרה הקלאסי שלפנינו, שפרסם הייר ב-1970, ממחיש היטב פסיכופתיה מהי:

פסיכופת בפעולה

דונלד, בן 30, סיים זה עתה לרצות מאסר של שלוש שנים על הונאה, על ביגמיה, על התחזות ועל בריחה ממעצר חוקי. הנסיבות שהובילו לעבירות אלה מעניינות ומתאימות להתנהגותו בעבר. כאשר נותר לו רק חודש אחד לסיום תקופת מאסר קודמת של 18 חודשים על הונאה, הוא התחזה לחולה ונמלט מבית החולים של הכלא. במהלך עשרת החודשים שבהם היה חופשי

הוא עסק במגוון יוזמות בלתי חוקיות. הפעילות שהביאה ללכידתו הייתה טיפוסית לשיטת הפעולה שלו. הוא נהג להציג את עצמו כ"מנהל בשדה" של ארגון פילנטרופי בין-לאומי וכך עלה בידו לגייס סיוע מכמה ארגונים דתיים במסע התרמות. מסע ההתרמות התקדם בהתחלה לאט, ובמאמץ להאיץ אותו ארגן דונלד לעצמו ריאיון בתחנת הטלוויזיה המקומית. הופעתו בריאיון הייתה כה מרשימה עד כי כספים החלו לזרום. אולם, לרוע מזלו הריאיון שודר גם ברשת חדשות ארצית. הוא זוהה ונאסר מייד. במשפט התברר שדונלד לא חש שמשהו במעשיו אינו כשורה. הוא טען כי רוב התרומות הגיעו מבני אדם החשים רגשי אשם עקב משהו ולכן מגיע להם שירמו אותם.

בעת שהותו בכלא, דונלד השתתף במחקרים אחדים שערך מחבר ספר זה. עם שחרורו, ניסה להתקבל לאוניברסיטה, וכשהתבקש לספק המלצות סיפר לפקיד ההרשמה כי היה אחד מעמיתי המחקר של המחבר! כעבור חודשים אחדים המחבר קיבל ממנו מכתב ובו בקשה לכתוב לו מכתב המלצה לצורך קבלה לעבודה.

רקע. דונלד היה הצעיר בין שלושה בנים שנולדו להורים בני המעמד הבינוני. שני אחיו ניהלו חיים נורמליים ופרודוקטיביים. אביו הקדיש זמן רב לעסקיו. כשהיה בבית, נטה לשקוע במצבי רוח והרבה לשתות אלכוהול כשדברים לא התנהלו כשורה. אימו של דונלד הייתה אישה עדינה וביישנית שניסתה לרצות את בעלה ולשמור על מראית עין של הרמוניה משפחתית... אולם... במקרים אחדים האב היה נתקף זעם ומכה את הילדים ובמקרים אחרים הוא היה נוזף בהם מילולית לעיתים באופן מתון ולעיתים באופן חמור.

לפי כל הדיווחים, דונלד נחשב לילד עקשן וקשה. כאשר לא קיבל ממתקים או צעצועים שרצה היה מתחיל בהפגנת חיבה, ואם זה לא עזר, היה מגיב בהתקף זעם. התקף זעם היה נחוץ רק לעיתים רחוקות שכן הודות למראהו המלאכי ולשיטותיו המתוחכמות הוא בדרך כלל השיג את מבוקשו... אף שהיה ברור שהוא אינטליגנטי מאוד, הוא לא הצטיין במיוחד בשנות לימודיו. הוא היה חסר מנוחה, השתעמם בנקל והרבה להיעדר מבית הספר... כשהיה לבדו, דונלד היה מסתבך בצרות או מסבך אחרים. לעיתים קרובות החשד להפרת החוק נפל עליו, אך הוא היה מיומן בהיחלצות מצרות.

התנהגותו הרעה של דונלד בילדותו לבשה צורות רבות כולל שקרים, מרמה, גניבות קטנות ובריונות כלפי ילדים קטנים יותר. כשהתבגר, הלכה וגברה התעניינותו במין, בהימורים ובאלכוהול. בגיל 14 עשה דונלד ניסיונות גסים להתקרב מינית לילדה צעירה יותר וכאשר היא איימה לספר להוריה נעל אותה במחסן. חלפו כ-16 שעות עד שהילדה נמצאה. בתחילה דונלד הכחיש כל ידע על התקרית, אחר כך טען שהיא פיתתה אותו וכי דלת הצריף כנראה ננעלה מעצמה... הוריו הצליחו למנוע הגשת כתב אישום נגדו.

כשדונלד היה בן 17, הוא זייף את חתימתו של אביו על המחאה בסכום גדול ובילה כשנה במסע סביב העולם. נראה שהוא חי בנעימים, והשתמש בשילוב של קסמו האישי, מראהו המושך והעמדת פנים למימון מסעו. בשנים שלאחר מכן עבד בעבודות שונות ואף פעם לא התמיד בהן יותר מחודשים אחדים. במהלך תקופה זו הוא הואשם במגוון עבירות, לרבות גניבה, שכרות במקום ציבורי, תקיפה ועבירות תנועה רבות. ברוב המקרים הוטלו עליו קנסות או עונשים קלים.

גבר של נשים. לדונלד היו התנסויות מיניות תכופות, אקראיות וקשוחות. בגיל 22 הוא התחתן עם אישה בת 41 שפגש במסבאה. אחר כך באה סדרה של נישואים נוספים, כולם ביגמיים... הדפוס תמיד חזר על עצמו. הוא היה מתחתן עם מישהי על פי דחף רגעי, נותן לה לתמוך בו כלכלית במשך כמה חודשים ואז עוזב אותה. אחת מפרשות הנישואים הייתה מעניינת במיוחד. לאחר שהורשע בהונאה, נשלח דונלד למוסד פסיכיאטרי לתקופת הסתכלות. בעת שהותו שם, הוא משך את תשומת ליבה של אחת מחברות הצוות המקצועי. קסמו האישי, הופעתו המושכת והבטחותיו המשכנעות לתקן את דרכיו גרמו לה להחליט להתערב לטובתו. הוא קיבל עונש של מאסר על תנאי וכעבור שבוע השניים נישאו. בתחילה התנהלו הדברים כשורה, אך כאשר היא סירבה לשלם כמה מחובות ההימורים שלו, הוא זייף את חתימתה על המחאה והסתלק. עד מהרה הוא נתפס ונשפט לתקופה של 18 חדשי מאסר... הוא נמלט מן הכלא כאשר נותר לו פחות מחודש לריצוי עונשו.

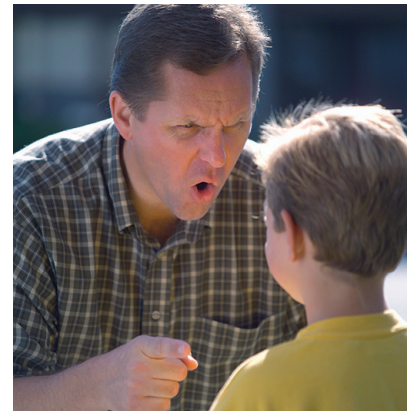
מעניין לציין שדונלד אינו רואה כל פסול בהתנהגותו וגם אינו מביע חרטה או רגשי אשם על כך שניצל אחרים וגרם להם עוגמת נפש. אף שבטווח הארוך הוא מזיק לעצמו בהתנהגותו, הוא סבור שהיא מעשית ונבונה. העונשים המוטלים עליו מדי פעם אינם משפיעים כהוא זה על מידת האנוכיות שלו ועל ביטחונו ביכולותיו... התנהגותו אגוצנטרית לגמרי וצרכיו מסופקים בלי כל התחשבות ברגשותיהם וברווחתם של אנשים אחרים (צוטט באישור של Robert P. Hare, University of British Columbia, rhare@interchange.ubc.ca)

גורמים סיבתיים בפסיכופתיה

הסיבות לפסיכופתיה מורכבות והן כוללות גורמים רבים. סבורים כי גורמים גנטיים, מאפייני מזג, חוסר פחד וחרדה, ליקויים רגשיים כלליים יותר, רגישות קיצונית לתגמול, לימוד מוקדם של התנהגות אנטי-חברתית כסגנון התמודדות וגורמים משפחתיים וסביבתיים ייחודיים, כל אלה עשויים להיות מעורבים בפסיכופתיה.

השפעות גנטיות

עד לעת האחרונה, רוב המחקר הגנטי של ההתנהגות התמקד בהשפעות גנטיות וסביבתיות על התנהגות אנטי-חברתית או על פשיעה ולא על הפסיכופתיה עצמה. אולם היו כמה מחקרים גדולים שהצביעו על מידה ניכרת של תורשתיות בפסיכופתיה ובכמה מהמאפיינים החשובים שלה (למשל, Blonigen et al. 2003, 2006; לסקירות ראו Waldman & Rhee, 2006; Hare et al., 2012). לדוגמה, במחקר של 3,687 זוגות תאומים בני 7 נמצא כי סימנים מוקדמים של תכונות קשיחות / חוסר רגש בילדים אלה היו במידה רבה תורשתיים (Viding et al., 2005). יתרה מזו, ילדים עם תכונות מדאיגות אלה חשופים גם לרמות גבוהות של הורות שלילית (כגון כעס ותסכול של ההורים). מכאן עולה האפשרות שתכונות של קשיחות וחוסר רגש אצל ילדים צעירים עשויות לעורר אצל ההורים את סוג התגובות שעלול להגדיל את הסיכון להתנהגות אנטי-חברתית בעתיד (Larsson et al., 2008). על בסיס מחקר בהשתתפות יותר מ-1,000 תאומים, התקבל אומדן שלפיו בין 43% ל-56% מהשונות בממדי הפסיכופתיה מיוחסים לגורמים גנטיים, ויתר השונות מוסברת יותר על ידי השפעות סביבתיות שאינן משותפות מאשר על ידי גורמים סביבתיים משותפים (Larsson et al., 2006).



הורים עשויים לנקוט סגנון משמעת קשוח בתגובה לתכונות אישיות נוקשות ונטולות רגש אצל ילדיהם.

פחד נמוך והתניה לקויה לפחד

על פי מחקרים, לפסיכופתים שמקבלים ציון גבוה בממדי הגורם הראשון והם אגוצנטריים, קשוחים ונצלנים, יש חרדה נמוכה כתכונת אישיות והם מראים התניה חלשה לפחד (Fowles & Dindo, 2006; Lykken, 1995; Patrick 2005). ממצא זה מתיישב עם הליקויים באמיגדלה שתוארו קודם. באחד המחקרים הקלאסיים המוקדמים, ליקן (Lykken, 1957) מצא כי לפסיכופתים יש התניה לקויה לתגובות הולכה בעור (המשקפות הפעלה של מערכת העצבים הסימפתטית) כאשר הם מצפים לאירוע בלתי נעים או לכאב, וגם הלמידה להפסיק להגיב כדי להימנע מעונש איטית אצלם. משום כך, פסיכופתים כנראה אינם רוכשים רבות מן התגובות המותנות החיוניות להימנעות פסיבית נורמלית מעונש, להתפתחות תקינה של המצפון ולחברות. הייר (Hare, 1998) סיכם באופן מדויק עבודה על סוגיה זו: "המחשבות, הדימויים והדיאלוגים הפנימיים הטעונים רגשית הם ש"נוגסים" במצפון, מסבירים את שליטתו החזקה בהתנהגות ומחוללים רגשי אשם וחרטה על עבירות מוסריות. פסיכופתים אינם יכולים להבין זאת. עבורם, המצפון אינו אלא מעט יותר ממודעות אינטלקטואלית לכללים שאחרים קובעים - מילים ריקות" (p. 112).

מחקרים רבים שנערכו מאז עבודתו המוקדמת של ליקן אישרו כי לפסיכופתים יש ליקויים בהתניית פחד לפחות במרכיבים סובייקטיביים ובמרכיבים פיזיולוגיים מסוימים (למשל, Lykken, 2001; Fowles, 2002; Flor et al., 2005; Birbaumer et al., 1995), אם כי הם לומדים ברמה הקוגניטיבית בלבד שהגירוי המותנה מבשר את בואו של הגירוי הלא מותנה (Birbaumer et al., 2005). מכיוון שהתניה כזאת מונחת ביסודה של הימנעות מוצלחת מעונש, ליקוי זה עשוי להסביר גם מדוע התנהגותם האימפולסיבית נמשכת בלי כל בקרה.



הרוצח הסדרתי טד בנדי הציג התנהגות אנטי-חברתית בצורתה הקיצונית ביותר. בנדי ניצל את הופעתו המסודרת כדי להתקרב לקורבנותיו - בעיקר סטודנטיות צעירות - שתקף מינית ואחר כך רצח אותן באכזריות. הופעתו החיצונית עשתה רושם חיצוני של אזרח ישר והגון.

עבודות מעניינות אחרות עוסקות בתגובת בהלה. בני אדם ובעלי חיים כאחד מראים תגובת בהלה מוגברת לנוכח גירוי מבהיל (למשל רעש חזק מאוד) כאשר המשתתף בניסוי כבר נתון במצב של חרדה. מצב כזה נודע בשם בהלה המוגברת בעת פחד. פטריק ועמיתיו (Patrick et al., 1993) השוו בין אסירים פסיכופתים לאסירים שאינם פסיכופתים ומצאו שהתופעה לא נצפתה אצל הפסיכופתים אלא רק בקרב האסירים הלא פסיכופתים. בעת צפייה בשקופיות בלתי נעימות ונעימות, הפסיכופתים הראו תגובות בהלה נמוכות יותר מאשר בעת צפייה בשקופיות ניטרליות (לתוצאות דומות ראו גם Patrick, 1994; Suttan et al., 2002). חוסר בתגובת בהלה המוגברת בעת פחד מתקשר רק לממד הראשון הרגשי של פסיכופתיה ולא לממד השני, האנטי-חברתי (Patrick, 2005). ניומן ועמיתיו (למשל Baskin-Sommers et al., 2010; Newman & Lorenz, 2003) ערכו אף הם מחקר שלפיו פסיכופתים ממוקדים במידה מוגזמת בהשגת תגמול, והדבר עלול לפגוע ביכולתם להשתמש בעונש או ברמזי הקשר או במידע הקשרי כדי להתאים את התנהגותם. יתרה מזו, ניומן ועמיתיו העלו השערה שלפסיכופתים חסרה היכולת לווסת את תשומת הלב שלהם כאשר הם ממוקדים בהתנהגות מכוונת מטרה והם מפתחים דבר דומה לראיית מנהרה במרדף אחר השגת המטרה האחת והיחידה שלהם. אחת התוצאות של תופעה זו היא שהם נוטים להיות פחות קשובים למידע פריפרי יותר כגון מידע רגשי (למשל פחד) או לרמזים אחרים העשויים לספק פרספקטיבה רחבה יותר ולאפשר להם להעריך מצבים באופן מלא יותר. ניומן ועמיתיו מאמינים שהליקוי הזה בוויסות התגובה תופס מקום מרכזי יותר בפסיכופתיה מאשר חסר בפחד (או אפילו חסר רגשי כללי). ממצאים נוספים מכמה מחקרים מעניינים עולים בקנה אחד עם רעיון זה, והשפעת הגישה של ניומן הולכת ומתחזקת (Hare et al., 2012). עם זאת, עדיין ישנם חילוקי דעות סביב השאלה אם ההשערה על הליקוי בוויסות התגובה יכולה להסביר טווח רחב של ממצאים הקשורים לפחד נמוך ולחסרים רגשיים אחרים.

ליקויים רגשיים כלליים יותר

נראה כי לפסיכופתים יש יותר ליקויים רגשיים כלליים מאשר ליקויים פשוטים בהתניית חרדה. ממחקרי הדמיה מוחית אנו לומדים שאצל אנשים הלוקים בפסיכופתיה נראית פחות פעילות באמיגדלה (יחסית לקבוצת ביקורת), לא רק במהלך התניית פחד אלא גם כאשר הם צופים בפנים עצובים או מפוחדים (לסקירה כמותית ראו Marsh & Blair, 2008). פסיכופתים גם מראים תגובות פיזיולוגיות משמעותיות פחות למראה תמונות של מצוקה (שקופיות של אנשים בוכים) מאשר התגובות של אנשים שאינם פסיכופתים. ממצא זה מתיישב עם הרעיון שלפסיכופתים יש רמות נמוכות של אמפתיה (Blair, 2006; Blair et al., 1997) מלבד רמות נמוכות של פחד.

דסטי ועמיתיו (Decety et al., 2013) המחישו בדרך יפה את הדברים הללו. הם אספו נתונים של סריקות מוח מ-37 אסירים שקיבלו ציון גבוה בפסיכופתיה בעת שצפו בשקופיות במצבים מכאיבים (אצבע נתפסת בדלת) ובלתי מכאיבים (הנחת יד על ידית מגירה). מתנדבים אחרים, עם ציונים נמוכים או בינוניים בפסיכופתיה, עברו גם הם את אותם הליכים. בעת שצפו בתמונות, התבקשו המשתתפים מדי פעם לדמיין שהמתרחש בתמונה קורה להם באופן אישי. במקרים אחרים הם התבקשו לדמיין שהמצב (למשל אצבע שנתפסת בדלת) קורה למישהו אחר. כאשר הם דמינו כאב בעצמם, הופיעה אצל האסירים עם רמת הפסיכופתיה הגבוהה תגובה טיפוסית לעיבוד כאב באזורי מוח המעורבים באמפתיה, לרבות האינסולה הקדמית (anterior insula) והאמיגדלה. לעומת זאת, כאשר דמינו כאב של אדם אחר, הפעילות באזורים אלה פחתה. היה גם מעניין (ומצמרר למדי) לגלות שאצל הפסיכופתים בעלי הציונים הגבוהים ביותר בגורם 1 ברשימת התיוג של הייר בממדים הבין-אישי והרגשי, הייתה למעשה פעילות מוגברת במבנה המפוספס הגחוני (ventral striatum) כשהתבקשו לדמיין שהסצנה קרתה לאדם אחר (לעומת הפעילות שנראתה כאשר התבקשו לדמיין שהיא קרתה להם עצמם). אזור זה במוח מעורב בציפייה לתגמול. אחד הפירושים לממצאים אלה הוא שהפסיכופתים לא רק שמושפעים פחות ממצוקתם של אחרים אלא הם גם מוצאים הנאה מסוימת ברעיון שאחרים סובלים מכאב. ליקויים כאלה יכולים מצידם להיות קשורים קשר הדוק לליקויים בחשיבה ובהתנהגות מוסרית הנראית אצל פסיכופתים, שכן חשיבה על סוגיות מוסריות דורשת שלאדם יהיה אכפת מהזכויות ומהרווחה של זולתם (Blair, 2007).

אובדן הורה בגיל צעיר ודחייה וחוסר עקביות מצד ההורים

נוסף על הגורמים הגנטיים והליקויים הרגשיים, התפתחות איטית של המצפון ורמות גבוהות של תוקפנות תגובתית ותוקפנות אינסטרומנטלית מושפעות מהתוצאות המזיקות של דחייה, התעללות והזנחה הורית, המלווה בהטלת משמעת באופן לא עקבי (למשל Farrington, 2006; Luntz & Widom, 1994). עם זאת, מחקרים על האינטראקציות בין גנים לסביבה שתוארו קודם מראים בבירור שאין די בסוגי השיבושים הללו כדי להסביר את מקורות האישיות הפסיכופתית או האנטי-חברתית שכן אין ספק כי אנשים מסוימים רגישים להשפעות אלה יותר מאחרים. כמו כן, נמצא כי אותם תנאים קשורים לקשת רחבה של התנהגויות

לא הסתגלותיות בשלבים מתקדמים יותר בחיים. בסעיף שלהלן נציג גישה התפתחותית משולבת המשתמשת בגישה ביו-פסיכו-חברתית עם מסלולים סיבתיים משולבים רבים.

השקפה התפתחותית על פסיכופתיה

בעשור החולף פיתחו פריק ועמיתיו דרך להערכת תכונות של קשיחות וחוסר רגשיות, שכפי הנראה מייצגות ביטויים מוקדמים של הממד הראשון של פסיכופתיה (למשל, Frick & Marsee, 2006; Frick & Morris, 2004; Frick, Cornell, Bodin, et al., 2003; Frick, Cornell, Bodin, et al., 2003). הם שמו לב שלילדים יש לפחות שני ממדים שונים של מזג קשה שכנראה מובילים לתוצאות התפתחותיות שונות. מקצת הילדים מתקשים מאוד ללמוד לווסת את רגשותיהם ונראות אצלם רמות גבוהות של תגובתיות רגשית, לרבות התנהגויות תוקפניות ואנטי-חברתיות, כתגובה לדרישות מלחיצות ולרגשות שליליים כגון תסכול וכעס. ילדים כאלה מצויים בסיכון מוגבר לפתח הפרעת אישיות אנטי-חברתית ורמות גבוהות בממד האנטי-חברתי של הפסיכופתיה. אך לילדים אחרים ויסות רגשות שליליים אינו בעייתי במיוחד ולעומת זאת הם מראים חוסר פחד וחרדה מועטה וכן תכונות של קשיחות / חוסר רגשיות והפעלה פחותה של האמיגדלה בעת תגובה להבעות פנים מפחידות (למשל Marsh et al., 2008). אלה הילדים עם הסיכוי הגבוה ביותר להתפתחות מועטה של המצפון, והתנהגויותיהם התוקפניות הן יותר אינסטרומנטליות ומתוכננות מראש מאשר תגובתיות כפי שרואים בילדים עם קשיים בוויסות רגשות. ילדים עם קשיים אלה יפתחו כנראה רמות גבוהות של המאפיין המרכזי הראשון הבין-אישי בפסיכופתיה שמוביל לפסיכופתים קרי מזג, חסרי רחמים שיש להם רמות נמוכות של פחד ואמפתיה.

גורמים סיבתיים חברתיים-תרבותיים

פסיכופתים היו קיימים מאז ומתמיד. אפשר למצוא אותם בכל קבוצה חברתית-כלכלית, גזע, מוצא אתני ותרבות. ילידי אלסקה מכנים אנשים עם תכונות פסיכופתיות בשם "קונלנגטה" (kunlangeta). האנתרופולוגית ג'ין מרפי (Murphy) שאלה אדם ממוצא אינואיטי כיצד מטפלים בקונלנגטה בחברה האלסקית, והוא השיב לה "מישהו כבר ידחוף אותו מן הקרח בעת שאיש לא יראה". אף על פי כן, הביטויים המדויקים של ההפרעה מושפעים מגורמים תרבותיים, ונראה כי תפוצת ההפרעה משתנה גם היא בהתאם להשפעות חברתיות-תרבותיות המעודדות או שאינן מעודדות את התפתחותה (Cooke et al., 2005; Hare et al., 1999; Sullivan & Kosson, 2006).

אחד התסמינים הראשונים שבהם רואים הבדלים בין-תרבותיים בהפרעה הוא תדירותה של התנהגות תוקפנית ואלימה. לכוחות החברות יש השפעה עצומה על צורת הביטוי של דחפים תוקפניים. לכן, אין פלא שבתרבויות מסוימות, כגון סין, ההסתברות שפסיכופתים יהיו קשורים להתנהגות תוקפנית, בייחוד אלימה, נמוכה לאין שיעור מזו שברוב תרבויות המערב (Cooke, 1996). לעומת זאת, מחקרים בין-תרבותיים הראו שהממד הרגשי-בין-אישי בפסיכופתיה הוא הממד העקבי ביותר בכל התרבויות (Cooke et al., 2005).

זאת ועוד, אפשר לסווג תרבויות על פי מידת האינדיבידואליזציה או הקולקטיביזם שלהן. בחברות אינדיבידואליסטיות יחסית שמים דגש על תחרותיות, ביטחון עצמי ועצמאות, ואילו בחברות קולקטיביסטיות יחסית מעודדים יותר תרומה וכפיפות לקבוצה החברתית, קבלת סמכות ויציבות במערכות יחסים (Cooke, 1996; Cooke & Michie, 1999). לפיכך, נצפה שבחברות אינדיבידואליסטיות (כגון ארצות הברית) קיים סיכוי גבוה יותר לקידום כמה מהמאפיינים ההתנהגותיים שבמצב קיצוני מגיעים לפסיכופתיה. מאפיינים אלה כוללים "תחושת גדלות, חלקלקות ושטחיות, תאוותנות [...] וגם חוסר אחריות כלפי הזולת. [...] התחרותיות [...] לא רק מעלה את שיעור ההתנהגות העבריינית, אלא היא גם מובילה לשימוש גובר בהתנהגות מטעה, מניפולטיבית ופרזיטית" (Cooke & Michie, 1999, p. 65). אף שהראיות לכך מעטות, מעניין לציין כי אומדני תפוצת הפרעת האישיות האנטי-חברתית נמוכים הרבה יותר בטייוואן, חברה קולקטיביסטית יחסית, מאשר בארצות הברית (בערך 0.1%-0.2% לעומת 1.5%-4%).

הטיפול באישיות פסיכופתית ותוצאותיהם

פסיכופתים אינם חווים מצוקה אישית רבה והם מאמינים שאינם זקוקים לטיפול. מהסיבות שנדונו לעיל, ענישה היא בדרך כלל לא יעילה. אלה המסתבכים עם החוק עשויים להשתתף בתוכניות שיקום כל עוד זה מקדם את האינטרסים שלהם (למשל כשהם מנסים לקבל גזר דין קל יותר או מבקשים חנינה), אך לעיתים נדירות בלבד התוכניות הללו משנות אותם. במחקרים אחדים עלו ממצאים מדאיגים, שלפיהם טיפולים שהם יעילים עבור פורעי חוק אחרים עלולים לגרום נזק לפסיכופתים שכן שיעורי העבריינות החוזרת עולים ולא יורדים (Harris & Rice, 2006). הסיכוי שזה יקרה גבוה במיוחד אם תוכנית הטיפול מדגישה אימון במיומנויות חברתיות או באמפתיה, מכיוון שמיומנויות כאלה עשויות פשוט לשפר את מסכת קסמם האישי או את שיטות ההונאה של קורבנות בעתיד (Vitale & Newman, 2013). לאור זאת, חוקרים מציעים למקד יותר את הטיפול בשכנוע פסיכופתים שעליהם להשתמש ביכולותיהם ובכישוריהם כדי לספק את צורכיהם בדרכים חברתיות יותר (Hare et al., 2012).

טיפולים ביולוגיים לאישיות פסיכופתית או אנטי-חברתית לא נחקרו באורח שיטתי, בין היתר משום שאין הרבה ראיות להשפעה משמעותית של גישות כאלה. כמו כן, גם אם יימצאו טיפולים תרופתיים יעילים, בעיית המוטיבציה הנמוכה של אנשים אלה ליטול את התרופות שנרשמו להם – תיוותר בעינה (Markovitz, 2001).

טיפולים קוגניטיביים-התנהגותיים נחשבו להבטחה הגדולה ביותר (Hare et al., 2012; Harris & Rice, 2006). ישנם כמה יעדים משותפים להתערבויות אלה: 1. הגברת השליטה העצמית, חשיבה ביקורתית עצמית והתבוננות מנקודת מבט חברתית; 2. הגברת המודעות לקורבן; 3. למידת ניהול כעסים; 4. שינוי עמדות אנטי-חברתיות; 5. גמילה מסמים. התערבויות מסוג זה מצריכות תנאים מבוקרים

שבהם המטפל יכול להעניק חיזוקים או להימנע מלתת אותם והמטופל אינו יכול לפרוש מהטיפול (למשל אשפוז או מאסר), שכן בטיפול בהתנהגות אנטי-חברתית אנו מתמודדים עם סגנון חיים כולל ולא עם כמה התנהגויות לא הסתגלויות ספציפיות (למשל Hare et al., 2012). אפילו הטובות שבתוכניות הטיפול רבות המרכיבים ברוח הקוגניטיבית-התנהגותית מחוללות בדרך כלל שינויים צנועים בלבד, אם כי יש לציין שהן יעילות קצת יותר בטיפול בעבריינים צעירים (מתבגרים) מאשר בעבריינים מבוגרים יותר, שלעיתים קרובות הם פסיכופתים קשים לכל אורך חייהם. יתרה מזו, אף שטיפולים כאלה עשויים להיות יעילים בהפחתת ההתנהגות האנטי-חברתית של האסירים כל עוד הם בבית הכלא או בסביבה סגורה אחרת, התוצאות בדרך כלל אינן מוכללות לעולם האמיתי כאשר האדם משתחרר מהכלא (Harris & Rice, 2006).

כל זה מדגיש את חשיבותה של התערבות מוקדמת. כפי שמתואר בפרק 15, ישנן כיום גישות טיפול מבוססות שאפשר להיעזר בהן עם ילדים צעירים ובני משפחותיהם. אלה מעוררות זיק של תקווה. כמו כן, למרבה המזל, הפעילות הפלילית של רבים מהפסיכופתים ומהאנשים עם האישיות האנטי-חברתית פוחתת אחרי גיל 40, אפילו ללא טיפול, כנראה בשל היחלשות הדחפים הביולוגיים, בגלל ראייה טובה יותר של ההתנהגויות המזיקות להם עצמם ובגלל השפעותיה המצטברות של ההתניה החברתית. אנשים אלה מכונים לעיתים "פסיכופתים שחוקים". אומנם אין בנמצא הרבה ראיות לסוגיה זו (Douglas et al., 2006), אך מחקר חשוב אחד התחקה אחר קבוצה של פסיכופתים במשך הרבה שנים ומצא הפחתה ברורה וחדה ברמות ההתנהגות הפלילית שלהם אחרי גיל 40. עם זאת, יותר מ-50% מכלל האנשים הללו חזרו לסורם שוב ושוב ונאסרו גם אחרי גיל 40 (Hare et al., 1988). יתרה מזו, רק הממד ההתנהגותי האנטי-חברתי של הפסיכופתיה דועך עם הגיל, ואילו הממד הרגשי והבין-אישי של האנוכיות, הקשיחות והנצלנות נותרים בעינם (Cloninger et al., 1997; Hare et al., 1999). במילים פשוטות, אישיותם של פסיכופתים יכולה להחזיק מעמד במשך שנים, אולם פעילות פלילית מצריכה אנרגיה. ולכן, ככל שפסיכופתים מתבגרים, נטייתם לעסוק בפעילויות אנטי-חברתיות הולכת ופוחתת.

שאלות חזרה



- במה נבדלות פסיכופתיה ואישיות אנטי-חברתית? מהם המאפיינים העיקריים של פסיכופתיה?
- מנו סיבות אחדות לכך שחוקרים סבורים כי פסיכופתיה היא מושג תקף יותר מאשר אישיות אנטי-חברתית.
- אילו גורמים ביולוגיים תורמים להפרעות האלה?
- מהם המאפיינים העיקריים של ההפרעות האלה מנקודת מבט התפתחותית?



סוגיות בלתי פתורות

DSM-5: כיצד אפשר לשפר את הסיווג של הפרעות-אישיות?

סוגיות כאלה הן פחות בעייתיות כאשר משתמשים בשיטת סיווג ממדית (או דירוג על פני רצף), שהרי אפשר לצפות שבקרב בני אדם יהיו הרבה דפוסים שונים של ציונים גבוהים בתת-מרכיבים שונים של תכונות שונות. כפי שכבר ציינו, תכונות האישיות המסווגות להפרעות האישיות הן ממדיות בטבען. לדוגמה, כל אדם הוא חשדן לפעמים, אך המידה שבה תכונה זו קיימת אצל אדם עם הפרעת אישיות פרנואידית היא קיצונית. שיטת סיווג ממדית מאפשרת לדרג אנשים על פי המידה שבה הם מציגים כל תת-מרכיב וכל ממד של תכונה – ולא לפי השאלה אם יש או אין להם הפרעת אישיות נתונה. כל אדם גם ידורג במספר רב של ממדים וכך דפוסים אישיים מאוד של ציונים יהיו עניין צפוי ולא בעייתי.

קיים פולמוס רציני בקרב פסיכולוגים ופסיכיאטרים בדבר הדרך המיטבית לגיבוש שיטה ממדית יותר (Clark, 2007; Livesley, 2011; Skodol et al, 2011). זה זמן רב ברור לכול שנדרשת שיטה כזו, ובכל זאת יישומה הממשי התברר כמשימה קשה מאוד. אחד האתגרים העיקריים הוא ליצור שיטת אבחון תקפה מבחינה מדעית שאינה מסובכת מדי ואינה הופכת את המחקר הרב על הקטגוריות הקיימות לחסר ערך. כפי שכבר נאמר מוקדם יותר, האפשרות שהוצע כי תיכלל ב-DSM-5 לא התקבלה. למרות הסיבות הרבות וההיגיון הרב במעבר לשיטה ממדית, מורכבות המודל שהוצע היה ללא ספק סוגיה מרכזית. כל זה מצביע על הקושי ליצור שיטת אבחון תקפה אך גם מועילה העונה על הצרכים השונים של מטפלים ושל חוקרים כאחד.

קריאת פרק זה סייעה לכם להבין חלק מהקשיים הקשורים למערכת אבחון קטגורית לגמרי של הפרעות אישיות. למשל, ייתכן שנתקלתם בקושי לראות תמונה ברורה של כל אחת מהפרעות האישיות ושל הייחוד שלה. אפשר גם שזיהיתם שהמאפיינים והתכונות של מקצת ההפרעות, למשל הפרעת אישיות סכיזואידית, נראים כאילו התמזגו עם אלה של הפרעות אחרות, למשל הפרעת אישיות סכיזופרנית או נמנעת. כמו כן, לעיתים קרובות קורה שהאדם אינו מתאים במדויק לשום קטגוריה אבחונית ספציפית. הוא גם עשוי להתאים לאבחנות של יותר מהפרעת אישיות אחת (למשל Clark, 2007; Grant, Stinson et al., 2005; Widiger et al., 1991). ואכן, אבחנה שכיחה היא "הפרעת אישיות שאינה מוגדרת אחרת" (למשל Verheul, & Krueger & Eaton, 2010; Widiger, 2004; Verheul et al., 2007), שזו קטגוריה השמורה לאנשים עם מאפיינים של כמה קטגוריות שונות אך שאינם מתאימים בבירור לאף אחת מהן.

בעבר נערכו מחקרים רבים על הקטגוריות השונות של הפרעות אישיות בניסיון למצוא נקודות חיתוך שבהן התנהגות נורמלית מובחנת מהתנהגות פתולוגית באופן ברור ביותר. אך לא נמצאו נקודות כאלה (Livesley, 2001; Widiger & Sanderson, 1995). יתרה מזו, שינויים בנקודות החיתוך או בסף הנדרש לאבחנת הפרעות אישיות עשויים להשפיע באופן דרסטי ובלתי מקובל על שיעורי התפוצה הידועים של אבחנת הפרעת אישיות מסוימת (Widiger & Trull, 2007). לדוגמה, עם העדכון של DSM-III ופרסומו של DSM-III-R, התברר כי שיעור הפרעת האישיות הסכיזואידית גדל ב-80% ושיעור הפרעת האישיות הנרקסיסטית גדל ב-350% (Morey, 1988).

סיכום

יעד לימוד 10.1 לתאר את המאפיינים הכלליים של הפרעות אישיות.

- לאנשים עם הפרעת אישיות יש תכונות נוקשות ולא הסתגלותיות שהן עמוקות ויציבות. הדרך שבה הם תופסים דברים, חושבים ומתנהגים פוגעת ביכולתם לתפקד ביעילות ולהתייחס לבני אדם אחרים ולסביבה. יש להם קשיים כרוניים ביחסים בין-אישיים ובעיות בזהות או בתחושת העצמי והם אינם מסוגלים לתפקד בצורה הסתגלותית.
- אנשים עם הפרעות אישיות קלות עשויים לתפקד כהלכה, אך אנשים אחרים יתארו אותם כקשים, כמרוכזים בעצמם וכאנשים שנדרש מאמץ רב כדי להכיר אותם. בקצה השני של קשת החומרה, אנשים רבים עם אישיות אנטי-חברתית מגיעים בסופו של דבר לכלא.
- ב-DSM מתוארים שלושה אשכולות של הפרעות אישיות (אשכולות A, B ו-C), אם כי יותר ויותר חוקרים מטילים ספק בדבר תקפותם של אשכולות אלה.
- אי-שם בין 10% ל-12% מן האוכלוסייה הכללית עונים כפי הנראה על הקריטריונים להפרעת אישיות אחת לפחות.

יעד לימוד 10.2 לסכם את האתגרים שבעריכת מחקר על הפרעות אישיות.

- גם עם ראיונות מובנים, מהימנות האבחון של הפרעות אישיות היא ברוב המקרים פחות מאידיאלית. הסיבה היא שרבים מהתסמינים של הפרעות אישיות ספציפיות אינם מוגדרים הגדרה חדשה. שיפוט רב נדרש כדי לדעת אם התנהגותו של אדם עונה על התקן בכל מקרה ומקרה.
- מגוון ראיונות וכלי מדידה לדיווח עצמי יכולים לשמש להערכת אישיות והפרעות אישיות. לא תמיד יש התאמה רבה בין אבחנה הנעשית באמצעות כלי אחד לבין זו הנעשית בכלי אחר.
- ייתכן כי סיווג הפרעות אישיות על פי קטגוריות אינו הגישה הטובה ביותר. רוב החוקרים מסכימים כיום כי לשיטת הסיווג הממדית להערכת הפרעות אישיות יש יתרונות רבים וכי עדיף להשתמש בה.
- קביעת הסיבות להפרעות אישיות היא משימה קשה מכיוון שרוב המחקרים שנערכו עד כה הם מחקרים רטרוספקטיביים.
- רוב האנשים הלוקים בהפרעת אישיות אחת לוקים בהפרעת אישיות נוספת אחת לפחות. עובדה זו מסבכת את המחקר.

יעד לימוד 10.3 למנות את שלוש הפרעות האישיות באשכול A ולתאר את המאפיינים הקליניים העיקריים של כל אחת מהן.

- הפרעות האישיות באשכול A הן פרנואידית, סכיזואידית וסכיזופרנית. הלוקים בהפרעות מאשכול A נראים מוזרים ומשונים.
- הפרעת אישיות פרנואידית מאופיינת בחשדנות ובחוסר אמון באחרים. היא שכיחה בקרב גברים ובקרב נשים באותה מידה, ותפוצתה היא בין 1% ל-2%. לא ידוע הרבה על הסיבות להפרעת אישיות פרנואידית, אולם ידוע כי אנשים עם הפרעה זו נמצאים בסיכון מוגבר לסכיזופרניה.
- אנשים עם הפרעת אישיות סכיזואידית מגלים מעט מאוד עניין בפיתוח קשרים חברתיים. הם אינם נוטים להביע רגשות. אנשים אחרים תופסים אותם כקרים וכמרוחקים. התפוצה במהלך חיים של הפרעת אישיות סכיזואידית היא כאחוז אחד, וההפרעה שכיחה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים. לא ידוע הרבה על הסיבות להפרעת אישיות סכיזואידית, בין היתר משום שאנשים כאלה אינם מעוניינים להשתתף במחקרים.
- התפוצה במהלך חיים של הפרעת אישיות סכיזופרנית היא כאחוז אחד. סבורים שהיא שכיחה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים. אנשים עם הפרעת אישיות זו חושבים, מדברים או מתנהגים באופן מוזר. לעיתים יש להם חשיבה מאגית או שהם מבטאים אמונות מוזרות. בהפרעת אישיות סכיזופרנית, שסבורים כי היא חלק מרצף הסכיזופרניה, מעורבים גורמים גנטיים וביולוגיים.

יעד לימוד 10.4 לתאר את ארבע הפרעות האישיות באשכול B ולהסביר את המאפיינים המשותפים להן.

- אשכול B כולל את הפרעות האישיות ההיסטריונית, הנרקסיסטית, האנטי- חברתית והגבולית. הלוקים בהפרעות אלה נוטים להיות דרמטיים, רגשיים ובלתי יציבים. על הגורמים להפרעות האישיות ההיסטריונית והנרקסיסטית ידוע מעט מאוד.
- אישיות היסטריונית מאופיינת ברדיפה מוגזמת אחר תשומת לב וברמות גבוהות של מוחצנות וכן בהתנהגות תיאטרלית ולעיתים פתיינית. התפוצה במהלך חיים של ההפרעה היא מעט יותר מאחוז אחד והיא שכיחה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים. לקראת פרסומו של DSM-5, הוצע להשמיט את ההפרעה הזו מהמדריך, אך זה לא קרה. רבים תוהים אם יש לאבחנה הזו משמעות.
- הפרעת אישיות נרקסיסטית כוללת תחושה מוגזמת של חשיבות עצמית, צורך בהערצה מצד אנשים אחרים והיעדר אמפתיה לרגשות הזולת. בני אדם כאלה פועלים כאילו הם בעלי זכויות יתר. סבורים כי ההפרעה שכיחה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים ותפוצתה היא מעט יותר מאחוז אחד.

- הפרעת אישיות אנטי-חברתית מאופיינת בהתנהגות ערמומית, תוקפנית וחסרת אחריות ובחוסר התחשבות בזכויותיהם של אחרים. ההפרעה שכיחה הרבה יותר בקרב גברים (כ-3%) מאשר בקרב נשים (כ-1%). אסירים רבים לוקים בהפרעת אישיות אנטי-חברתית. שורשיה של אישיות אנטי-חברתית מצויים בילדות ותכונות אנטי-חברתיות הן כנראה תורשתיות. הרבה גורמים סביבתיים שליליים (כגון הכנסה משפחתית נמוכה, פיקוח הורי גרוע או הזנחה) מעורבים בה אף הם.
- הפרעת אישיות גבולית מאופיינת בחוסר יציבות רגשית, פחד מנטישה, אימפולסיביות, חבלה עצמית קשה ותחושת עצמי לא יציבה. מערכות היחסים של אנשים עם הפרעת אישיות גבולית הן אינטנסיביות וסוערות. התפוצה במהלך חיים של ההפרעה היא 1% עד 2%. בעבר היה נהוג לציין כי ההפרעה שכיחה יותר בקרב גברים, אולם מחקרים עדכניים מראים שהפרעת אישיות גבולית שכיחה בקרב נשים וגברים באותה מידה. גורמים סביבתיים פסיכו-חברתיים (למשל מצוקה בילדות) זוהו כגורמים המגבירים את הסיכוי להתפתחות הפרעת אישיות גבולית. נראה כי בני אדם בעלי מזג רגיש או אלה האימפולסיביים והרגשניים יותר נמצאים בסיכון הגבוה ביותר אם קיבלו טיפול לקוי בילדותם.

יעד לימוד 10.5 למנות את שלוש הפרעות האישיות באשכול C ולתאר את המאפיינים הקליניים העיקריים של כל אחת מהן.

- אשכול C כולל את הפרעות האישיות הנמנעת, התלותית והטורדנית-כפייתית. הלוקים בהפרעות אלה חווים פחד או מתח בדומה להפרעות המבוססות על חרדה.
- ילדים בעלי מזג מאופק עלולים להיות בסיכון גבוה להפרעת אישיות נמנעת. ההפרעה מאופיינת במופנמות, בחרדה חברתית וברגישות קיצונית לביקורת או לחוסר אישור מצד אחרים. הפרעת אישיות נמנעת שכיחה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים ותפוצתה היא 2% עד 3%. קיימת חפיפה גדולה בין הפרעת אישיות נמנעת לבין פוביה חברתית.
- אנשים עם הפרעת אישיות תלותית חוששים מאוד להישאר לבדם ומאמינים שהם זקוקים לאנשים אחרים שיטפלו בהם. הם מתקשים לקבל החלטות וזקוקים להרבה עידוד מצד אחרים. ההפרעה שכיחה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים ותפוצתה נמוכה מעט מאחוז אחד. בני אדם עם רמות גבוהות של נירוטיות ונועם הליכות, עם הורים סמכותניים ושמגינים יתר על המידה, עלולים להיות בסיכון הגבוה ביותר להפרעת אישיות תלותית.
- הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית כוללת דאגה מופרזת לארגון ולהישארות בשליטה. הלוקים בהפרעה זו לעיתים קרובות שואפים לשלמות ותכונה זו מפריעה ליכולתם לסיים פרויקטים. הם עשויים גם להיות נוקשים מאוד

ולהתקשות להאציל סמכויות לאחרים או להירגע בדרך כלשהי. הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית שכיחה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים ותפוצתה היא כ-2%.

יעד לימוד 10.6 להסביר את התפקידים שגורמים חברתיים-תרבותיים עשויים למלא בתפוצה של הפרעות אישיות.

- חמש תכונות האישיות הבסיסיות משותפות לכל התרבויות.
- ישנם חוקרים הסבורים כי תפוצתן של הפרעות אישיות מסוימות בארצות הברית עלתה בשנים האחרונות. ייתכן שהסיבה היא הדגש שתרבותנו שמה על סיפוק מייד, אמביציה אישית והשבר שעברו כמה מהמבנים החברתיים המסורתיים.
- הפרעות כגון הפרעת אישיות היסטריונית שכיחות פחות בתרבויות שבהן לא רואים בעין יפה משיכת תשומת לב של אדם לעצמו.

יעד לימוד 10.7 להסביר את האתגרים בטיפול בהפרעות אישיות ולסכם את הגישות שבהן משתמשים.

- ברוב המקרים, הטיפול בהפרעות אישיות אינו פשוט כלל ועיקר, בין היתר משום שבהגדרה, הן משקפות סגנונות חשיבה ודפוסי התנהגות עמוקים ומקובעים.
- רבים מהלוקים בהפרעת אישיות אינם מאמינים כי הם זקוקים לטיפול. גם הטיפול מסובך בשל העובדה שהפרעות אישיות כרוכות בדרך כלל בבעיות ביחסים בין-אישיים. בעיות אלה מגיעות עם המטופל אל מערכת היחסים עם המטפל.
- טיפולים קוגניטיביים בהפרעות אישיות מכוונים אל ליבת האמונות הדיספונקציונליות שנחשבות מרכזיות לאופן שבו אדם רואה את העולם ומתנהג בו.
- טיפול התנהגותי דיאלקטי הוא צורה יעילה של טיפול התנהגותי בהפרעת אישיות גבולית. הטיפול עוזר למטופלים ללמוד לנהל את רגשותיהם ולפתח מיומנויות התמודדות חדשות. שיטות טיפול נוספות בהפרעת אישיות גבולית שפותחו בעת האחרונה כוללות פסיכותרפיה הממוקדת בהעברה ושיטת טיפול בשם מנטליזציה. לעיתים משתמשים בטווח רחב של תרופות (תרופות נוגדות דיכאון, תרופות נוגדות פסיכოזה ותרופות מייצבות מצב רוח).

יעד לימוד 10.8 לתאר את המאפיינים הקליניים של פסיכופתיה ולהסביר את הדמיון ואת השוני בינה ובין הפרעת אישיות אנטי-חברתית.

- הדרך הטובה ביותר להסתכל על פסיכופתיה היא כהפרעה הכוללת ארבעה ממדים שונים של תכונות שאפשר לסכם בשני גורמים: 1. מערכת תכונות רגשיות-בין אישיות המשקפות היעדר חרטה או רגשי אשם, קשיחות / היעדר אמפתיה, חלקלקות / קסם אישי שטחי, הערכה עצמית מופרזת ושקרנות פתולוגית; 2. התנהגות אנטי-חברתית, אימפולסיבית וחריגה, חוסר אחריות וסגנון חיים טפילי. אדם עם אבחנה של הפרעת אישיות אנטי-חברתית מאופיין בעיקר בתכונות של סגנון חיים חריג ואנטי-חברתי (גורם 2).
- נראה כי לגנטיקה, למזג, ללמידה ולגורמים סביבתיים שליליים יש חלק חשוב בהתפתחות של פסיכופתיה והפרעת אישיות אנטי-חברתית.
- פסיכופתים מתאפיינים גם בחסרים בפחד ובחרדה ובחסרים רגשיים כלליים יותר כגון היעדר אמפתיה. כמו כן מאפיינים אותם ליקויים באזורי המוח הלימבי (אמיגדלה) והקדם-מצחי.
- הטיפול באנשים עם פסיכופתיה הוא קשה, בין השאר משום שרק לעיתים נדירות הם רואים צורך להשתנות והם נוטים להאשים אחרים בבעיותיהם. במקרים מסוימים פסיכופתים עשויים ללמוד בעת הטיפול מיומנויות חדשות המאפשרות להם לנצל אנשים אחרים אפילו טוב יותר.